Optimal Untuk Negeri

optimal

Buku Ajar

KETERAMPILAN KLINIS KEBIDANAN

PEMERIKSAAN, TINDAKAN DASAR, DAN KIE

Kristy Mellya Putri • Sri Musfiroh • Khusnul Nikmah • Nina Hidayatunnikmah

Editor: Prof. Dr. Runjati, Bdn., M.Mid.



BUKU AJAR:
KETERAMPILAN KLINIS KEBIDANAN: PEMERIKSAAN, TINDAKAN DASAR, DAN KIE

Penulis:
Kristy Mellya Putri, SST., Bdn., M.Kes
Sri Musfiroh, S.Si.T., M.Kes.
Khusnul Nikmah, SST., M.Kes.
Nina Hidayatunnikmah, S.Keb., Bd., M.Kes

Editor:
Prof. Dr. Runjati, Bdn., M.Mid.

Optimal
Untuk
Negeri

Buku Ajar: Keterampilan Klinis Kebidanan: Pemeriksaan, Tindakan Dasar, dan KIE

Penulis:
Kristy Mellya Putri, SST., Bdn., M.Kes.
Sri Musfiroh, S.Si.T., M.Kes.
Khusnul Nikmah, SST., M.Kes.
Nina Hidayatunnikmah, S.Keb., Bd., M.Kes.

Editor: Prof. Dr. Runjati, Bdn., M.Mid.

Desain Sampul: Ivan Zumarano
Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7927-20-0

Cetakan Pertama: September, 2026
Hak Cipta 2026
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Copyright © 2026
by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.
Website : optimaluntuknegeri.com
Instagram : @bimbel.optimal
Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:
PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta
Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku ajar berjudul *Keterampilan Klinis Kebidanan: Pemeriksaan, Tindakan Dasar, dan KIE* ini dapat disusun dengan baik. Buku ajar ini hadir sebagai salah satu sumber pembelajaran bagi mahasiswa kebidanan, dosen, serta praktisi kesehatan yang ingin memperkuat pemahaman dan keterampilan dasar dalam pelayanan kebidanan yang aman, profesional, dan berpusat pada pasien.

Keterampilan klinis merupakan kompetensi penting yang harus dimiliki oleh setiap tenaga kebidanan. Dalam praktik kebidanan, kemampuan melakukan pemeriksaan, tindakan dasar, komunikasi terapeutik, serta pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) sangat menentukan mutu pelayanan yang diberikan kepada perempuan, ibu, bayi, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, buku ini disusun untuk membantu pembaca memahami konsep, prinsip, serta penerapan keterampilan klinis kebidanan secara sistematis dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Buku ajar ini membahas berbagai materi pokok, meliputi konsep dasar keterampilan klinis kebidanan yang mencakup keselamatan pasien, penggunaan alat pelindung diri (APD), dan pencegahan infeksi; komunikasi terapeutik dan KIE dalam kebidanan yang menekankan teknik wawancara, empati, serta edukasi efektif; pengkajian kebidanan terpadu melalui anamnesis terfokus, pemeriksaan fisik, dan dokumentasi awal; serta pemeriksaan tanda vital dan antropometri yang mencakup teknik pelaksanaan, interpretasi hasil, dan kesalahan umum yang perlu dihindari.

Penyusunan buku ini diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran berbasis kompetensi, khususnya dalam membangun keterampilan berpikir kritis, ketelitian, komunikasi profesional, serta sikap tanggung jawab dalam praktik kebidanan. Selain itu, buku ini juga diharapkan mampu menjadi panduan dalam melatih mahasiswa agar terbiasa menerapkan prinsip keselamatan pasien, etika pelayanan, pencegahan infeksi, dan dokumentasi yang tepat sejak tahap pembelajaran klinis.

Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan di masa mendatang. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan isi, penyajian, dan manfaat buku ini bagi pembelajaran kebidanan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam proses penyusunan buku ajar ini.

Juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **iv**

BAB 1 KONSEP DASAR KETERAMPILAN KLINIS KEBIDANAN: KESELAMATAN PASIEN, APD, DAN PENCEGAHAN INFEKSI **1**

A. Keselamatan Pasien dalam Kebidanan 3

B. Sasaran Keselamatan Pasien 5

C. Identifkasi Pasien 8

D. Alat Pelindung Diri (APD) 10

E. *Hand Hygiene* 12

F. Teknik Aseptik dan Antiseptik 14

G. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) 17

H. Pengolahan Limbah Medis 19

I. K3 dalam Praktik Kebidanan 22

J. Clinical Reasoning (Berbasis Kasus) 24

K. Ringkasan Materi 36

L. Alur singkat praktik aman: 36

M. Tabel Red Flags & Eskalasi 37

N. Referensi 39

BAB 2 KOMUNIKASI TERAPEUTIK DAN KIE DALAM KEBIDANAN: TEKNIK WAWANCARA, EMPATI,DAN EDUKASI EFEKTIF **41**

A. Komunikasi Terapeutik dalam Praktik Kebidanan 44

B. Prinsip Komunikasi Terapeutik 44

C. Teknik Wawancara Klinis 45

D. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) 45

E. Teknik Edukasi Efektif 45

F. *Mini Case* 46

G. Ringkasan BAB 47

H. *Red Flag* (Hal Kritis) 47

I. Referensi 48

BAB 3 PENGKAJIAN KEBIDANAN TERPADU: ANAMNESIS TERFOKUS, PEMERIKSAAN FISIK, DAN DOKUMENTASI AWAL 49

A. Definisi 60
B. Tujuan 61
C. Indikasi 61
D. Kontraindikasi 61
E. Persiapan Alat 61
F. Langkah Tindakan 62
G. Keselamatan 62
H. Evaluasi 62
I. Dokumentasi 62
J. Aktivitas 1 — *Knows How* 63
K. Ringkasan Materi 74
L. Alur asuhan singkat 75
M. Tabel Red Flags & Eskalasi 76
N. Referensi 77

BAB 4 PEMERIKSAAN TANDA VITAL DAN ANTROPOMETRI: TEKNIK, INTERPRETASI, DAN KESALAHAN UMUM 78

A. Pemeriksaan Tanda Vital dan Antropometri: Teknik, Interpretasi, dan Kesalahan Umum 80
B. Tekanan Darah 84
C. Frekuensi dan Irama Pernapasan 92
D. Suhu Tubuh 95
E. Denyut Nadi 97
F. Referensi 98

PROFIL PENULIS 99

BAB 1

KONSEP DASAR KETERAMPILAN KLINIS KEBIDANAN: KESELAMATAN PASIEN, APD, DAN PENCEGAHAN INFEKSI

Capaian Pembelajaran

CPL yang berkontribusi

- CPL–1: Profesionalisme dan kepatuhan aspek legal
- CPL–3: Keselamatan pasien, PPI dan K3
- CPL–5: Keterampilan klinis aman dan bermutu

CPMK Utama

CPMK-1

Mahasiswa mampu menerapkan keselamatan pasien, APD, pencegahan infeksi dan K3.

Sub – CPMK

- Mahasiswa mampu menerapkan identifikasi pasien dan keselamatan prosedur
- Mahasiswa mampu menggunakan APD, hand hygiene, teknik aseptic dan pengelolaan limbah sesuai risiko

Pendahuluan

Keselamatan pasien (*patient safety)* merupakan prinsip fundamental dalam pelayanan kebidanan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya cedera atau kejadian tidak diinginkan selama proses asuhan. Menurut *World Health Organization*, keselamatan pasien mencakup upaya sistematis untuk mengurangi risiko kesalahan melalui pendekatan berbasis sistem, bukan hanya individu (WHO, 2021). Dalam kebidanan, aspek ini menjadi sangat penting karena pelayanan melibatkan dua individu sekaligus, yaitu ibu dan bayi, sehingga risiko klinis lebih kompleks dan membutuhkan standar keselamatan yang tinggi. Selain itu, keselamatan pasien juga mencakup budaya keselamatan (*safety culture*) yang menekankan komunikasi efektif, kerja tim, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, serta dokumentasi yang akurat (WHO, 2023; ICM, 2021).

Salah satu komponen utama keselamatan pasien adalah pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI). Infeksi terkait pelayanan kesehatan (*Healthcare-Associated Infections/HAIs*) masih menjadi masalah global dengan angka kejadian sekitar 7–10% pada pasien di fasilitas kesehatan, dan sebagian besar dapat dicegah (WHO, 2016; Haque et al., 2018). Dalam praktik kebidanan, PPI sangat penting terutama pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas karena infeksi dapat menyebabkan komplikasi serius seperti sepsis maternal maupun kematian neonatal. Oleh karena itu, World Health Organization merekomendasikan penerapan standar seperti kebersihan tangan, penggunaan alat steril, serta teknik aseptik dalam setiap tindakan klinis (WHO, 2018).

Praktik *hand hygiene* merupakan intervensi paling sederhana namun paling efektif dalam mencegah penularan infeksi. WHO menekankan lima momen penting hand hygiene yang harus dipatuhi tenaga kesehatan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien serta sebelum tindakan aseptik (WHO, 2009; Allegranzi & Pittet, 2009). Selain itu, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan, masker, gaun pelindung, dan pelindung mata harus disesuaikan dengan tingkat risiko paparan. Penggunaan APD yang tepat tidak hanya melindungi tenaga kesehatan, tetapi juga mencegah transmisi silang antar pasien, terutama dalam tindakan kebidanan yang melibatkan paparan cairan tubuh (WHO, 2020; CDC, 2023).

Selain aspek teknis, penerapan keselamatan pasien dan PPI juga memerlukan manajemen risiko dan pengelolaan lingkungan yang baik, termasuk pengelolaan limbah medis secara aman. Limbah infeksius dan benda tajam harus ditangani sesuai standar untuk mencegah cedera dan penularan penyakit. Secara keseluruhan, keselamatan pasien, penggunaan APD, dan pencegahan infeksi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam praktik kebidanan. Implementasi yang konsisten terhadap prinsip-prinsip ini akan meningkatkan mutu pelayanan serta melindungi ibu, bayi, dan tenaga kesehatan, sehingga menjadi kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh setiap bidan sesuai standar *International Confederation of Midwives* (ICM, 2021).

Uraian Materi

A. Keselamatan Pasien dalam Kebidanan

Keselamatan pasien (*patient safety*) merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mencegah terjadinya cedera pada pasien akibat kesalahan tindakan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan. Menurut *World Health Organization*, keselamatan pasien didefinisikan sebagai upaya untuk mengurangi risiko bahaya yang tidak perlu hingga tingkat minimum yang dapat diterima dalam pelayanan kesehatan (WHO, 2023). Konsep ini menekankan bahwa pelayanan kesehatan harus dirancang secara sistematis agar mampu meminimalkan kesalahan serta dampaknya terhadap pasien. Dalam konteks nasional, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan bahwa keselamatan pasien merupakan bagian integral dari mutu pelayanan kesehatan. Artinya, kualitas pelayanan tidak hanya diukur dari keberhasilan tindakan medis, tetapi juga dari sejauh mana pelayanan tersebut aman bagi pasien. Oleh karena itu, setiap tenaga kesehatan, termasuk bidan, wajib menerapkan prinsip keselamatan pasien dalam setiap tindakan klinis. WHO juga menegaskan bahwa kesalahan medis merupakan salah satu penyebab utama kejadian tidak diinginkan (*adverse events*) dalam pelayanan kesehatan. Secara global, sekitar 1 dari 10 pasien mengalami cedera saat menerima pelayanan kesehatan, dan lebih dari 50% kejadian tersebut sebenarnya dapat dicegah melalui sistem yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar insiden keselamatan pasien bukan disebabkan oleh individu semata, tetapi oleh kelemahan sistem pelayanan kesehatan.

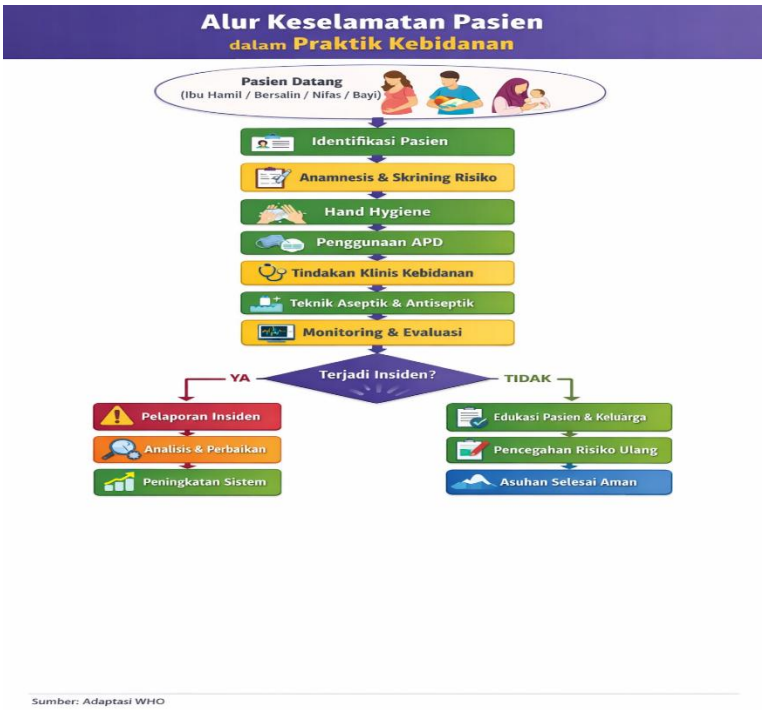
Pendekatan sistem (*system approach*) menjadi kunci utama dalam meningkatkan keselamatan pasien. WHO menekankan bahwa kesalahan sering terjadi akibat kegagalan sistem seperti kurangnya komunikasi, prosedur yang tidak jelas, atau keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, upaya peningkatan keselamatan pasien harus mencakup perbaikan sistem kerja, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta penguatan budaya keselamatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam praktik kebidanan, keselamatan pasien memiliki karakteristik khusus karena melibatkan dua individu sekaligus, yaitu ibu dan bayi. Hal ini menyebabkan risiko klinis menjadi lebih kompleks dibandingkan bidang kesehatan lainnya. Asuhan kebidanan mencakup masa kehamilan, persalinan, nifas, hingga perawatan bayi baru lahir, sehingga potensi terjadinya komplikasi harus diantisipasi melalui penerapan prinsip keselamatan pasien secara ketat. Selain ibu dan bayi, keluarga juga merupakan bagian penting dalam keselamatan pasien. WHO menekankan pentingnya keterlibatan pasien dan keluarga dalam proses perawatan sebagai

bagian dari strategi keselamatan pasien. Keterlibatan ini dapat meningkatkan kepatuhan terhadap terapi, mempercepat deteksi dini komplikasi, serta memperkuat komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien.

Salah satu aspek penting dalam keselamatan pasien adalah pencegahan infeksi yang merupakan bagian dari *Infection Prevention and Control* (IPC). Infeksi terkait pelayanan kesehatan masih menjadi masalah global dengan angka kejadian yang tinggi, bahkan WHO menyebutkan bahwa infeksi ini merupakan salah satu bentuk kejadian tidak diinginkan yang paling sering terjadi di fasilitas kesehatan . Dalam kebidanan, infeksi dapat berdampak serius baik pada ibu maupun bayi, termasuk risiko sepsis dan kematian. Penerapan keselamatan pasien dalam kebidanan juga mencakup penggunaan standar prosedur operasional (SOP), komunikasi efektif antar tenaga kesehatan, serta dokumentasi yang akurat. Budaya keselamatan (*safety culture*) harus dibangun melalui kerja tim yang baik, pelaporan insiden tanpa menyalahkan individu, serta pembelajaran berkelanjutan dari setiap kejadian yang terjadi. Selain itu, keselamatan pasien juga berkaitan erat dengan manajemen risiko dalam pelayanan kesehatan. Setiap tindakan kebidanan harus didahului dengan penilaian risiko untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi. Dengan demikian, tenaga kesehatan dapat mengambil langkah pencegahan yang tepat sebelum terjadi insiden yang merugikan pasien.

Secara keseluruhan, keselamatan pasien merupakan komponen utama dalam pelayanan kebidanan yang berkualitas. Implementasi prinsip keselamatan pasien secara konsisten akan mampu menurunkan angka kejadian tidak diinginkan, meningkatkan mutu pelayanan, serta memberikan perlindungan optimal bagi ibu, bayi, dan keluarga. Oleh karena itu, penguasaan konsep ini menjadi kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh setiap bidan dalam praktik profesionalnya.



Gambar 1.1
Alur Keselamatan Pasien dalam Praktik Kebidanan

B. Sasaran Keselamatan Pasien

Sasaran pertama keselamatan pasien adalah identifikasi pasien secara benar. Identifikasi yang tepat merupakan langkah awal untuk mencegah kesalahan dalam pemberian pelayanan kesehatan. WHO merekomendasikan penggunaan minimal dua identitas, seperti nama lengkap dan tanggal lahir atau nomor rekam medis, sebelum melakukan tindakan apa pun (WHO, 2021). Kesalahan identifikasi dapat menyebabkan salah pemberian obat, salah prosedur, hingga risiko kematian, sehingga menjadi prioritas utama dalam setiap pelayanan, termasuk dalam praktik kebidanan (Kemenkes RI, 2021).

Sasaran kedua adalah meningkatkan komunikasi yang efektif antar tenaga kesehatan. Komunikasi yang tidak efektif merupakan salah satu penyebab utama terjadinya insiden keselamatan pasien di fasilitas kesehatan. WHO menekankan pentingnya penggunaan metode komunikasi terstruktur seperti SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) untuk memastikan informasi yang disampaikan jelas, akurat, dan tepat waktu (WHO, 2023). Dalam praktik kebidanan, komunikasi efektif sangat penting terutama saat rujukan, serah terima pasien, dan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal.

Sasaran ketiga adalah meningkatkan keamanan penggunaan obat. Kesalahan dalam pemberian obat dapat berdampak serius terhadap keselamatan pasien, termasuk reaksi obat yang tidak diinginkan hingga kematian. Oleh karena itu, WHO dan berbagai literatur klinis merekomendasikan prinsip “5 benar” dalam pemberian

obat, yaitu benar pasien, obat, dosis, waktu, dan cara pemberian (WHO, 2016; Panagioti et al., 2019). Dalam kebidanan, hal ini sangat penting terutama dalam penggunaan obat-obatan seperti oksitosin dan magnesium sulfat yang memiliki risiko tinggi.

Sasaran keempat adalah memastikan prosedur yang benar pada pasien yang benar. Sasaran ini bertujuan untuk mencegah kesalahan tindakan medis, termasuk tindakan pada pasien atau lokasi yang salah. WHO menekankan pentingnya verifikasi sebelum tindakan melalui checklist keselamatan untuk memastikan kesesuaian antara pasien, prosedur, dan kondisi klinis (WHO, 2021). Dalam praktik kebidanan, hal ini mencakup konfirmasi sebelum tindakan obstetri seperti episiotomi atau intervensi lainnya.

Sasaran kelima adalah mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Infeksi nosokomial masih menjadi salah satu penyebab utama kejadian tidak diinginkan di fasilitas kesehatan. WHO menegaskan bahwa sebagian besar infeksi dapat dicegah melalui penerapan Infection Prevention and Control (IPC), seperti kebersihan tangan, penggunaan alat pelindung diri, dan teknik aseptik (WHO, 2009; Allegranzi & Pittet, 2009). Dalam kebidanan, pencegahan infeksi sangat penting untuk melindungi ibu dan bayi dari komplikasi serius seperti sepsis.

Sasaran keenam adalah mengurangi risiko cedera akibat jatuh. Pasien yang dirawat di fasilitas kesehatan memiliki risiko jatuh yang dapat menyebabkan cedera serius, memperpanjang masa perawatan, bahkan meningkatkan angka kematian. WHO menekankan pentingnya identifikasi pasien berisiko serta penerapan langkah pencegahan seperti pengawasan, edukasi, dan modifikasi lingkungan (WHO, 2021). Dalam kebidanan, pencegahan jatuh terutama penting pada ibu postpartum yang masih lemah atau dalam kondisi anemia.

Fokus utama keselamatan pasien dalam asuhan kebidanan dimulai dari identifikasi ibu dan bayi secara benar. Identifikasi merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa setiap tindakan diberikan kepada pasien yang tepat. WHO merekomendasikan penggunaan minimal dua identitas seperti nama lengkap dan tanggal lahir atau nomor rekam medis sebelum melakukan tindakan (WHO, 2021). Dalam praktik kebidanan, identifikasi menjadi sangat penting terutama pada bayi baru lahir untuk mencegah tertukarnya bayi atau kesalahan tindakan. Oleh karena itu, penggunaan gelang identitas ibu dan bayi merupakan standar pelayanan yang wajib diterapkan di fasilitas kesehatan (Kemenkes RI, 2021).

Fokus berikutnya adalah pencegahan infeksi selama proses asuhan kebidanan, khususnya pada masa persalinan dan nifas. Infeksi merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas maternal serta neonatal. WHO menegaskan bahwa sebagian besar infeksi terkait pelayanan kesehatan dapat dicegah melalui

penerapan *Infection Prevention and Control* (IPC), seperti kebersihan tangan, penggunaan alat pelindung diri, serta teknik aseptik (WHO, 2016; Allegranzi & Pittet, 2009). Dalam praktik kebidanan, penerapan hand hygiene sebelum dan sesudah tindakan serta penggunaan sarung tangan steril saat persalinan menjadi langkah utama dalam melindungi ibu dan bayi dari infeksi.

Selain itu, penerapan teknik aseptik dalam tindakan obstetri merupakan fokus penting dalam keselamatan pasien. Teknik aseptik bertujuan untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh selama prosedur klinis. WHO menekankan bahwa setiap tindakan invasif harus dilakukan dengan prinsip sterilitas yang ketat untuk mencegah komplikasi seperti sepsis (WHO, 2016). Dalam kebidanan, tindakan seperti pemeriksaan dalam, pemasangan infus, dan proses persalinan harus dilakukan dengan teknik aseptik yang benar agar risiko infeksi dapat diminimalkan.

Komunikasi efektif juga menjadi fokus utama dalam keselamatan pasien kebidanan. Kesalahan komunikasi antar tenaga kesehatan sering kali menjadi penyebab terjadinya insiden keselamatan pasien. WHO merekomendasikan penggunaan komunikasi terstruktur seperti SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation)* untuk meningkatkan kejelasan informasi (WHO, 2023). Dalam praktik kebidanan, komunikasi efektif sangat diperlukan saat rujukan, serah terima pasien, serta dalam memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga untuk mendukung keberhasilan asuhan.

Fokus lain yang tidak kalah penting adalah monitoring dan deteksi dini komplikasi pada ibu dan bayi. Pemantauan kondisi klinis secara berkelanjutan memungkinkan tenaga kesehatan untuk mengenali tanda bahaya sejak dini dan melakukan intervensi yang tepat. Menurut Kementerian Kesehatan, pemantauan tanda vital, kondisi ibu, serta kondisi bayi baru lahir merupakan bagian integral dari asuhan kebidanan yang aman (Kemenkes RI, 2021). Kegagalan dalam melakukan monitoring dapat menyebabkan keterlambatan penanganan yang berujung pada komplikasi serius.

Selain itu, keselamatan pasien dalam kebidanan juga mencakup pengelolaan risiko dan pengambilan keputusan klinis yang tepat. WHO menekankan pentingnya pendekatan berbasis risiko dalam pelayanan kesehatan untuk mencegah terjadinya insiden sebelum terjadi (WHO, 2021). Dalam praktik kebidanan, bidan harus mampu mengidentifikasi faktor risiko pada ibu hamil, bersalin, dan nifas serta menentukan tindakan yang sesuai untuk mencegah komplikasi.

Secara keseluruhan, fokus utama sasaran keselamatan pasien dalam asuhan kebidanan meliputi identifikasi pasien yang benar, pencegahan infeksi, penerapan teknik aseptik, komunikasi efektif, serta monitoring berkelanjutan. Implementasi

yang konsisten terhadap aspek-aspek tersebut akan meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan, menurunkan angka kejadian tidak diinginkan, serta memberikan perlindungan optimal bagi ibu dan bayi. Oleh karena itu, penguasaan konsep ini menjadi kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh setiap bidan sesuai standar International Confederation of Midwives (ICM, 2021).



Gambar 1.2
Fokus Keselamatan Pasien dalam Kebidanan

C. Identifkasi Pasien

Identifikasi pasien merupakan langkah fundamental dalam keselamatan pasien yang bertujuan memastikan bahwa setiap tindakan diberikan kepada individu yang tepat. Standar *World Health Organization* dan berbagai pedoman internasional merekomendasikan penggunaan minimal dua identitas unik, seperti nama lengkap dan tanggal lahir atau nomor rekam medis, sebelum melakukan tindakan klinis. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mengurangi kesalahan pelayanan karena sistem identifikasi tunggal memiliki risiko tinggi terhadap kekeliruan, terutama pada pasien dengan nama yang sama atau kondisi tidak sadar (WHO, 2021; Lippi et al., 2017) .

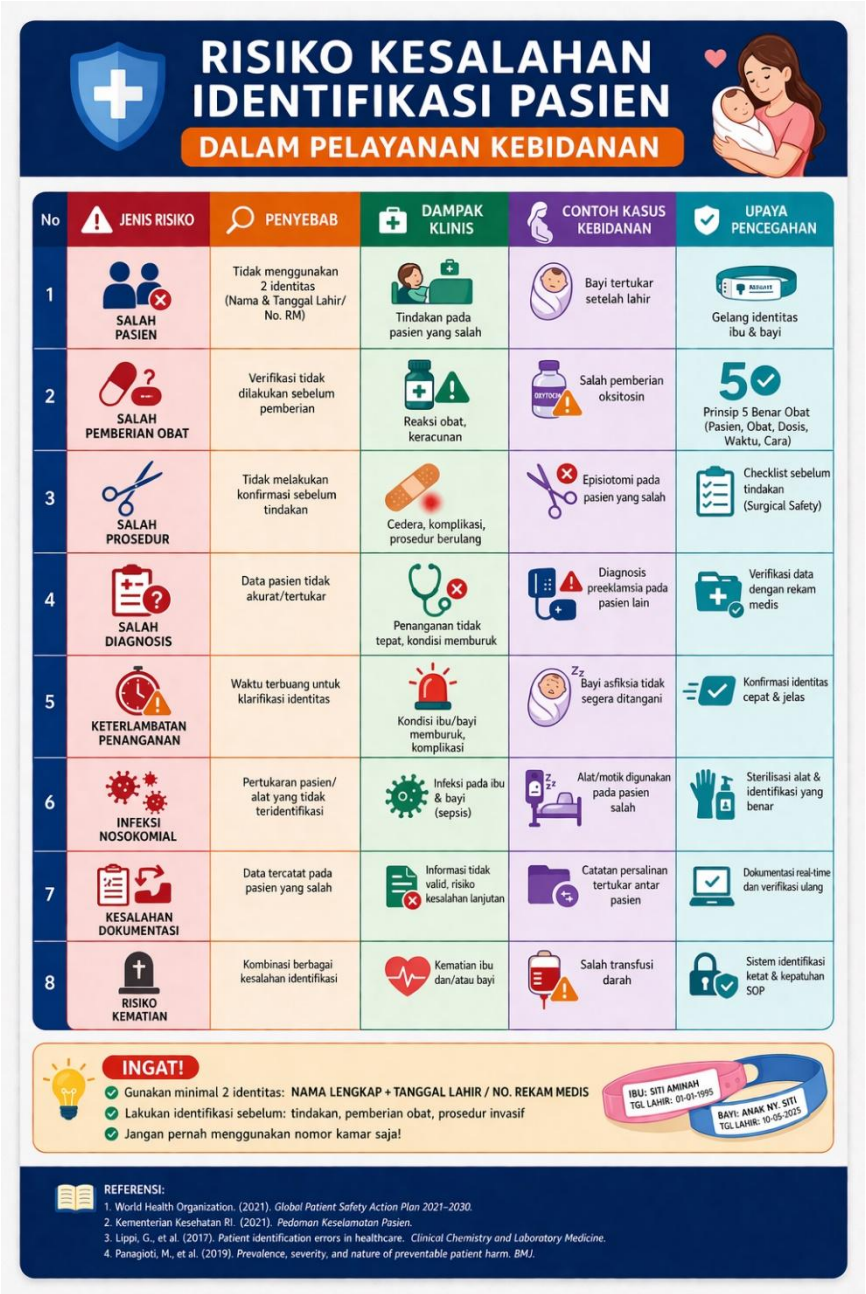
Penggunaan dua identitas pasien juga diperkuat oleh penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa kesalahan identifikasi masih menjadi masalah signifikan dalam

sistem pelayanan kesehatan. Studi dalam jurnal terindeks menyebutkan bahwa kesalahan identifikasi pasien berkontribusi langsung terhadap berbagai kejadian tidak diinginkan (*adverse events*), termasuk kesalahan pemberian obat, tindakan yang tidak perlu, hingga prosedur pada pasien yang salah (Alenazi et al., 2024) . Oleh karena itu, implementasi sistem identifikasi seperti gelang identitas dan verifikasi berulang menjadi strategi penting dalam meningkatkan keselamatan pasien.

Kesalahan identifikasi pasien dapat menyebabkan dampak serius dalam pelayanan kesehatan. Literatur menunjukkan bahwa pasien yang tertukar dapat menerima terapi yang tidak sesuai, seperti pemberian obat yang salah atau tindakan invasif yang tidak diperlukan. Bahkan, dalam beberapa kasus, kesalahan ini dapat berujung pada tindakan operasi yang salah atau komplikasi berat yang mengancam jiwa (Maul & Straub, 2022). Hal ini menegaskan bahwa identifikasi pasien bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan bagian penting dari praktik klinis yang aman.

Lebih lanjut, dampak kesalahan identifikasi tidak hanya terbatas pada kesalahan tindakan dan pemberian obat, tetapi juga dapat meningkatkan risiko kematian pasien. Studi menunjukkan bahwa sebagian kesalahan identifikasi berkontribusi terhadap kejadian fatal akibat keterlambatan atau kesalahan penanganan yang seharusnya dapat dicegah. Bahkan, sekitar 10–20% kesalahan identifikasi dalam beberapa konteks pelayanan dapat menyebabkan kerugian serius pada pasien (Lippi et al., 2017) . Dalam konteks kebidanan, kondisi ini menjadi lebih kritis karena melibatkan dua nyawa sekaligus, yaitu ibu dan bayi.

Dengan demikian, penerapan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas harus menjadi standar wajib dalam setiap tindakan kebidanan. Kepatuhan terhadap prosedur ini tidak hanya meningkatkan akurasi pelayanan, tetapi juga merupakan langkah preventif utama dalam menurunkan angka kejadian tidak diinginkan serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan.



Gambar 1.3
Risiko Kesalahan Identifikasi Pasien dalam Pelayanan Kebidanan

D. Alat Pelindung Diri (APD)

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan perlengkapan yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk melindungi diri dari paparan bahaya, terutama agen infeksius selama memberikan pelayanan. Menurut *World Health Organization*, APD adalah peralatan yang dirancang untuk mencegah atau meminimalkan paparan terhadap berbagai bahaya seperti agen biologis, kimia, maupun fisik yang dapat menyebabkan penyakit atau cedera . Dalam konteks pelayanan kesehatan, APD berfungsi sebagai penghalang (*barrier*) antara tenaga kesehatan dengan sumber

infeksi seperti darah, cairan tubuh, dan droplet, sehingga mampu menurunkan risiko penularan penyakit. Literatur terbaru juga menegaskan bahwa penggunaan APD merupakan bagian penting dari sistem Infection *Prevention and Control* (IPC) dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh kebersihan tangan dan kontrol lingkungan yang baik.

Jenis APD yang digunakan dalam pelayanan kesehatan, termasuk kebidanan, disesuaikan dengan area tubuh yang perlu dilindungi serta tingkat risiko paparan. Secara umum, APD meliputi sarung tangan, masker atau respirator, pelindung mata (goggles atau face shield), gaun pelindung, apron, serta penutup kepala dan sepatu. APD tersebut berfungsi melindungi kulit, mukosa mata, hidung, dan mulut dari kontak langsung dengan bahan infeksius. Dalam praktik kebidanan, penggunaan sarung tangan steril saat persalinan, masker untuk mencegah paparan droplet, serta pelindung tubuh seperti gaun dan apron sangat penting karena tingginya risiko paparan darah dan cairan tubuh. Penelitian dalam jurnal kesehatan menunjukkan bahwa penggunaan APD yang tepat dapat secara signifikan menurunkan risiko infeksi pada tenaga kesehatan, terutama dalam tindakan yang bersifat invasif atau kontak langsung dengan pasien (Tian et al., 2020).

Penggunaan APD harus mengikuti prinsip yang telah ditetapkan oleh *World Health Organization* dan *International Confederation of Midwives*, yaitu berdasarkan tingkat risiko paparan (*risk-based approach*). APD harus digunakan sebelum kontak dengan pasien atau lingkungan yang berpotensi terkontaminasi, serta dilepas dengan teknik yang benar (*doffing*) untuk mencegah kontaminasi diri. WHO menekankan bahwa kesalahan dalam melepas APD merupakan salah satu penyebab utama transmisi infeksi pada tenaga kesehatan . Selain itu, APD umumnya bersifat sekali pakai (*single use*) dan harus dibuang sesuai prosedur limbah medis setelah digunakan untuk mencegah penularan lebih lanjut.

Dalam praktik kebidanan, penerapan prinsip penggunaan APD menjadi sangat penting karena bidan sering terpapar cairan tubuh selama proses persalinan dan tindakan obstetri. Oleh karena itu, pemilihan APD harus sesuai dengan jenis tindakan, misalnya penggunaan sarung tangan steril dan gaun pelindung saat persalinan, serta penggunaan masker dan pelindung mata saat terdapat risiko percikan cairan tubuh. Selain itu, bidan harus memiliki kompetensi dalam teknik *donning* dan *doffing* serta memahami bahwa APD hanya efektif jika digunakan secara konsisten dan dikombinasikan dengan praktik pencegahan infeksi lainnya. Hal ini sejalan dengan standar kompetensi *International Confederation of Midwives* yang menekankan pentingnya keselamatan tenaga kesehatan dan pasien dalam setiap tindakan kebidanan.



Gambar 1.4
Alat Pelindung Diri (APD) dalam Kebidanan

E. *Hand Hygiene*

Kebersihan tangan (*hand hygiene*) merupakan intervensi paling esensial dalam pencegahan infeksi terkait pelayanan kesehatan (*Healthcare-Associated Infections/HAIs*). Berdasarkan penelitian global yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks Scopus, kepatuhan terhadap praktik *hand hygiene* terbukti secara signifikan menurunkan angka infeksi nosokomial serta meningkatkan keselamatan pasien. Studi oleh Didier Pittet dalam The Lancet menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap kebersihan tangan mampu menurunkan angka infeksi hingga lebih dari 50% di berbagai fasilitas kesehatan (Pittet et al., 2022). Hal ini menegaskan bahwa hand hygiene merupakan intervensi berbasis bukti (*evidence-based practice)* yang paling efektif, sederhana, dan ekonomis.

Konsep 5 *Moments for Hand Hygiene* yang dikembangkan oleh *World Health Organization* menjadi standar utama dalam praktik klinis. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan lima momen ini secara konsisten mampu memutus rantai transmisi mikroorganisme dari tenaga kesehatan ke pasien maupun

sebaliknya. Studi oleh Kingston et al. (2017) dalam jurnal BMJ Open menyatakan bahwa kepatuhan terhadap lima momen hand hygiene secara langsung berkorelasi dengan penurunan infeksi silang di rumah sakit. Dalam praktik kebidanan, lima momen ini sangat relevan terutama sebelum dan sesudah kontak dengan ibu dan bayi, serta sebelum tindakan aseptik seperti pemeriksaan dalam atau pertolongan persalinan.

Dari aspek metode, penggunaan *alcohol-based handrub* direkomendasikan sebagai pilihan utama karena memiliki efektivitas tinggi dalam membunuh mikroorganisme dalam waktu singkat. Penelitian oleh Allegranzi et al. dalam *Journal of Hospital Infection* menunjukkan bahwa handrub berbasis alkohol lebih efektif dibandingkan cuci tangan dengan sabun biasa dalam kondisi tangan tidak tampak kotor. Namun, pada kondisi tangan terlihat kotor atau setelah paparan cairan tubuh, metode handwash dengan sabun tetap menjadi standar utama. Kombinasi kedua metode ini menjadi strategi optimal dalam praktik klinis modern berbasis bukti.

Dalam konteks kebidanan, penelitian terbaru menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan terhadap hand hygiene masih menjadi tantangan utama di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Studi yang dipublikasikan dalam BMC Pregnancy and Childbirth menyebutkan bahwa kurangnya kepatuhan tenaga kesehatan terhadap kebersihan tangan berkontribusi terhadap meningkatnya risiko infeksi maternal dan neonatal, termasuk sepsis yang merupakan penyebab utama kematian ibu dan bayi (Storr et al., 2021). Oleh karena itu, intervensi berbasis edukasi, pelatihan, serta pengawasan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan tenaga kesehatan.

Pendekatan edukatif dan promotif yang banyak dikembangkan dalam penelitian kebidanan, termasuk yang dilakukan oleh Kristy Mellya Putri, menekankan pentingnya integrasi edukasi hand hygiene dalam pelayanan kebidanan komunitas dan klinik. Penelitian di bidang kebidanan menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan dan sikap bidan melalui pelatihan dan simulasi klinis dapat meningkatkan kepatuhan terhadap praktik hand hygiene secara signifikan. Selain itu, edukasi kepada ibu dan keluarga juga berperan penting dalam mencegah infeksi, terutama pada masa nifas dan perawatan bayi baru lahir.

Dengan demikian, *hand hygiene* bukan hanya prosedur teknis, tetapi merupakan bagian dari budaya keselamatan pasien yang harus diterapkan secara konsisten. Integrasi antara standar internasional, bukti ilmiah dari jurnal terindeks, serta pendekatan edukasi kebidanan menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan menurunkan angka infeksi maternal dan neonatal.



Gambar 1.5
Konsep 5 *Moments for Hand Hygiene* dan Pemilihan Metode *Hand Hygiene* (Standar WHO)

F. Teknik Aseptik dan Antiseptik

1. Konsep Aseptik

Aseptik merupakan prinsip dasar dalam praktik klinis yang bertujuan untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh sehingga dapat menghindari terjadinya infeksi. Secara ilmiah, aseptik diartikan sebagai kondisi bebas dari mikroorganisme patogen serta serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi tersebut selama prosedur klinis. Dalam konteks pelayanan kesehatan modern, WHO menempatkan teknik aseptik sebagai bagian penting dari *Infection Prevention and Control (IPC)* yang bertujuan memutus rantai penularan infeksi di fasilitas kesehatan.

Dalam praktik kebidanan, penerapan aseptik menjadi sangat krusial karena banyak tindakan bersifat invasif dan berisiko tinggi terhadap infeksi, seperti pemeriksaan dalam, pertolongan persalinan, serta pemasangan infus. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan teknik aseptik yang tidak optimal berhubungan signifikan dengan peningkatan risiko infeksi pada pasien, termasuk infeksi luka dan infeksi maternal . Oleh karena itu, penerapan aseptik tidak hanya mencakup penggunaan alat steril, tetapi juga meliputi kebersihan tangan,

penggunaan APD, serta pengelolaan lingkungan yang bersih dan aman. Selain itu, konsep aseptik terbagi menjadi dua, yaitu aseptik medis (mengurangi jumlah mikroorganisme) dan aseptik bedah (menghilangkan seluruh mikroorganisme). Dalam kebidanan, kedua konsep ini diterapkan secara bersamaan, terutama saat persalinan untuk mencegah infeksi maternal dan neonatal. Hal ini sejalan dengan pedoman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menekankan pentingnya praktik bersih dan aman (*clean and safe delivery*) dalam pelayanan kebidanan.

2. Konsep Antiseptik

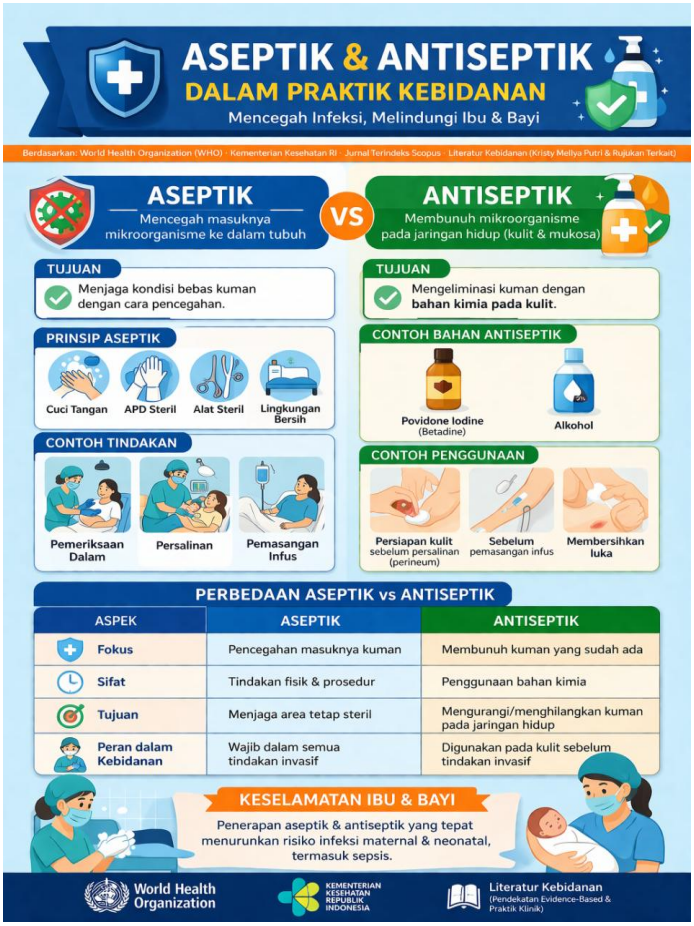
   Antiseptik merupakan penggunaan bahan kimia untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan hidup seperti kulit dan mukosa. Berbeda dengan aseptik yang bersifat pencegahan, antiseptik berfungsi langsung dalam mengeliminasi mikroorganisme yang sudah ada pada permukaan tubuh. Bahan antiseptik yang umum digunakan dalam praktik klinis meliputi *povidone iodine*, alkohol, dan *chlorhexidine*. Penelitian terindeks menunjukkan bahwa penggunaan antiseptik secara tepat sebelum tindakan invasif dapat secara signifikan menurunkan jumlah koloni bakteri dan mencegah infeksi pascatindakan. Studi eksperimental menunjukkan bahwa antiseptik seperti *chlorhexidine alkohol* dan *povidone iodine* efektif dalam menurunkan pertumbuhan bakteri pada prosedur klinis. Hal ini memperkuat pentingnya antiseptik sebagai bagian integral dari prosedur keselamatan pasien. Dalam praktik kebidanan, antiseptik digunakan pada berbagai tindakan seperti persiapan daerah perineum sebelum persalinan, pembersihan kulit sebelum pemasangan infus, serta perawatan luka. Penggunaan antiseptik harus dilakukan sesuai standar agar efektif dan tidak menimbulkan iritasi atau reaksi alergi pada pasien.

3. Hubungan Aseptik dan Antiseptik dalam Pencegahan Infeksi

   Aseptik dan antiseptik merupakan dua konsep yang berbeda namun saling melengkapi dalam pencegahan infeksi. Aseptik berfokus pada pencegahan masuknya mikroorganisme, sedangkan antiseptik bertujuan untuk membunuh mikroorganisme yang sudah ada. Literatur terbaru menegaskan bahwa kombinasi kedua prinsip ini merupakan strategi paling efektif dalam menurunkan kejadian infeksi terkait pelayanan kesehatan (*Healthcare-Associated Infections/HAIs*). Dalam kebidanan, penerapan kedua prinsip ini sangat penting karena risiko infeksi dapat berdampak langsung pada ibu dan bayi. Kegagalan dalam menerapkan teknik aseptik dan antiseptik dapat menyebabkan komplikasi serius seperti sepsis maternal dan neonatal, yang merupakan penyebab utama kematian ibu dan bayi di berbagai negara berkembang.

4. Pendekatan Praktik Kebidanan dan *Evidence-Based*

Pendekatan praktik kebidanan modern, termasuk yang dikembangkan dalam kajian akademik kebidanan seperti oleh Kristy Mellya Putri, menekankan integrasi antara teori, praktik klinis, dan edukasi masyarakat dalam pencegahan infeksi. Dalam pendekatan ini, bidan tidak hanya dituntut untuk melakukan tindakan aseptik dan antiseptik secara teknis, tetapi juga mampu memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga mengenai pentingnya kebersihan dan pencegahan infeksi. Penelitian kebidanan menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan dan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap prinsip aseptik dan antiseptik berkontribusi signifikan terhadap penurunan angka infeksi maternal dan neonatal. Oleh karena itu, penguatan kompetensi bidan melalui pelatihan, supervisi, serta penerapan standar WHO dan Kementerian Kesehatan menjadi kunci dalam meningkatkan keselamatan pasien.



Gambar 1.6
Aseptik dan Antiseptik dalam Praktik Kebidanan

G. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

1. Konsep Dasar PPI

   Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) merupakan serangkaian upaya sistematis untuk mencegah terjadinya infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan, baik pada pasien, tenaga kesehatan, maupun lingkungan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, PPI merupakan bagian integral dari mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien yang wajib diterapkan di seluruh fasilitas kesehatan (Kemenkes RI, 2021). PPI bertujuan untuk memutus rantai penularan mikroorganisme melalui pendekatan berbasis sistem, termasuk kebijakan, prosedur, dan praktik klinis yang aman.

   WHO menegaskan bahwa infeksi terkait pelayanan kesehatan (*Healthcare-Associated Infections/HAIs*) masih menjadi masalah global dengan angka kejadian sekitar 7–10% pada pasien yang dirawat di fasilitas kesehatan. Sebagian besar infeksi tersebut sebenarnya dapat dicegah melalui penerapan PPI yang konsisten dan berbasis bukti (Allegranzi et al., 2016). Dalam kebidanan, PPI memiliki peran sangat penting karena melibatkan ibu dan bayi yang rentan terhadap infeksi, terutama pada masa persalinan dan nifas.

2. Prinsip Universal Precaution

   Salah satu prinsip utama dalam PPI adalah *universal precaution* atau kewaspadaan standar. Prinsip ini menyatakan bahwa semua pasien harus dianggap berpotensi menularkan infeksi, tanpa memandang diagnosis atau status kesehatannya. Oleh karena itu, setiap tenaga kesehatan wajib menerapkan langkah pencegahan infeksi pada setiap kontak dengan pasien. Menurut *World Health Organization*, *universal precaution* meliputi penggunaan APD, kebersihan tangan, pengelolaan limbah medis, serta pencegahan paparan terhadap darah dan cairan tubuh. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko penularan penyakit infeksi seperti HIV, hepatitis B, dan infeksi lainnya dalam pelayanan kesehatan (WHO, 2009). Dalam praktik kebidanan, prinsip ini sangat penting karena bidan sering berinteraksi dengan darah dan cairan tubuh selama proses persalinan.

3. Komponen Utama PPI

   a. Hand Hygiene

      Kebersihan tangan merupakan komponen paling penting dalam PPI. WHO menetapkan standar "5 M*oments for Hand Hygiene*" sebagai pedoman utama dalam praktik klinis. Penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hand hygiene dapat menurunkan angka infeksi nosokomial secara signifikan hingga lebih dari 50% (Pittet et al., 2022). Dalam kebidanan, hand hygiene wajib

dilakukan sebelum dan sesudah kontak dengan ibu dan bayi serta sebelum tindakan aseptik.

b. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

APD digunakan untuk melindungi tenaga kesehatan dari paparan infeksi. Pemilihan APD harus disesuaikan dengan tingkat risiko paparan. Studi menunjukkan bahwa penggunaan APD yang tepat dapat menurunkan risiko infeksi pada tenaga kesehatan secara signifikan (Chughtai et al., 2019). Dalam kebidanan, APD seperti sarung tangan, masker, dan gaun pelindung wajib digunakan saat tindakan persalinan.

c. Sterilisasi dan Disinfeksi Alat

Sterilisasi merupakan proses menghilangkan seluruh mikroorganisme termasuk spora dari alat medis. Disinfeksi digunakan untuk mengurangi jumlah mikroorganisme pada permukaan alat. WHO menekankan bahwa alat medis yang digunakan dalam tindakan invasif harus steril untuk mencegah infeksi (WHO, 2016). Dalam kebidanan, sterilisasi sangat penting pada alat persalinan dan tindakan invasif lainnya.

d. Manajemen Limbah Medis

Pengelolaan limbah medis bertujuan untuk mencegah penularan infeksi dari limbah yang terkontaminasi. Limbah medis harus dipisahkan berdasarkan jenisnya, seperti limbah infeksius, benda tajam, dan limbah non-infeksius. Kemenkes menegaskan bahwa pengelolaan limbah harus dilakukan sesuai standar untuk melindungi tenaga kesehatan, pasien, dan lingkungan (Kemenkes RI, 2021).

e. Etika Batuk (Respiratory Hygiene)

Etika batuk merupakan upaya untuk mencegah penularan infeksi melalui droplet. WHO merekomendasikan penggunaan masker, menutup mulut saat batuk atau bersin, serta menjaga jarak untuk mencegah penularan penyakit saluran pernapasan. Dalam pelayanan kebidanan, penerapan etika batuk penting untuk melindungi ibu, bayi, dan tenaga kesehatan dari infeksi respiratori.

4. Implementasi PPI dalam Kebidanan

Dalam praktik kebidanan, penerapan PPI harus dilakukan secara konsisten pada setiap tindakan, mulai dari pemeriksaan antenatal hingga perawatan bayi baru lahir. Penelitian dalam jurnal *BMC Pregnancy and Childbirth* menunjukkan bahwa penerapan PPI yang baik dapat menurunkan risiko infeksi maternal dan neonatal secara signifikan (Storr et al., 2021). Oleh karena itu, bidan harus memiliki kompetensi dalam menerapkan seluruh komponen PPI sesuai standar nasional dan internasional. Pendekatan praktik kebidanan modern, menekankan

pentingnya integrasi edukasi, praktik klinis, dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan infeksi. Edukasi kepada ibu dan keluarga menjadi bagian penting dalam menjaga kebersihan dan mencegah infeksi, terutama pada masa nifas dan perawatan bayi baru lahir.



Gambar 1.7
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dalam Praktik Kebidanan

H. Pengolahan Limbah Medis

1. Konsep Dasar Limbah Medis

Limbah medis merupakan seluruh sisa kegiatan pelayanan kesehatan yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, limbah medis harus dikelola secara khusus karena mengandung agen infeksius, bahan kimia, maupun benda tajam yang berisiko menyebabkan cedera dan penularan penyakit (Kemenkes RI, 2021). WHO juga menegaskan bahwa pengelolaan limbah medis yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko penyebaran infeksi seperti hepatitis B, hepatitis C, dan HIV pada tenaga kesehatan maupun masyarakat (WHO, 2014). Dalam praktik kebidanan, limbah medis dihasilkan dari berbagai tindakan seperti persalinan, pemasangan infus, imunisasi, serta perawatan ibu dan bayi. Oleh karena itu,

pengelolaan limbah menjadi bagian penting dari *Infection Prevention and Control (IPC)* untuk melindungi tenaga kesehatan, pasien, dan lingkungan.

2. Jenis Limbah Medis
   a. Limbah Infeksius adalah limbah yang mengandung mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan penyakit. Contohnya meliputi darah, cairan tubuh, jaringan tubuh, serta bahan yang terkontaminasi seperti kasa dan sarung tangan bekas. WHO menyatakan bahwa limbah infeksius harus ditangani secara khusus karena memiliki risiko tinggi terhadap penularan penyakit (WHO, 2014).
   b. Limbah Non – Infeksius adalah limbah yang tidak terkontaminasi bahan berbahaya atau mikroorganisme patogen, seperti kertas, plastik biasa, dan kemasan alat medis yang bersih. Meskipun tidak berbahaya, limbah ini tetap harus dipisahkan dari limbah infeksius untuk mencegah kontaminasi silang dan memudahkan proses pengolahan.
   c. Limbah Benda Tajam (*Sharp Waste*) adalah merupakan limbah yang memiliki potensi melukai dan menularkan infeksi, seperti jarum suntik, ampul, pisau bedah, dan alat tajam lainnya. Menurut WHO, limbah benda tajam merupakan salah satu jenis limbah paling berbahaya karena dapat menyebabkan cedera tusuk jarum (*needle stick injury*) yang berisiko menularkan penyakit infeksi serius (WHO, 2014).
3. Prinsip Pengolahan Limbah Medis
   a. Pemilihan Limbah (*Segregation)* harus sesuai dengan jenis dan tingkat bahayanya. Kemenkes menetapkan system kode warna untuk memudahkan identifikasi, misalnya kuning (limbah infeksius), hitam (limbah non-infeksius), *safety box* (benda tajam). Pemilahan yang terpat terbukti dapat mengurangi risiko penularan infeksi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan limbah (Chartier et al., WHO).
   b. Penggunaan *Safety Box* khusus untuk limbah benda tajam guna mencegah cedera dan kontaminasi. WHO merekomendasikan bahwa safety box harus tahan tusuk, tidak bocor, dan ditutup rapat setelah mencapai kapasitas maksimal. Penggunaan *safety box* terbukti secara signifikan menurunkan kejadian cedera tusuk jarum pada tenaga kesehatan (Auta et al., 2017).
   c. Larangan Menutup Ulang Jarum Suntik dimana menutup kembali jarum suntik (*recapping*) merupakan praktik yang sangat berbahaya karena meningkatkan risiko cedera tusuk jarum. WHO dan Kemenkes secara tegas melarang praktik ini dan merekomendasikan agar jarum langsung dibuang ke dalam safety box setelah digunakan tanpa ditutup kembali. Penelitian menunjukkan bahwa

sebagian besar kasus cedera tusuk jarum terjadi akibat praktik recapping (Auta et al., 2017).

d. Pengangkutan dan pemusnahan limbah menggunakan wadah tertutup dan diproses melalui metode yang aman seperti insinerasi atau autoklaf. Kemenkes menekankan bahwa pengelolaan limbah harus sesuai standar untuk mencegah pencemaran lingkungan dan penularan penyakit.

4. Dampak Kesalahan Pengelolaan Limbah

Kesalahan dalam pengelolaan limbah medis dapat menyebabkan berbagai dampak serius, antara lain infeksi pada tenaga kesehatan akibat cedera benda tajam, penularan penyakit pada masyarakat, pencemaran lingkungan dan risiko hukum bagi fasilitas kesehatan. Studi dalam jurnal *Journal of Environmental Health* menunjukkan bahwa pengelolaan limbah yang buruk berkontribusi terhadap meningkatnya angka infeksi dan pencemaran lingkungan di berbagai negara berkembang.

5. Implementasi dalam Praktik Kebidanan

Dalam praktik kebidanan, pengelolaan limbah harus dilakukan secara konsisten pada setiap tindakan. Bidan harus mampu:

a. Memilah limbah sesuai jenisnya
b. Menggunakan safety box dengan benar
c. Menghindari praktik berbahaya seperti recapping
d. Mengedukasi pasien dan keluarga

Pendekatan ini juga diperkuat dalam kajian kebidanan berbasis edukasi komunitas, yang menekankan pentingnya peran bidan dalam menjaga keselamatan lingkungan dan masyarakat melalui pengelolaan limbah yang benar.

Tabel 1.1
Kode Warna Pengelolaan Limbah Medis

Warna Wadah/Kantong	Jenis Limbah	Contoh Limbah	Cara Penanganan
Kuning	Limbah infeksius	Darah, cairan tubuh, kasa bekas, sarung tangan bekas	Dikemas dalam kantong kuning, diolah dengan insinerator/autoklaf
Merah	Limbah sangat infeksius / patologis	Jaringan tubuh, plasenta, organ	Dikemas khusus, dimusnahkan dengan insinerasi suhu tinggi
Hitam	Limbah non-infeksius	Kertas, plastik bersih, kemasan	Dibuang seperti limbah domestik
Safety Box (kuning keras)	Limbah benda tajam (*sharp waste*)	Jarum suntik, ampul, pisau bedah	Dibuang langsung tanpa ditutup

			ulang, wadah tahan tusuk
Coklat	Limbah farmasi/kimia	Obat kadaluarsa, sisa bahan kimia	Dikelola khusus sesuai regulasi bahan berbahaya
Ungu	Limbah sitotoksik	Obat kemoterapi	Penanganan khusus dengan standar tinggi
Biru	Limbah non-infeksius tertentu (kaca/logam)	Botol kaca, vial obat	Didaur ulang atau diproses sesuai jenis bahan

Sumber : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pengelolaan Limbah Medis* dan *World Health Organization*. (2014). *Safe Management of Wastes from Health-Care Activities*

I. K3 dalam Praktik Kebidanan

1. Konsep K3 dalam Kebidanan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan upaya sistematis untuk melindungi tenaga kesehatan dari risiko cedera dan penyakit akibat kerja selama memberikan pelayanan. Dalam kebidanan, K3 sangat penting karena bidan memiliki risiko tinggi terhadap paparan darah, cairan tubuh, serta tindakan invasif. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, K3 di fasilitas pelayanan kesehatan mencakup pencegahan kecelakaan kerja, pengendalian risiko biologis, serta perlindungan tenaga kesehatan melalui standar operasional yang ketat.

WHO juga menegaskan bahwa tenaga kesehatan merupakan kelompok berisiko tinggi terhadap paparan infeksi akibat pekerjaan, sehingga diperlukan penerapan standar keselamatan kerja berbasis *universal precaution* dan *infection control*. Dalam praktik kebidanan, penerapan K3 tidak hanya melindungi tenaga kesehatan, tetapi juga menjamin keselamatan ibu dan bayi.

2. Pencegahan Needle Stick Injury (NSI)

Needle Stick Injury (NSI) adalah cedera akibat tertusuk jarum atau benda tajam yang terkontaminasi, yang dapat menyebabkan penularan penyakit seperti Hepatitis B, Hepatitis C, dan HIV. Penelitian menunjukkan bahwa NSI merupakan salah satu kecelakaan kerja paling sering terjadi pada tenaga kesehatan. WHO melaporkan bahwa sekitar 2,5% tenaga kesehatan terpapar HIV dan hingga 40% terpapar hepatitis akibat cedera jarum suntik. Studi di Indonesia juga menunjukkan bahwa kejadian NSI masih cukup tinggi dan dipengaruhi oleh faktor seperti kepatuhan terhadap penggunaan APD, kelelahan kerja, serta kurangnya pelatihan K3. Selain dampak fisik, NSI juga dapat menimbulkan

dampak psikologis seperti kecemasan dan stres pada tenaga kesehatan. Upaya pencegahan NSI meliputi:

a. Tidak melakukan *recapping* jarum
b. Menggunakan *safety box*
c. Menggunakan APD sesuai risiko
d. Melakukan teknik kerja aman (*safe injection practice*)
e. Edukasi dan pelatihan K3 secara berkala

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan dan budaya keselamatan (*safety culture*) berhubungan signifikan dengan penurunan kejadian NS

3. Post Exposure Prophylaxis (PEP)

Post Exposure Prophylaxis (PEP) adalah tindakan pencegahan yang dilakukan setelah seseorang terpapar risiko infeksi, terutama akibat cedera jarum suntik atau kontak dengan cairan tubuh. WHO merekomendasikan bahwa PEP harus diberikan sesegera mungkin, idealnya dalam waktu kurang dari 72 jam setelah paparan. Langkah penatalaksanaan PEP meliputi:

a. Segera mencuci luka dengan sabun dan air mengalir
b. Melaporkan kejadian (incident report)
c. Evaluasi risiko paparan
d. Pemeriksaan laboratorium (HIV, HBV, HCV)
e. Pemberian terapi profilaksis sesuai indikasi
f. Monitoring lanjutan

Penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan dalam pemberian PEP dapat meningkatkan risiko infeksi, sehingga sistem pelaporan dan respons cepat sangat penting dalam sistem K3 rumah sakit. Selain itu, kepatuhan terhadap prosedur PEP masih menjadi tantangan di berbagai fasilitas kesehatan.

4. Lingkungan Kerja Aman

Lingkungan kerja yang aman merupakan komponen penting dalam K3 untuk mencegah kecelakaan dan paparan risiko. Lingkungan kerja yang aman mencakup tata ruang yang ergonomis, pencahayaan yang cukup, ventilasi yang baik, ketersediaan APD dan fasilitas kebersihan dan sistem pengelolaan limbah yang baik. Penelitian dalam jurnal keselamatan kerja menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang tidak aman berkontribusi terhadap meningkatnya kejadian kecelakaan kerja termasuk NSI. Faktor seperti kelelahan, beban kerja tinggi, dan kurangnya pengawasan juga meningkatkan risiko cedera. Dalam praktik kebidanan, lingkungan kerja yang aman sangat penting terutama di ruang bersalin, ruang tindakan, dan ruang nifas. Pengaturan alat, pencahayaan, serta

kebersihan lingkungan menjadi faktor penting dalam mencegah kesalahan dan kecelakaan kerja.

5. Pendekatan Evidence-Based dalam Kebidanan

   Pendekatan kebidanan modern, menekankan bahwa K3 tidak hanya bersifat teknis tetapi juga edukatif dan preventif. Bidan harus mampu:

   a. Mengidentifikasi risiko kerja
   b. Menerapkan prosedur keselamatan
   c. Memberikan edukasi kepada tenaga kesehatan lain dan keluarga pasien
   d. Berperan dalam menciptakan budaya keselamatan

   Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan edukasi dapat meningkatkan kepatuhan terhadap K3 serta menurunkan angka kecelakaan kerja di fasilitas kesehatan.

J. Clinical Reasoning (Berbasis Kasus)

Mini Case (Knows How Level)

Bidan Dina sedang bertugas di ruang bersalin rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan pada seorang ibu yang akan melahirkan. Sebelum memasuki ruang bersalin, ia telah mengenakan masker, sarung tangan, dan jas laboratorium sesuai protokol APD. Ia juga memeriksa kesiapan alat kesehatan yang akan digunakan, termasuk stetoskop, kain periksa, dan sarung tangan cadangan. Namun, saat memasuki ruang bersalin, ia menyadari bahwa beberapa alat yang digunakan sebelumnya belum disterilkan dengan benar. Kondisi ini membuat bidan Dina harus mengambil keputusan cepat agar prosedur pemeriksaan dan persalinan tetap aman bagi pasien.

Selain itu, lingkungan ruang bersalin terlihat ramai dengan tenaga kesehatan lain yang juga sedang menangani pasien. Bidan Dina menyadari pentingnya menjaga teknik aseptik, mencuci tangan sebelum dan sesudah prosedur, serta membuang alat sekali pakai di tempat sampah medis yang benar. Ia juga harus memastikan bahwa penggunaan APD lengkap tidak mengganggu mobilitasnya saat melakukan tindakan darurat jika diperlukan. Situasi ini menuntut bidan untuk menerapkan prinsip keselamatan pasien, pencegahan infeksi, dan penggunaan APD secara konsisten, sambil tetap memberikan pelayanan klinis yang cepat dan efektif.

Pertanyaan Diskusi

1. Sebutkan alat pelindung diri (APD) yang wajib dipakai bidan saat melakukan pemeriksaan pada pasien bersalin.
2. Apa tujuan utama pencegahan infeksi nosokomial di ruang bersalin?
3. Jelaskan mengapa penggunaan APD lengkap penting bagi keselamatan bidan dan pasien.
4. Mengapa sterilisasi alat kesehatan sangat penting sebelum digunakan pada pasien bersalin?
5. Jika bidan menemukan alat yang belum disterilkan, tindakan apa yang paling tepat dilakukan untuk mencegah infeksi tanpa menunda pemeriksaan pasien?
6. Bagaimana dampak buruk jika APD tidak digunakan secara benar selama prosedur bersalin bagi pasien dan tenaga kesehatan?
7. Seorang pasien menunjukkan tanda infeksi setelah persalinan. Bagaimana Anda menilai kemungkinan penyebabnya terkait keselamatan dan pencegahan infeksi?
8. Bagaimana bidan menilai risiko infeksi saat harus melakukan tindakan darurat dengan APD terbatas?
9. Rancang alur kerja singkat yang menjamin keselamatan pasien, penggunaan APD, dan pencegahan infeksi di ruang bersalin.
10. Gabungkan prinsip APD dan sterilisasi alat untuk membuat checklist persiapan pemeriksaan pasien bersalin.
11. Evaluasi apakah prosedur keselamatan pasien yang dilakukan bidan Dina sudah memadai dan berikan saran perbaikannya.
12. Nilai efektivitas protokol pencegahan infeksi yang diterapkan di ruang bersalin dan identifikasi kelemahannya.

TEMPLATE SOAL OSCE – KESELAMATAN PASIEN, APD, DAN PENCEGAHAN INFEKSI

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Keselamatan Pasien, APD, dan Pencegahan Infeksi
3	Kasus	Bidan bertugas melakukan pemeriksaan ibu bersalin di ruang bersalin. Bidan memasuki ruang bersalin dan menemukan beberapa alat yang belum disterilkan serta lingkungan kerja terlihat ramai. Bidan harus melakukan pemeriksaan aman sambil menerapkan APD dan teknik pencegahan infeksi.
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam: 1. Persiapan dan penggunaan APD 2. Teknik aseptic 3. Pencegahan infeksi 4. Pemeriksaan fisik terfokus 5. Dukungan emosional dan KIE pasien 6. Identifikasi kebutuhan kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional
5	Kompetensi	1. Persiapan dan pemeriksaan alat 2. Penggunaan APD lengkap 3. Pencegahan infeksi 4. Pemeriksaan fisik cepat/terfokus 5. Penilaian risiko pasien 6. Komunikasi efektif dan KIE 7. Kolaborasi dan rujukan 8. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	**SKENARIO KLINIK** Bidan memasuki ruang bersalin untuk melakukan pemeriksaan ibu. Bidan menemukan alat yang belum disterilkan dan harus menilai kondisi ibu serta janin secara cepat sambil memastikan keselamatan dan pencegahan infeksi. **TUGAS** 1. Persiapkan APD sesuai protokol. 2. Cuci tangan sebelum prosedur. 3. Periksa kesiapan alat dan pastikan sterilisasi. 4. Lakukan pemeriksaan fisik terfokus (misal tanda vital, pemeriksaan perut, DJJ). 5. Berikan KIE singkat kepada pasien dan keluarga. 6. Identifikasi risiko infeksi dan kebutuhan rujukan bila ada. 7. Tampilkan perilaku profesional dan komunikasi efektif.

7	Instruksi penguji	**INSTRUKSI UMUM** 1. Pastikan identitas peserta sesuai kartu ujian. 2. Nilai peserta menggunakan: Actual mark (0–3) & Global rating (1–4). 3. Jangan melakukan interaksi selain yang diinstruksikan. **INSTRUKSI KHUSUS** 1. Penguji hanya memberikan data bila peserta meminta atau melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai. 2. Penguji memberikan skenario tambahan sesuai permintaan peserta, misal: kondisi alat, tanda vital, atau DJJ. 3. Penilaian tindakan awal mencakup persiapan APD, teknik aseptik, dan komunikasi KIE.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	**Instruksi PS :** 1. PS berperan sebagai pasien/ibu di ruang bersalin. 2. PS tampak cemas, sesekali meringis saat kontraksi. 3. PS merespons kooperatif jika peserta memberikan penjelasan atau dukungan. 4. PS mengikuti arahan peserta jika tindakan rujukan diperlukan.
9	Dialog PS	**Contoh Dialog :** Peserta: Selamat pagi/siang, Bu. PS: Pagi/siang, Bu. Peserta: Saya bidan yang akan memeriksa ibu. Apakah ibu bersedia? PS: Iya, saya bersedia. Peserta: Apakah ibu merasa nyeri atau ada keluhan lain? PS: Saya merasa mulas dan cemas, Bu. Peserta: Apakah ibu melihat cairan keluar atau perdarahan? PS: Ada sedikit lendir bercampur darah. Peserta: Saya akan menilai kondisi ibu dan janin serta memastikan keselamatan ibu dan bayi. PS: Baik, Bu, saya mengerti.
10	Kebutuhan manikin	- Phantom abdomen/manekin Leopold - Phantom panggul untuk simulasi teknik aseptik dan pemeriksaan fisik cepat
11	Kebutuhan laboran	- Menyiapkan dan merapikan alat serta manikin - Menyediakan lembar instruksi dan jawaban - Memastikan set stasiun siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1. Sarung tangan bersih 2. Masker 3. Jas laboratorium 4. Handrub 5. Phantom/manikin abdomen 6. Phantom panggul

		7. Stetoskop 8. Doppler/Pinard 9. Jam tangan/stopwatch 10. Termometer 11. Alat sterilisasi cadangan atau dummy 12. Lembar jawaban peserta 13. Pena
13	Penulis	.....
14	Referensi	1. Kementerian Kesehatan RI. Standar profesi bidan (2020). 2. Kementerian Kesehatan RI. Standar kompetensi kerja bidang kebidanan (2022). 3. WHO. Midwifery education modules (2008). 4. WHO. Intrapartum care for a positive childbirth experience (2018).

RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

Stase 1: Keselamatan Pasien, APD, dan Pencegahan Infeksi

KOMPETENSI 1: Persiapan dan Penggunaan APD

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Menyapa pasien dengan sopan dan ramah	0–3	
2. Memperkenalkan diri dan tujuan tindakan	0–3	
3. Memastikan pasien memahami prosedur dan persetujuan	0–3	
4. Menjaga privasi pasien	0–3	
5. Memakai APD lengkap sesuai protokol (masker, sarung tangan, jas, pelindung mata jika perlu)	0–3	
6. Melakukan cuci tangan/hand hygiene sebelum prosedur	0–3	
7. Menyiapkan dan memastikan alat bersih/steril sebelum digunakan	0–3	
Skoring Kompetensi 1	3 = semua 7 langkah benar 2 = 5–6 langkah benar 1 = 1–4 langkah benar 0 = tidak melakukan sama sekali	

KOMPETENSI 2: Pencegahan Infeksi dan Teknik Aseptik

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Menilai kondisi lingkungan kerja (bersih, rapi, aman)	0–3	
2. Mengatur posisi pasien yang aman (misal posisi miring kiri)	0–3	
3. Menjaga teknik aseptik selama pemeriksaan atau tindakan	0–3	
4. Menyiapkan pengangkatan/pembuangan alat sekali pakai sesuai SOP	0–3	
5. Melakukan pemantauan tanda vital/persiapan tindakan lanjutan dengan aman	0–3	
6. Meminimalkan kontak tidak perlu dengan permukaan atau benda yang tidak steril	0–3	
7. Membersihkan/mensterilkan alat setelah prosedur	0–3	
Skoring Kompetensi 2	3 = semua 7 langkah benar dan sistematis 2 = 5–6 langkah benar 1 = 1–4 langkah benar 0 = tidak melakukan atau salah semua	

KOMPETENSI 3: KIE/Konseling Pasien

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Memberi salam/sapa pasien dengan ramah	0–3	
2. Menjelaskan prosedur dan tujuan pemeriksaan/tindakan dengan bahasa sederhana	0–3	
3. Menjelaskan tindakan awal yang dilakukan dan alasan	0–3	
4. Menjelaskan pentingnya pencegahan infeksi dan penggunaan APD	0–3	
5. Memberi kesempatan bertanya kepada pasien dan menjawab dengan jelas	0–3	
6. Memberikan dukungan emosional singkat dan melibatkan keluarga/pendamping	0–3	
Skoring Kompetensi 3	3 = semua 6 langkah benar 2 = 4–5 langkah benar 1 = 1–3 langkah benar 0 = tidak melakukan	

KOMPETENSI 4: Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Melaksanakan tindakan dengan sistematis	0–3	
2. Menjaga keselamatan dan privasi pasien	0–3	
3. Memberikan perhatian pada respons pasien (nyeri, cemas)	0–3	
4. Bersikap tenang, percaya diri, suara jelas dan informatif	0–3	
5. Tidak ragu-ragu dan profesional selama prosedur	0–3	
Skoring Kompetensi 4	3 = semua 5 langkah benar 2 = 4 langkah benar 1 = 1–3 langkah benar 0 = tidak melakukan	

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4

Nilai akhir (%) = (TOTAL SKOR / 30) × 100

Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang sesuai:

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Catatan:

- Peserta lulus jika nilai akhir ≥ 70% dan kompetensi minimal pada semua domain ≥1.
- Penilaian global mempertimbangkan keseluruhan performa, perilaku, komunikasi, dan kemampuan menerapkan prinsip keselamatan serta pencegahan infeksi.

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$$

(Kota), ...

.....

Penguji :.....

Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Keselamatan Pasien, APD, dan Pencegahan Infeksi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus: Keselamatan Pasien, APD, dan Pencegahan Infeksi
Metode Penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural. Penilai mengamati tindakan peserta, lalu memberikan umpan balik segera setelah prosedur selesai. Domain yang dinilai mencakup pemakaian APD, cuci tangan, teknik aseptik, komunikasi, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan tindakan kebidanan dasar seperti pemeriksaan vital, pemasangan infus, atau prosedur laboratorium sederhana, sambil menilai penerapan APD, teknik aseptik, dan pengelolaan keselamatan pasien.
Tujuan Penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa melakukan prosedur klinis dengan aman, cepat, dan sistematis, sesuai prinsip keselamatan pasien dan pencegahan infeksi. WHO menekankan pentingnya praktik berbasis bukti (evidence-based), woman-centered, dan higienis.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang teknik kebidanan, tetapi juga kemampuan menerapkan APD, mencuci tangan, menjaga aseptik, menilai risiko infeksi, dan memberikan penjelasan KIE singkat kepada pasien.
Kasus Klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di praktik klinik yang relevan dengan capaian pembelajaran. Fokus pada prosedur kebidanan dasar dan penerapan APD serta pencegahan infeksi.	Mahasiswa diminta melakukan pemeriksaan ibu inpartu atau bayi baru lahir, memastikan lingkungan dan alat bersih/steril, memakai APD lengkap, dan menjaga keselamatan pasien saat tindakan.
Aktivitas Mahasiswa yang Diamati	Mahasiswa diamati saat melakukan prosedur klinis, bukan sekadar berdiskusi teori. Keterampilan yang relevan termasuk pemakaian APD, cuci tangan, persiapan alat, penilaian kondisi pasien, teknik aseptik, komunikasi, dan pencegahan infeksi.	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan, memakai APD lengkap, mencuci tangan sebelum dan sesudah, menyiapkan alat steril, memposisikan pasien aman, melakukan tindakan klinik dasar sesuai SOP, dan menjelaskan prosedur serta tindakan pencegahan infeksi kepada pasien.
Aspek yang Dinilai	Pemahaman indikasi tindakan, persetujuan tindakan, persiapan pra-prosedur, kemampuan teknis, komunikasi, profesionalisme, keselamatan pasien, dan penerapan pencegahan infeksi.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan prosedur kebidanan dasar dengan penerapan APD, teknik aseptik, dan langkah-langkah mencegah infeksi, sambil tetap memperhatikan kenyamanan pasien.
Fokus Observasi Pembimbing	Mutu performa nyata mahasiswa saat melakukan prosedur. WHO menekankan identifikasi risiko	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa cepat mengenali risiko infeksi, menggunakan APD lengkap,

	infeksi, penggunaan APD, teknik aseptik, dan langkah penanganan yang aman.	melakukan cuci tangan sesuai protokol, menempatkan pasien dengan aman, dan menjaga kebersihan lingkungan kerja.
Umpan Balik	Diberikan segera setelah observasi dan berisi apa yang sudah efektif serta perlu diperbaiki. Form DOPS menekankan komentar mengenai kekuatan, area perlu ditingkatkan, dan rencana perbaikan.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah tepat memakai APD dan cuci tangan, namun perlu meningkatkan ketelitian menjaga aseptik atau menjelaskan prosedur kepada pasien lebih jelas.
Keputusan Penilaian	Hasil DOPS diringkas menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Keputusan ditetapkan berdasarkan ketepatan prosedur, keselamatan pasien, komunikasi, dan penerapan pencegahan infeksi.	Mahasiswa dinyatakan **kompeten** bila mampu melakukan prosedur kebidanan dasar aman, sistematis, dan sesuai prinsip keselamatan pasien dan APD. **Perlu supervisi** bila ada langkah kecil yang kurang tepat. **Remedial** bila gagal menerapkan keselamatan pasien atau teknik aseptik.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik capaian pembelajaran karena performa diamati langsung saat tindakan klinik. Observasi langsung dan umpan balik menjadikan DOPS sesuai untuk pembelajaran berbasis kompetensi.	Mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori pencegahan infeksi dan keselamatan pasien, tetapi mampu menerapkan APD, teknik aseptik, dan tindakan klinis aman secara langsung di lahan praktik.

Tabel 1.2
Portofolio pada Konsep Dasar Keterampilan Klinis Kebidanan: Keselamatan Pasien, APD, dan Pencegahan Infeksi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus: Keselamatan Pasien, APD, dan Pencegahan Infeksi
Hakikat portofolio	Kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu.	Portofolio memuat bukti mahasiswa mampu memakai APD dengan benar, melakukan cuci tangan sesuai protokol, menyiapkan alat steril, melakukan prosedur kebidanan aman, dan memperbaiki performa berdasarkan umpan balik CI/dosen.
Tujuan portofolio	Mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa menunjukkan kemampuannya secara bertahap dalam menerapkan pencegahan infeksi, teknik aseptik, dan keselamatan pasien, bukan hanya sekali praktik.
OSCE dan DOPS	Bukti keterampilan terstruktur di laboratorium (OSCE) dan performa nyata di lahan praktik (DOPS).	OSCE memuat penilaian mahasiswa memakai APD, cuci tangan, menyiapkan alat, dan teknik aseptik. DOPS memuat observasi langsung mahasiswa melakukan tindakan kebidanan dasar pada pasien dengan menjaga keselamatan dan pencegahan infeksi.
Catatan kasus singkat	Ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, tindakan utama, dan hasil.	Mahasiswa mencatat pasien ibu bersalin, tindakan kebidanan yang dilakukan, penggunaan APD, cuci tangan, sterilisasi alat, dan tindakan pencegahan infeksi yang diterapkan.
Refleksi patient safety	Menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya cuci tangan, APD lengkap, teknik aseptik, menjaga kebersihan lingkungan, dan komunikasi yang aman dengan pasien dan keluarga.
Feedback CI/dosen	Umpan balik yang menunjukkan kekuatan mahasiswa dan area yang perlu ditingkatkan.	CI menulis bahwa mahasiswa sudah tepat dalam memakai APD dan cuci tangan, tetapi perlu lebih teliti saat menyiapkan alat steril dan menjelaskan prosedur kepada pasien.
Karakteristik penilaian	Portofolio dibangun berulang dan berkesinambungan, menekankan konsistensi performa.	Mahasiswa dinilai dari beberapa pengalaman praktik, menunjukkan kemampuan konsisten dalam keselamatan pasien, APD, dan pencegahan infeksi.
Bukti konsistensi kompetensi	Menunjukkan kemampuan mahasiswa mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik.	Dari OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat mahasiswa mampu menerapkan APD, teknik aseptik,

		dan menjaga keselamatan pasien secara konsisten.
Makna dalam OBE	Memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran terlihat dalam performa nyata, berulang, dan terdokumentasi.	Portofolio menunjukkan mahasiswa tidak hanya memahami teori keselamatan pasien dan pencegahan infeksi, tetapi juga konsisten menerapkannya di praktik klinik.

Tabel 1.3
Case Report pada Konsep Dasar Keterampilan Klinis Kebidanan: Keselamatan Pasien, APD, dan Pencegahan Infeksi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus: Keselamatan Pasien, APD, dan Pencegahan Infeksi
Hakikat case report	Laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa, menunjukkan kemampuan analisis dan dokumentasi klinis.	Mahasiswa menyusun laporan pasien bersalin atau bayi baru lahir, termasuk penggunaan APD, cuci tangan, dan tindakan pencegahan infeksi selama prosedur.
Tujuan	Menunjukkan kemampuan mahasiswa mengintegrasikan data pengkajian, masalah klinik, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil.	Mahasiswa menuliskan masalah keselamatan pasien, prosedur yang dilakukan dengan APD lengkap, cuci tangan, teknik aseptik, dan evaluasi hasil tindakan.
Isi laporan	Identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, tindakan, implementasi, evaluasi, pembelajaran.	Mahasiswa menulis prosedur kebidanan dasar yang dilakukan, cara memakai APD, cuci tangan, menyiapkan alat steril, pengawasan pasien, dan refleksi atas risiko infeksi yang berhasil dicegah.
Fokus penilaian	Ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan tindakan, kemampuan evaluasi hasil.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa menerapkan APD, cuci tangan, teknik aseptik, dan menjaga keselamatan pasien dengan benar, serta mampu mengevaluasi efektivitas tindakan.
Nilai edukatif	Membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan refleksi ilmiah.	Mahasiswa belajar bahwa APD, cuci tangan, dan teknik aseptik adalah inti keselamatan pasien dan pencegahan infeksi.
Makna dalam OBE	Menjadi bukti mahasiswa mampu menerapkan teori ke kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan kemampuan mengintegrasikan praktik kebidanan aman dengan keselamatan pasien dan pencegahan infeksi ke dalam laporan kasus.

Tabel 1.4
Refleksi Patient Safety pada Konsep Dasar Keterampilan Klinis Kebidanan: Keselamatan Pasien, APD, dan Pencegahan Infeksi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus: Keselamatan Pasien, APD, dan Pencegahan Infeksi
Hakikat refleksi patient safety	Tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya cuci tangan, APD lengkap, teknik aseptik, dan kebersihan lingkungan untuk mencegah infeksi pada pasien bersalin atau bayi baru lahir.
Tujuan	Menumbuhkan kesadaran bahwa keselamatan pasien adalah bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.	Mahasiswa menyadari bahwa kesalahan kecil seperti tidak memakai APD lengkap atau menunda cuci tangan dapat membahayakan ibu, bayi, dan petugas.
Fokus refleksi	Identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, pembelajaran yang diperoleh.	Mahasiswa menuliskan risiko kontaminasi silang, infeksi nosokomial, dan kesalahan prosedur jika APD dan aseptik tidak diterapkan dengan benar.
Risiko yang diidentifikasi	Kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang diidentifikasi antara lain paparan infeksi, alat tidak steril, kontak dengan darah/fluida tubuh, dan prosedur yang tidak aman bagi pasien.
Tindakan pencegahan	Langkah konkret untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menekankan penggunaan APD lengkap, cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan, sterilisasi alat, menjaga kebersihan lingkungan, dan komunikasi aman dengan pasien.
Pembelajaran mahasiswa	Menunjukkan apa yang dipelajari dan bagaimana akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari pentingnya konsistensi penerapan APD, cuci tangan, teknik aseptik, dan keselamatan pasien pada setiap tindakan kebidanan.
Makna dalam OBE	Bukti kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien dan praktik profesional.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan prosedur, tetapi juga mengevaluasi risiko, mencegah infeksi, dan meningkatkan kualitas praktik kebidanan secara berkelanjutan.

K. Ringkasan Materi

Keselamatan pasien merupakan prinsip utama dalam praktik kebidanan modern, mencakup identifikasi risiko, pencegahan infeksi, penggunaan alat pelindung diri (APD), dan teknik aseptik dalam setiap tindakan klinik. Bidan harus mampu menilai situasi secara cepat dan sistematis, melindungi pasien, diri sendiri, serta tim dari bahaya infeksi, dan memastikan prosedur dilakukan secara aman dan bermartabat.

Penggunaan APD yang tepat seperti sarung tangan, masker, gaun, dan pelindung mata harus disesuaikan dengan tingkat risiko tindakan. Pencucian tangan sebelum dan sesudah tindakan, teknik aseptik saat menyiapkan dan menangani alat steril, serta kebersihan lingkungan adalah langkah penting untuk mencegah infeksi nosokomial pada ibu dan bayi. Semua tindakan harus didokumentasikan secara jelas, termasuk prosedur pencegahan infeksi yang diterapkan.

Bidan juga perlu mengenali situasi yang meningkatkan risiko keselamatan pasien, seperti kontak dengan darah atau cairan tubuh, prosedur invasif, atau lingkungan yang tidak steril. Refleksi terhadap praktik setiap tindakan membantu bidan menilai risiko potensial, memperbaiki kekurangan, dan mengembangkan kebiasaan berpikir kritis untuk tindakan pencegahan di masa depan. Umpan balik dari dosen atau *Clinical Instructor* (CI) memperkuat pembelajaran, menunjukkan area yang kuat dan yang perlu ditingkatkan.

L. Alur singkat praktik aman:

Persiapan tindakan → Pakai APD lengkap → Cuci tangan → Siapkan alat steril → Lakukan tindakan klinik dengan teknik aseptik → Pantau pasien dan lingkungan → Dokumentasi lengkap → Evaluasi dan refleksi risiko → Umpan balik dan perbaikan berkelanjutan.

Pendekatan ini memastikan bahwa mahasiswa bidan tidak hanya memahami teori keselamatan pasien dan pencegahan infeksi, tetapi juga mampu menerapkannya secara konsisten di praktik klinik nyata, sejalan dengan prinsip *evidence-based, woman-centred care*, dan standar WHO untuk praktik kebidanan aman.

M. Tabel Red Flags & Eskalasi

Topik: Konsep Dasar Keterampilan Klinis Kebidanan – Keselamatan Pasien, APD, dan Pencegahan Infeksi

Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi / Rencana Tindak Lanjut
Tidak mencuci tangan sebelum dan sesudah tindakan	Risiko penularan infeksi nosokomial pada ibu, bayi, dan bidan	Segera hentikan tindakan, lakukan cuci tangan sesuai prosedur, gunakan APD lengkap, evaluasi risiko yang sudah terjadi
APD tidak digunakan atau tidak lengkap saat prosedur invasif	Peningkatan risiko kontak dengan darah atau cairan tubuh; keselamatan bidan dan pasien terancam	Hentikan tindakan sementara, kenakan APD sesuai SOP, edukasi diri dan tim, dokumentasikan insiden
Alat steril atau area kerja tidak aseptik	Potensi infeksi silang, komplikasi infeksi	Segera ganti alat, sterilkan area kerja, hentikan prosedur bila perlu, lapor ke pembimbing/DPJP, catat tindakan korektif
Kontaminasi silang (misal menyentuh alat steril dengan tangan tidak bersih)	Meningkatkan risiko infeksi nosokomial	Segera ganti alat, ulangi prosedur aseptik, evaluasi dan refleksi terhadap kesalahan, beri umpan balik tim
Pasien menunjukkan tanda infeksi atau demam setelah tindakan	Kemungkinan infeksi terkait prosedur	Pantau vital sign, beri laporan kepada DPJP, lakukan tindakan pencegahan/terapi sesuai SOP, dokumentasikan
Kebocoran atau penggunaan APD yang rusak	Tidak efektif melindungi bidan atau pasien	Segera ganti APD, hentikan sementara tindakan, pastikan standar keselamatan terpenuhi
Ketidaktepatan pembuangan limbah medis atau jarum	Risiko infeksi dan cedera occupational	Hentikan kegiatan yang salah, buang sesuai SOP, lapor ke pengawas, edukasi ulang tim
Pasien atau keluarga tidak diberi informasi tentang tindakan/risiko	Mengurangi keselamatan pasien, dapat menimbulkan stres atau kesalahan keputusan	Jelaskan prosedur dengan bahasa sederhana, dapatkan informed consent, dokumentasikan komunikasi
Lingkungan tidak bersih atau tidak siap	Meningkatkan risiko infeksi dan kecelakaan	Bersihkan lingkungan, siapkan area kerja sesuai SOP, pastikan perlengkapan siap sebelum tindakan
Terlambat mengenali tanda awal infeksi atau komplikasi	Risiko memburuknya kondisi pasien	Pantau pasien secara ketat, lapor segera ke DPJP atau pembimbing, lakukan intervensi awal sesuai kewenangan

Form Checklist "Saya sudah bisa…"

Bab: Konsep Dasar Keterampilan Klinis Kebidanan – Keselamatan Pasien, APD, dan Pencegahan Infeksi

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan prinsip keselamatan pasien dalam praktik kebidanan	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa mengenali risiko infeksi pada pasien, bidan, dan lingkungan	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa mencuci tangan sesuai prosedur WHO sebelum dan sesudah tindakan	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa menggunakan APD lengkap sesuai prosedur tindakan (masker, sarung tangan, apron/gaun, pelindung mata bila perlu)	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa menilai kebersihan dan sterilisasi alat sebelum dan sesudah prosedur	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa menyiapkan area kerja yang aseptik sebelum melakukan prosedur	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa mengenali kontaminasi silang dan langkah koreksinya	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa menyingkirkan limbah medis dan jarum secara aman sesuai SOP	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa memantau tanda infeksi pada pasien secara dini (demam, perdarahan, nyeri, tanda vital abnormal)	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa memberikan informasi dan edukasi risiko infeksi kepada pasien dan keluarga	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa menjaga keselamatan diri sendiri, pasien, dan lingkungan selama tindakan	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa menilai perlunya kolaborasi atau eskalasi bila risiko keselamatan pasien tinggi	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa mendokumentasikan tindakan, pemakaian APD, dan langkah pencegahan infeksi dengan tepat	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa merefleksikan pengalaman praktik untuk memperbaiki keselamatan pasien dan pencegahan infeksi	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

N. Referensi

Allegranzi, B., & Nejad, S. B., Combescure, C., Graafmans, W., Attar, H., Donaldson, L., & Pittet, D. (2016). Burden of endemic healthcare-associated infection in developing countries: Systematic review and meta-analysis. *Lancet, 377*(9761), 228–241. Available from: https://www.internationalmidwives.org/wp-content/uploads/EN_ICM-Essential-Competencies-for-Midwifery-Practice-1.pdf

Allegranzi, B., & Pittet, D. (2009). Role of hand hygiene in healthcare-associated infection prevention. *J Hosp Infect, 73*(4), 305–315. Available from: https://www.internationalmidwives.org/wp-content/uploads/EN_ICM-Essential-Competencies-for-Midwifery-Practice-1.pdf

Auta, A., Adewuyi, E. O., Tor-Anyiin, A., Aziz, D., Ogbole, E., & Adeleke, L. (2017). Healthcare waste management in developing countries: A review of current practices and challenges. *Waste Manag Res, 35*(6), 581–592. Available from: https://internationalmidwives.org/resources/essential-competencies-for-midwifery-practice

Chughtai, A. A., Seale, H., & MacIntyre, C. R. (2019). Effectiveness of cloth masks for protection against severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. *Emerg Infect Dis, 26*(10), 2192–2200. Available from: https://internationalmidwives.org/resources/essential-competencies-for-midwifery-practice

Haque, M., Sartelli, M., McKimm, J., & Bakar, M. A. (2018). Health care-associated infections – an overview. *Infect Drug Resist, 11*, 2321–2333.

International Confederation of Midwives (ICM). (2024). *Essential Competencies for Midwifery Practice*. The Hague: ICM. Available from: https://www.internationalmidwives.org/wp-content/uploads/EN_ICM-Essential-Competencies-for-Midwifery-Practice-1.pdf

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Panduan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan*. Jakarta: Kemenkes RI.

Kingston, L., O'Connell, N. H., Dunne, C. P., & Kearney, P. M. (2017). Hand hygiene-related knowledge, attitudes and practices among healthcare workers: A cross-sectional study in a tertiary hospital in Ireland. *BMJ Open, 7*, e016823. Available from: https://internationalmidwives.org/resources/using-the-competencies-in-a-midwifery-curriculum

Panagioti, M., Khan, K., Keers, R. N., Abuzour, A., Phipps, D., Kontopantelis, E., et al. (2019). Prevalence, severity, and nature of preventable patient harm across medical care settings: Systematic review and meta-analysis. *BMJ, 366*, l4185.

Pittet, D., Allegranzi, B., Sax, H., Dharan, S., Pessoa-Silva, C. L., Donaldson, L., & Boyce, J. (2022). Evidence-based model for hand transmission during patient care and the role of improved practices. *Lancet Infect Dis, 22*(4), 501–511. Available from: https://internationalmidwives.org/resources/essential-competencies-for-midwifery-practice

Storr, J., Kilpatrick, C., Vassallo, A., & Pittet, D. (2021). WHO guidelines on hand hygiene in health care and maternal-child health: A review of implementation and outcomes. *BMC Pregnancy Childbirth, 21*, 456. Available from: https://internationalmidwives.org/resources/using-the-competencies-in-a-midwifery-curriculum

Tian, M., Rong, X., & Wang, H. (2020). Personal protective equipment use and infection prevention in maternal healthcare settings. *Infect Control Hosp Epidemiol, 41*(7), 791–798.

World Health Organization. (2009). *WHO guidelines on hand hygiene in health care: First global patient safety challenge—Clean care is safer care*. Geneva: WHO. Available from: https://www.internationalmidwives.org/wp-content/uploads/EN_ICM-Essential-Competencies-for-Midwifery-Practice-1.pdf

World Health Organization. (2014). *Safe management of wastes from health-care activities* (2nd ed.). Geneva: WHO. Available from: https://www.internationalmidwives.org/wp-content/uploads/EN_ICM-Essential-Competencies-for-Midwifery-Practice-1.pdf

World Health Organization. (2016). *Infection prevention and control of epidemic- and pandemic-prone acute respiratory infections in health care*. Geneva: WHO. Available from: https://www.internationalmidwives.org/wp-content/uploads/EN_ICM-Essential-Competencies-for-Midwifery-Practice-1.pdf

World Health Organization. (2018). *Aseptic technique for safe childbirth*. Geneva: WHO. Available from: https://www.internationalmidwives.org/wp-content/uploads/EN_ICM-Essential-Competencies-for-Midwifery-Practice-1.pdf

World Health Organization. (2021). *Patient safety: Global action on patient safety 2021–2030*. Geneva: WHO. Available from: https://www.internationalmidwives.org/wp-content/uploads/EN_ICM-Essential-Competencies-for-Midwifery-Practice-1.pdf

World Health Organization. (2023). *World Patient Safety Day 2023: Building a culture of safety*. Geneva: WHO. Available from: https://www.internationalmidwives.org/wp-content/uploads/EN_ICM-Essential-Competencies-for-Midwifery-Practice-1.pdf

BAB 2

KOMUNIKASI TERAPEUTIK DAN KIE DALAM KEBIDANAN: TEKNIK WAWANCARA, EMPATI,DAN EDUKASI EFEKTIF

Capaian Pembelajaran Lulusan

CPL	Rumusan CPL
CPL 1 (Sikap)	Menunjukkan sikap profesional, empati, menghargai martabat manusia, menjaga kerahasiaan informasi klien, serta bertanggung jawab dalam praktik kebidanan.
CPL 2 (Pengetahuan)	Menguasai konsep teoritis komunikasi efektif, komunikasi terapeutik, wawancara klinis, konseling, KIE, promosi kesehatan, dan edukasi kesehatan dalam pelayanan kebidanan.
CPL 3 (Keterampilan Khusus)	Mampu menerapkan komunikasi terapeutik, melakukan wawancara klinis, memberikan KIE, serta mengembangkan promosi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan perempuan pada setiap siklus reproduksi.
CPL 4 (Keterampilan Umum)	Mampu berpikir logis, kritis, sistematis, melakukan refleksi praktik komunikasi, serta mendokumentasikan hasil komunikasi dan edukasi kesehatan secara tepat dan etis.

CPMK

CPMK	Rumusan CPMK	Sub-CPMK
CPMK 1	Menganalisis konsep komunikasi terapeutik dalam praktik kebidanan sebagai dasar hubungan profesional bidan-klien.	1. Menjelaskan definisi, tujuan, dan manfaat komunikasi terapeutik dalam kebidanan.
		2. Mengidentifikasi prinsip-prinsip komunikasi terapeutik dalam pelayanan kebidanan.
		3. Menganalisis peran komunikasi terapeutik dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan.
CPMK 2	Menerapkan teknik wawancara klinis untuk memperoleh data kesehatan klien secara efektif, akurat, dan berpusat pada klien.	1. Mengidentifikasi tahapan wawancara klinis dalam praktik kebidanan.
		2. Menerapkan teknik bertanya efektif, active listening, klarifikasi, dan observasi non-verbal.
		3. Melaksanakan wawancara klinis sesuai standar komunikasi profesional.
CPMK 3	Menganalisis konsep Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) sebagai upaya peningkatan literasi dan perilaku kesehatan klien.	1. Menjelaskan konsep, tujuan, dan manfaat KIE dalam pelayanan kebidanan.
		2. Mengidentifikasi kebutuhan edukasi kesehatan pada perempuan di berbagai siklus reproduksi.
		3. Menganalisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan KIE.
CPMK 4	Melaksanakan edukasi kesehatan dan KIE secara efektif menggunakan pendekatan komunikasi yang sesuai dengan karakteristik klien dan keluarga.	1. Menerapkan teknik edukasi efektif (teach-back method).
		2. Memilih media edukasi yang sesuai dengan kebutuhan klien.
		3. Melibatkan keluarga dalam proses edukasi dan pengambilan keputusan kesehatan.
		4. Menyampaikan informasi kesehatan menggunakan bahasa yang mudah dipahami klien.
CPMK 5	Mendemonstrasikan komunikasi terapeutik dan KIE dalam penyelesaian	1. Menunjukkan empati dalam interaksi dengan klien.

	kasus kebidanan secara profesional, etis, dan berbasis kebutuhan klien.	
		2. Melakukan komunikasi terapeutik pada kasus kebidanan sederhana.
		3. Memberikan edukasi kesehatan sesuai kebutuhan klien.
		4. Mengevaluasi keberhasilan komunikasi dan pemahaman klien.
		5. Mendokumentasikan hasil komunikasi dan KIE sesuai standar pelayanan kebidanan.

A. Komunikasi Terapeutik dalam Praktik Kebidanan

1. Definisi

   Komunikasi terapeutik adalah komunikasi profesional yang direncanakan secara sadar dengan tujuan membantu klien mencapai kondisi kesehatan optimal melalui hubungan interpersonal yang efektif (Arnold & Boggs, 2020).

   Dalam kebidanan, komunikasi terapeutik mencakup:

   a. empati,
   b. kejujuran,
   c. penerimaan tanpa menghakimi,
   d. serta penghargaan terhadap nilai dan budaya klien.

   Komunikasi ini sejalan dengan konsep Respectful Maternity Care (RMC) yang menekankan pelayanan bermartabat dan bebas diskriminasi (WHO, 2018).

2. Tujuan

   Komunikasi terapeutik bertujuan untuk:

   a. Membangun hubungan saling percaya
   b. Mengurangi kecemasan dan ketakutan klien
   c. Menggali data kesehatan secara akurat
   d. Meningkatkan kepatuhan terhadap terapi
   e. Mendukung pengambilan keputusan yang tepat

   (Hidayat, 2021; WHO, 2022)

B. Prinsip Komunikasi Terapeutik

1. Empati

   Kemampuan memahami perasaan klien tanpa kehilangan objektivitas profesional.

2. Menghargai martabat klien

   Pelayanan tanpa diskriminasi sosial, budaya, agama.

3. Kejujuran dan transparansi

   Informasi disampaikan secara jelas dan benar.

4. Komunikasi dua arah

   Melibatkan partisipasi aktif klien.

5. Kerahasiaan (confidentiality)

   Menjaga privasi informasi pasien.

(International Confederation of Midwives, 2021)

C. Teknik Wawancara Klinis

1. Tahap Pembukaan
   a. Salam dan perkenalan
   b. Menjelaskan tujuan
   c. Menciptakan kenyamanan
   d. Menjamin privasi
2. Tahap Penggalian Informasi
   a. Pertanyaan terbuka
   b. Active listening
   c. Klarifikasi
   d. Observasi non-verbal
3. Tahap Penutupan
   a. Ringkasan hasil
   b. Validasi pemahaman
   c. Rencana tindak lanjut

(Silverman et al., 2022)

D. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

KIE adalah proses sistematis untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku kesehatan masyarakat melalui pendekatan komunikasi yang efektif (Kemenkes RI, 2020).

Tujuan KIE:

1. Meningkatkan literasi kesehatan
2. Mendorong perilaku sehat
3. Meningkatkan kesiapsiagaan komplikasi

E. Teknik Edukasi Efektif

1. Teach-back method
   Klien mengulang informasi untuk memastikan pemahaman.
2. Media edukasi
   Leaflet, video, alat peraga.
3. Pendekatan keluarga
   Melibatkan suami/keluarga dalam keputusan.
4. Bahasa sederhana
   Disesuaikan dengan tingkat pendidikan. (WHO, 2022)

F. *Mini Case*

Kasus

Seorang ibu hamil usia 28 tahun, primigravida, usia kehamilan 32 minggu, datang dengan keluhan cemas menghadapi persalinan. Ia mengatakan takut nyeri dan komplikasi.

Pertanyaan Analisis:

1. Identifikasi masalah psikologis klien
2. Teknik komunikasi apa yang digunakan?
3. Buat contoh respon terapeutik bidan

OSCE

Stasiun: Komunikasi Terapeutik

Instruksi Mahasiswa:

Lakukan komunikasi terapeutik pada ibu hamil dengan kecemasan.

Checklist Penilaian:

No	Aspek	Skor
1	Perkenalan diri	0–2
2	Empati	0–3
3	Active listening	0–3
4	Edukasi jelas	0–3
5	Penutupan	0–2

Rubrik:

1. 0 = tidak dilakukan
2. 1 = kurang tepat
3. 2 = cukup
4. 3 = sangat baik

DOPS (Direct Observation of Procedural Skills)

Kompetensi Dinilai:

1. Komunikasi interpersonal
2. Penggalian data
3. Edukasi pasien

Level Penilaian:

1. Novice
2. Advanced beginner

3. Competent
4. Proficient

Portofolio Mahasiswa
Mahasiswa wajib menyusun:
1. Refleksi praktik komunikasi
2. Studi kasus pasien
3. Dokumentasi KIE
4. Umpan balik pembimbing

G. Ringkasan BAB

Komunikasi terapeutik dan KIE merupakan kompetensi utama dalam kebidanan yang berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan pasien, serta kepuasan ibu. Keterampilan ini harus dilatih secara berkelanjutan melalui praktik klinik dan evaluasi berbasis kompetensi.

H. *Red Flag* (Hal Kritis)

1. Tidak menjaga privasi pasien
2. Komunikasi satu arah
3. Menggunakan bahasa medis yang sulit
4. Tidak empatik
5. Tidak melibatkan pasien dalam keputusan

I. Referensi

Arnold, E. C., & Boggs, K. U. (2020). Interpersonal relationships: Professional communication skills for nurses (8th ed.). Elsevier.

Hidayat, A. A. A. (2021). Metodologi penelitian kebidanan dan teknik analisis data. Salemba Medika.

International Confederation of Midwives. (2021). Essential competencies for midwifery practice. ICM.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman pelayanan kebidanan. Jakarta: Kemenkes RI.

Notoatmodjo, S. (2018). Promosi kesehatan dan perilaku kesehatan. Rineka Cipta.

Rahmawati, D. (2021). Pengaruh KIE terhadap pengetahuan ibu hamil. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 15(1), 23–30.

Silverman, J., Kurtz, S., & Draper, J. (2022). Skills for communicating with patients (4th ed.). CRC Press.

Sudarmiati, S., & Handayani, S. (2022). Efektivitas komunikasi terapeutik terhadap kecemasan ibu hamil. Jurnal Kebidanan Indonesia, 13(2), 45–52.

World Health Organization. (2018). WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience. Geneva: WHO.

World Health Organization. (2022). Family planning: A global handbook for providers (3rd ed.). Geneva: WHO.

BAB 3

PENGKAJIAN KEBIDANAN TERPADU: ANAMNESIS TERFOKUS, PEMERIKSAAN FISIK, DAN DOKUMENTASI AWAL

CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepatuhan aspek legal-budaya dalam pelayanan kebidanan.	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik, konseling, dan kolaborasi yang berpusat pada perempuan dan keluarga.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan keselamatan pasien, pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), serta K3 dalam seluruh tindakan klinis.	CPMK-1; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-7
CPL-4	Melaksanakan pengkajian, interpretasi data, dan clinical reasoning untuk menentukan asuhan, monitoring, dan rujukan.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
CPL-5	Mendemonstrasikan keterampilan pemeriksaan dan tindakan dasar kebidanan secara aman, efektif, dan bermutu.	CPMK-4; CPMK-5; CPMK-7
CPL-6	Menyusun dokumentasi klinis dan komunikasi rujukan yang akurat serta memanfaatkan standar/bukti untuk perbaikan mutu.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-6; CPMK-7

CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menerapkan prinsip keselamatan pasien, APD, pencegahan infeksi, dan K3 pada seluruh keterampilan klinis kebidanan.
CPMK-2	Melaksanakan komunikasi terapeutik dan KIE/konseling kebidanan yang empatik, terstruktur, dan sesuai kebutuhan serta literasi kesehatan.
CPMK-3	Melakukan pengkajian kebidanan terpadu melalui anamnesis terfokus, pemeriksaan fisik dasar, dan dokumentasi awal yang akurat.
CPMK-4	Melakukan pemeriksaan tanda vital dan antropometri, menginterpretasi hasil, serta mengidentifikasi kesalahan teknik dan tindak lanjut awal.
CPMK-5	Melakukan pemeriksaan obstetri intrapartum (Leopold, DJJ, dan pemeriksaan dalam aseptik) serta melaporkan kemajuan persalinan secara tepat.
CPMK-6	Menggunakan partograf untuk memantau persalinan dan mengambil keputusan praktik dasar (observasi, intervensi, rujukan) berbasis kriteria.
CPMK-7	Melaksanakan tindakan dasar asuhan kebidanan dan stabilisasi awal pada persalinan, nifas, bayi baru lahir, KB, serta rujukan aman sesuai standar.

Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Konsep Dasar Keterampilan Klinis Kebidanan: Keselamatan Pasien, APD, dan Pencegahan Infeksi	1.1 Menerapkan identifikasi pasien, keselamatan prosedur, dan pencegahan insiden pada praktik keterampilan klinis.	1.2 Menggunakan APD, hand hygiene, teknik aseptik, dan pengelolaan limbah sesuai tingkat risiko.	CPMK-1	CPMK-3; CPMK-7
Bab 2. Komunikasi Terapeutik dan KIE dalam Kebidanan: Teknik Wawancara, Empati, dan Edukasi Efektif	2.1 Melaksanakan wawancara kebidanan dengan teknik terapeutik (pertanyaan terbuka, klarifikasi, refleksi) dan empati.	2.2 Menyampaikan KIE/konseling dengan tujuan, pesan kunci, teach-back, dan dokumentasi ringkas.	CPMK-2	CPMK-3; CPMK-7
Bab 3. Pengkajian Kebidanan Terpadu:	3.1 Mengumpulkan data anamnesis terfokus berbasis keluhan utama	3.2 Melakukan pemeriksaan fisik dasar dan menulis	CPMK-3	CPMK-1; CPMK-2

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Anamnesis Terfokus, Pemeriksaan Fisik, dan Dokumentasi Awal	dan faktor risiko secara sistematis.	dokumentasi awal (format institusi) secara akurat dan tepat waktu.		
Bab 4. Pemeriksaan Tanda Vital dan Antropometri: Teknik, Interpretasi, dan Kesalahan Umum	4.1 Melakukan pengukuran tanda vital dan antropometri dengan teknik benar serta cek alat sederhana.	4.2 Menginterpretasi hasil, mengenali nilai abnormal dan kesalahan umum, serta menentukan tindak lanjut awal.	CPMK-4	CPMK-1; CPMK-3
Bab 5. Pemeriksaan Abdomen Obstetri (Leopold I–IV) dan Penilaian DJJ	5.1 Melakukan palpasi abdomen obstetri (Leopold I–IV) untuk menilai letak, posisi, presentasi, dan penurunan.	5.2 Menilai DJJ (frekuensi, irama, lokasi) serta mengomunikasikan temuan dan rencana pemantauan.	CPMK-5	CPMK-3; CPMK-4
Bab 6. Pemeriksaan Dalam dan Penilaian Kemajuan Persalinan: Indikasi, Teknik Aseptik, dan Pelaporan	6.1 Menentukan indikasi/kontraindikasi, menyiapkan informed consent, dan menjaga privasi pemeriksaan dalam.	6.2 Melakukan pemeriksaan dalam secara aseptik, menilai temuan kunci, dan mendokumentasikan pelaporan kemajuan.	CPMK-5	CPMK-1; CPMK-3
Bab 7. Penggunaan Partograf dan Pengambilan Keputusan Praktik: Kapan Observasi, Kapan Rujuk	7.1 Mengisi partograf secara benar berdasarkan data pemantauan ibu-janin dan kemajuan persalinan.	7.2 Menganalisis partograf untuk keputusan: observasi, intervensi dasar, atau rujukan sesuai kriteria.	CPMK-6	CPMK-5; CPMK-7
Bab 8. Tindakan Dasar Persalinan Aman: Pimpinan Persalinan,	8.1 Melaksanakan pimpinan persalinan kala II dengan langkah aman, komunikasi tim,	8.2 Melaksanakan AMTSL sesuai standar serta evaluasi awal	CPMK-7	CPMK-1; CPMK-6

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Perlindungan Perineum, dan AMTSL	dan perlindungan perineum.	perdarahan dan kondisi ibu.		
Bab 9. Penatalaksanaan Perdarahan Postpartum Tingkat Dasar: Masase Uterus, Kompresi, dan Oksitosin	9.1 Melakukan identifikasi dini dan penilaian cepat perdarahan postpartum tingkat dasar (tonus uterus, perdarahan, tanda syok).	9.2 Melaksanakan penatalaksanaan awal (masase uterus, kompresi sesuai kompetensi, oksitosin sesuai kewenangan) dan menyiapkan rujukan.	CPMK-7	CPMK-1; CPMK-6
Bab 10. Keterampilan Asuhan Bayi Baru Lahir: Pengeringan, IMD, Termoregulasi, dan Perawatan Tali Pusat	10.1 Melakukan asuhan segera bayi baru lahir: pengeringan, penilaian cepat, IMD, dan termoregulasi.	10.2 Melakukan perawatan tali pusat bersih serta KIE perawatan rumah dan tanda bahaya.	CPMK-7	CPMK-1; CPMK-2
Bab 11. Resusitasi Dasar Bayi Baru Lahir: Persiapan, Ventilasi, dan Evaluasi	11.1 Menyiapkan area dan alat resusitasi dasar, melakukan penilaian awal, dan menjaga termoregulasi.	11.2 Melakukan ventilasi tekanan positif, mengevaluasi respons, dan menentukan tindak lanjut/rujukan.	CPMK-7	CPMK-1; CPMK-6
Bab 12. Keterampilan Asuhan Nifas dan Menyusui: Pemeriksaan Ibu, Teknik Menyusui, dan Manajemen Masalah Umum	12.1 Melakukan pemeriksaan ibu nifas, mengenali masalah umum, serta memberikan edukasi perawatan diri.	12.2 Menilai teknik menyusui dan menangani masalah umum melalui demonstrasi dan tindak lanjut.	CPMK-7	CPMK-2; CPMK-3
Bab 13. Keterampilan Pelayanan KB: Konseling, Skrining	13.1 Melakukan konseling KB berbasis kebutuhan dan mendukung keputusan informasional.	13.2 Melakukan skrining kelayakan, merencanakan tindak lanjut, dan	CPMK-2	CPMK-3; CPMK-7

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Kelayakan, dan Tindak Lanjut Efek Samping		penanganan efek samping umum.		
Bab 14. Keterampilan Rujukan dan Transport Aman: Stabilisasi Pra-Rujukan, SBAR, dan Dokumentasi Rujukan	14.1 Melakukan stabilisasi pra-rujukan dan persiapan transport aman (prioritas ABC dasar, monitoring).	14.2 Melakukan komunikasi SBAR dan menyiapkan dokumentasi rujukan yang lengkap untuk kesinambungan informasi.	CPMK-7	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-6

Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	OSCE/simulasi PPI & keselamatan + checklist; kuis singkat PPI-K3	Kepatuhan hand hygiene & APD sesuai risiko; teknik aseptik dan pembuangan limbah tepat; identifikasi pasien & keselamatan prosedur konsisten	15	Checklist OSCE; hasil kuis; lembar observasi
CPMK-2	OSCE roleplay komunikasi & KIE + rubrik; portofolio materi edukasi	Pertanyaan terbuka & klarifikasi digunakan tepat; empati (verbal-nonverbal) konsisten; KIE terstruktur + teach-back; dokumentasi KIE ringkas dan lengkap	15	Rubrik OSCE; rekaman/video (bila ada); leaflet/skrip KIE; catatan KIE
CPMK-3	Mini-CEX/OSCE pengkajian; telaah dokumen (SOAP/format institusi)	Anamnesis terfokus relevan (keluhan, riwayat, risiko); pemeriksaan fisik sistematis; data subjektif-objektif konsisten; dokumentasi awal lengkap, terbaca, tepat waktu	15	Lembar pengkajian; SOAP/format institusi; umpan balik mini-CEX
CPMK-4	OSCE tanda vital & antropometri + checklist; kuis interpretasi	Teknik pengukuran sesuai SOP; pencatatan satuan & waktu benar; nilai abnormal/artefak dikenali;	10	Checklist OSCE; lembar hasil pengukuran; hasil kuis

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
		tindak lanjut awal/eskalasi sesuai temuan		
CPMK-5	OSCE Leopold-DJJ; OSCE pemeriksaan dalam (manekin) + checklist	Langkah Leopold I–IV benar dan interpretasi tepat; penilaian DJJ akurat; pemeriksaan dalam aseptik dan menjaga privasi; pelaporan kemajuan persalinan lengkap	15	Checklist OSCE; lembar laporan kemajuan persalinan
CPMK-6	Penugasan partograf kasus; uji tulis analisis keputusan	Partograf terisi lengkap dan konsisten dengan data; interpretasi pola (waspada/tindakan) tepat; keputusan observasi/intervensi/rujuk sesuai kriteria; alasan keputusan berbasis data	10	Partograf terisi; lembar analisis; nilai uji tulis
CPMK-7	Simulasi terpadu/OSCE multi-stasiun + checklist; logbook keterampilan; penilaian kinerja klinik	Prioritas tindakan sesuai algoritme; prosedur dilakukan aman (aseptik, alat/obat, evaluasi respons); komunikasi tim & SBAR rujukan jelas; dokumentasi tindakan/rujukan lengkap	20	Checklist simulasi/OSCE; logbook; format rujukan; catatan tindakan

Rubrik CPMK (skala 1–4)

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Kepatuhan PPI & penggunaan APD	Langkah kritis (hand hygiene/APD/aseptik) sering terlewat dan berisiko.	Langkah utama dilakukan namun tidak konsisten; ada kesalahan yang perlu koreksi segera.	Langkah lengkap dan konsisten; kesalahan minor tidak berdampak pada keamanan.	Sangat konsisten, antisipatif, menjelaskan rasional dan mengingatkan praktik aman pada tim.
1.2 Keselamatan	Identifikasi pasien/cek keselamatan tidak	Identifikasi dan cek	Identifikasi dan cek	Cek keselamatan menyeluruh,

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
prosedur & manajemen risiko	dilakukan atau salah; potensi insiden tinggi.	keselamatan dilakukan sebagian; perlu arahan untuk pencegahan insiden.	keselamatan dilakukan tepat; risiko umum diantisipasi.	proaktif mencegah insiden/near-miss dan melakukan pelaporan sesuai alur.

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Komunikasi terapeutik & empati	Tidak membangun rapport; pertanyaan menutup; respon empati tidak tampak.	Rapport terbentuk sebagian; teknik komunikasi dasar ada namun belum terarah.	Wawancara terstruktur; pertanyaan terbuka dan klarifikasi tepat; empati konsisten.	Sangat responsif, menyesuaikan gaya komunikasi dengan budaya/literasi; menjaga kenyamanan dan kepercayaan.
2.2 KIE/konseling efektif & teach-back	Pesan tidak jelas/tidak sesuai kebutuhan; tanpa verifikasi pemahaman.	Pesan cukup relevan namun struktur kurang rapi; verifikasi pemahaman terbatas.	Pesan kunci jelas, terstruktur; teach-back dilakukan; rencana tindak lanjut disepakati.	Edukasi sangat jelas, memotivasi, menggunakan media/analog sesuai; teach-back kuat dan dokumentasi sangat rapi.

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Anamnesis terfokus (kelengkapan & relevansi)	Data kunci banyak hilang/tidak relevan; alur tidak sistematis.	Data cukup terkumpul namun masih ada bagian penting yang terlewat; alur kurang rapi.	Data kunci lengkap dan relevan; alur sistematis; mampu menggali 56ensit risiko.	Penggalian sangat tajam, efisien, dan 56ensitive; mampu menautkan data ke risiko/masalah secara jelas.
3.2 Dokumentasi awal (akurasi & konsistensi)	Catatan tidak lengkap/tidak terbaca; data subjektif-objektif tidak konsisten.	Catatan cukup lengkap namun ada ketidaktepatan istilah/satuan; perlu revisi.	Catatan lengkap, terbaca, konsisten; memuat rencana awal yang logis.	Catatan sangat rapi, akurat, tepat waktu; menonjolkan prioritas dan memudahkan kesinambungan asuhan.

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Teknik pengukuran & pencatatan	Teknik salah; hasil tidak valid atau tidak dicatat dengan benar.	Teknik dasar benar namun ada kesalahan posisi/alat; pencatatan belum konsisten.	Teknik benar, hasil reliabel; pencatatan lengkap (satuan, waktu, kondisi).	Teknik sangat presisi, memverifikasi bila meragukan, dan menjaga kenyamanan serta keamanan klien.
4.2 Interpretasi hasil & tindak lanjut	Tidak mengenali nilai abnormal/artefak; tidak ada tindak lanjut.	Mengenali sebagian abnormal namun ragu menentukan tindak lanjut.	Menginterpretasi tepat; menentukan tindak lanjut awal/eskalasi sesuai temuan.	Cepat dan tepat, menjelaskan rasional, serta mengomunikasikan temuan secara jelas ke tim/klien.

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Leopold & penilaian DJJ (teknik & interpretasi)	Urutan/teknik salah; interpretasi tidak tepat; data sulit digunakan.	Teknik cukup benar namun kurang sistematis; interpretasi masih perlu koreksi.	Teknik sistematis dan nyaman; interpretasi letak/posisi/presentasi dan DJJ tepat.	Sangat terampil, efisien, dan komunikatif; mampu mengonfirmasi temuan dan menjelaskan implikasinya.
5.2 Pemeriksaan dalam aseptik & pelaporan	Aseptik/privasi tidak terjaga; temuan tidak lengkap/tidak dilaporkan benar.	Aseptik dan privasi cukup namun belum konsisten; pelaporan sebagian.	Aseptik dan privasi terjaga; temuan kunci lengkap; pelaporan jelas dan tepat.	Sangat konsisten, minim ketidaknyamanan; pelaporan ringkas-bermakna dan siap digunakan untuk keputusan.

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Pengisian partograf	Banyak kolom kosong/salah; waktu pencatatan tidak konsisten.	Terisi sebagian; ada ketidaksesuaian data dan waktu pencatatan.	Terisi lengkap, konsisten, dan tepat waktu sesuai data pemantauan.	Sangat rapi, konsisten, mampu melakukan verifikasi dan koreksi dini terhadap ketidakwajaran data.
6.2 Analisis partograf & keputusan	Tidak mampu menafsirkan pola; keputusan tidak sesuai data.	Menafsirkan sebagian; keputusan masih ragu dan perlu arahan.	Menafsirkan tepat; keputusan observasi/intervensi/rujuk sesuai kriteria dan rasional.	Analisis tajam, antisipatif, merumuskan rencana tindak lanjut dan komunikasi keputusan dengan jelas.

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Pelaksanaan prosedur inti (langkah kritis & keamanan)	Langkah kritis terlewat; prosedur tidak aman/berhenti sebelum selesai.	Prosedur selesai namun beberapa langkah kritis perlu koreksi; keamanan belum konsisten.	Prosedur lengkap dan aman; langkah kritis dilakukan sesuai urutan; mandiri.	Sangat terampil, efisien, minim trauma/ketidaknyamanan; tetap aman pada situasi menantang.
7.2 Prioritas tindakan & evaluasi respons	Prioritas keliru; tidak memantau respons; keterlambatan eskalasi.	Prioritas cukup namun belum stabil; pemantauan/evaluasi belum terstruktur.	Prioritas tepat; memantau dan mengevaluasi respons; melakukan eskalasi sesuai kebutuhan.	Sangat cepat dan tepat, antisipatif, menjaga stabilitas dengan monitoring terencana dan keputusan tegas.
7.3 Rujukan aman	Tidak melakukan	Stabilisasi dan SBAR dilakukan sebagian;	Stabilisasi memadai;	Koordinasi sangat baik, informasi ringkas-krusial,

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
(stabilisasi, SBAR, dokumentasi)	stabilisasi dasar; komunikasi rujukan tidak jelas; dokumen tidak lengkap.	dokumen perlu banyak perbaikan.	SBAR jelas; dokumentasi rujukan lengkap dan terbaca.	dokumentasi sangat rapi, memastikan kesinambungan informasi sampai tujuan rujukan.

Uraian Materi

Pengkajian kebidanan terpadu merupakan kemampuan dasar yang harus dikuasai mahasiswa kebidanan sebagai bagian dari kompetensi inti. Pengkajian tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi harus dapat diaplikasikan secara nyata dalam praktik klinik. Dalam pengkajian terpadu dapat diperoleh melalui pengumpulan data subyekti, data obyektif dan pencatatan data melalui dokumentasi. Data subyektif diperoleh melalui anamnesis sedangkan data obyektif melalui pemeriksaan fisik yang kita lakukan. Maka sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik lebih lanjut kita memerlukan anamnesis kepada pasien.

Anamnesis terfokus adalah proses pengumpulan data berdasarkan keluhan utama dan faktor risiko yang relevan. Anamnesis tidak hanya dipahami sebagai teori, tetapi sebagai kompetensi praktik yang harus dapat dilakukan secara efektif. Anamnesis yang kita lakukan mulai dari menanyakan identitas pasien, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat obstetri, riwayat kesehatan dahulu dan keluarga, riwayat social budaya dan pola kebutuhan dasar. Setelah melakukan anamnesis secara lengkap selanjutnya melakukan pemeriksaan fisik.

Pemeriksaan fisik adalah proses pengumpulan data objektif melalui teknik inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Keterampilan ini harus dikuasai melalui praktik langsung. Pemeriksaan fisik yang dilakukan meliputi pemeriksaan umum, pemeriksaan head to toe dan pemeriksaan obstetri. Setelah melakukan pemeriksaan fisik secara lengkap melakukan dokumentasi.

Dokumentasi awal adalah pencatatan hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik secara sistematis. Dokumentasi merupakan kompetensi penting yang harus dikuasai mahasiswa sebagai bagian dari praktik profesional.

Pemeriksaan Klinik pada ibu hamil adalah salah satu usaha preventif program pelayanan kesehatan obstetri untuk mengoptimalkan kelainan yang terjadi pada maternal dan neonatal melalui serangkaian pemeriksaan yang dapat dilakukan selama kehamilan

A. Definisi

Pengkajian kebidanan terpadu merupakan tahap awal dalam proses asuhan kebidanan yang dilakukan secara sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan untuk mengumpulkan data terkait kondisi kesehatan ibu dan janin. Pendekatan terpadu ini mencakup tiga komponen utama, yaitu anamnesa terfokus, pemeriksaan fisik, dan dokumentasi awal, yang saling berkaitan dalam menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penegakan diagnosis dan perencanaan asuhan kebidanan.

B. Tujuan

Tujuan pengkajian kebidanan terpadu yang meliputi anamnesa terfokus, pemeriksaan fisik, dan dokumentasi awal adalah untuk memperoleh data yang lengkap, akurat, dan relevan mengenai kondisi kesehatan ibu dan janin sebagai dasar dalam pengambilan keputusan klinis yang tepat. Melalui anamnesa terfokus, tenaga kesehatan bertujuan menggali informasi utama yang berkaitan dengan keluhan, riwayat kehamilan, serta faktor risiko yang dapat mempengaruhi kehamilan. Penelitian menunjukkan bahwa anamnesa yang sistematis dan terarah memiliki kontribusi besar dalam penegakan diagnosis klinis karena sebagian besar informasi awal diperoleh dari riwayat pasien.

C. Indikasi

1. Semua kunjungan pelayanan kebidanan
2. Kunjungan pertama dan kunjungan ulang
3. Adanya keluhan atau tanda bahaya
4. Ibu dengan factor resiko atau riwayat komplikasi
5. Kebutuhan penegakan diagnose kebidanan
6. Pemantauan kesejahteraan ibu dan janin
7. Kewajiban professional dan legal

D. Kontraindikasi

1. Kondisi kegawatdaruratan
2. Gangguan kesadaran atau kondisi umum tidak stabil
3. Perdarahan antepartum yang belum diketahui penyebabnya
4. Ketuban pecah dini atau resiko infeksi
5. Nyeri hebat atau kondisi yang tidak memungkinkan pemeriksaan
6. Gangguan psikologis atau hambatan komunikasi
7. Situasi keterbatasan fasilitas atau bencana

E. Persiapan Alat

1. Alat komunikasi (Anamnesa) → Formulir, Alat tulis, Media komunikasi dan jam atau stopwatch.
2. Alat pemeriksaan klinis (Fisik dan Obstetri) → Tensimeter, Stetoskop, Termometer, Timbangan BB, Pengukur TB, Doppler, Sarung tangan Steril, Kasa, Senter,
3. Alat pencegahan infeksi → Masker, Sarung tangan, APD (Alat Pelindung Diri), Hand sanitizer
4. Alat dokumentasi → Buku KIA, Rekam Medis, Partograf, Alat Tulis

5. Sarana pendukung pelayanan →Tempat tidur, Tirai, Lampu pemeriksaan, Perlak (Alas)

F. Langkah Tindakan

1. Persiapan
2. Anamnesa
3. Pemeriksaan Fisik
4. Dokumentasi

G. Keselamatan

1. Keselamatan pasien
2. Keselamatan tenaga kesehatan
3. Keamanan proses anamnesa, pemeriksaan dan dokumentasi
4. Keamanan lingkungan dan sistem pelayanan

H. Evaluasi

1. Kualitas data
2. Ketepatan prosedur
3. Kelengkapan dokumentasi

I. Dokumentasi

1. Data Subyektif
   a. Identitas Pasien
   b. Keluhan Utama
   c. Riwayat keluhan sekarang
   d. Riwayat kehamilan sekarang
   e. Riwayat obstetric
   f. Riwayat penyakit dahulu
   g. Pola kebutuhan dasar
   h. Aspek psikososial
2. Data Obyektif
   a. Keadaan umum
   b. Tanda vital
   c. Pemeriksaan fisik umum
   d. Pemeriksaan obstetric
   e. Pemeriksaan penunjang
3. Assasment (Analisa)
4. Planning (Rencana tindakan)

J. Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Seorang ibu hamil, Ny. A, usia 28 tahun, G2P1A0, datang ke puskesmas dengan keluhan utama pusing dan lemas sejak 3 hari terakhir. Usia kehamilan berdasarkan HPHT adalah sekitar 28 minggu. Ibu mengatakan nafsu makan menurun dan sering merasa cepat lelah. Tidak ada riwayat penyakit kronis sebelumnya, namun pada kehamilan sebelumnya ibu pernah mengalami anemia ringan. Hasil anamnesis awal menunjukkan: Ibu jarang mengonsumsi tablet tambah darah karena merasa mual. Pola makan kurang bervariasi, lebih sering mengonsumsi nasi dan lauk sederhana. Aktivitas sehari-hari cukup padat sebagai ibu rumah tangga. Hasil Pemeriksaan fisik awal menunjukkan: Keadaan umum: tampak lemah, Kesadaran: compos mentis, Tekanan darah: 100/70 mmHg, Nadi: 92 x/menit, Pernapasan: 22 x/menit, Suhu: 36,7°C, Konjungtiva tampak pucat, TFU sesuai usia kehamilan, DJJ: 140 x/menit

Pertanyaan Diskusi

1. Identifikasi data subjektif tambahan yang perlu digali dari pasien!
2. Sebutkan pemeriksaan fisik lanjutan yang perlu dilakukan untuk memperkuat dugaan masalah!
3. Jelaskan tujuan dari masing-masing pemeriksaan tersebut!
4. Identifikasi tanda-tanda klinis yang mengarah pada anemia pada ibu hamil! Interpretasikan data subjektif dan objektif yang telah diperoleh!
5. Rumuskan masalah kebidanan sementara berdasarkan data tersebut!
6. Buat contoh dokumentasi awal menggunakan format SOAP

Soal OSCE Kebidanan

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Pengkajian Kebidanan Terpadu pada Ibu Hamil Trimester III dengan Dugaan Anemia
3	Kasus	Seorang ibu hamil datang ke puskesmas dengan keluhan pusing, lemas, dan mudah lelah sejak beberapa hari terakhir. Ibu tampak pucat dan mengaku jarang mengonsumsi tablet tambah darah.
4	Tujuan	Menilai kemampuan peserta dalam melakukan pengkajian kebidanan secara terpadu meliputi anamnesa terfokus, pemeriksaan fisik, dan dokumentasi awal.
5	Kompetensi	1. Melakukan anamnesa terfokus pada ibu hamil 2. Melakukan pemeriksaan fisik dasar pada ibu hamil 3. Menginterpretasikan data awal 4. Melakukan dokumentasi awal (SOAP)

No.	Komponen	Isi
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Anda adalah seorang bidan di puskesmas. Seorang ibu hamil usia kehamilan ±28 minggu datang dengan keluhan pusing dan lemas. Lakukan pengkajian kebidanan secara terpadu untuk menentukan kondisi pasien. TUGAS 1. Melakukan komunikasi terapeutik 2. Melakukan anamnesa terfokus sesuai kasus 3. Melakukan pemeriksaan fisik dasar 4. Menyampaikan hasil interpretasi awal 5. Menuliskan dokumentasi awal dalam format SOAP
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikutkan kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: ▪ Actual mark (0/1/2/3) ▪ Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Salam dan identifikasi pasien 2. Anamnesa sesuai keluhan utama 3. Pemeriksaan tanda vital 4. Pemeriksaan tanda anemia (konjungtiva) 5. Interpretasi sederhana INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Jika peserta tidak menanyakan sesuatu yang penting, PS dapat memberikan petunjuk minimal setelah 2 menit 2. Jika peserta melewatkan pemeriksaan penting, beri tanda pada checklist
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 1. Menjawab sesuai pertanyaan peserta 2. Tidak memberikan informasi tambahan tanpa ditanya 3. Menunjukkan ekspresi lelah

No.	Komponen	Isi
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Bu. PS: Pagi/siang, Bu. Peserta: Saya bidan yang akan memeriksa ibu. Apakah ibu bersedia? PS: Iya, Bu, saya bersedia. Peserta: Apa keluhan utama ibu? PS: Saya sering pusing dan lemas, Bu. Peserta: Sejak kapan pusing dan lemasnya? PS: Kira-kira sudah 2 hari, Bu. Peserta: Apakah minum obat Fe? PS: Saya jarang minum, soalnya bikin mual. Peserta: Bagaimana makannya? PS: Saya makan seadanya, kadang Cuma nasi sama tempe. Peserta: Apakah ibu tidak pernah makan sayur? PS: Tidak, Bu. Peserta: Bagaimana gerakan bayi? PS: Masih terasa , Bu. Peserta: Ini kehamilan yang ke berapa? PS: Ini kehamilan kedua, yang pertama normal Bu. Catatan: Jika ada pertanyaan lain terkait riwayat penyakit, riwayat obstetri-ginekologi, sosial, spiritual, ekonomi, dan ADL, PS memberi jawaban normatif dan tidak mengarah ke diagnosis lain.
10	Kebutuhan manikin	1. Tidak wajib (bisa menggunakan pasien standar) 2. Alternatif: manikin ibu hamil untuk simulasi pemeriksaan
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: 1. Menyiapkan alat pemeriksaan 2. Mengatur waktu (7–10 menit) 3. Mengondisikan ruangan 4. Membantu pergantian peserta
12	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur/periksa – 1 2. Tensimeter – 1 3. Stetoskop – 1 4. Jam Tangan / Stopwatch – 1 5. Phantom Ibu Hamil – 1 6. Lembar SOAP - 1 set 7. Alat Tulis – 1 8. Sarung tangan bersih - 1 pasang 9. Handrub - 1 botol 10. Kain penutup/selimut – 1 11. Tisu - 1 pack 12. Buku KIA (Opsional) 13. Lembar jawaban peserta - 1 lembar
13	Penulis	.....

No.	Komponen	Isi
14	Referensi	1. Kementerian Kesehatan RI. (2020). Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 2. Kementerian Kesehatan RI. (2020). Standar Profesi Bidan Indonesia 3. International Confederation of Midwives. (2019). Essential Competencies for Midwifery Practice 4. Varney, H., Kriebs, J. M., & Gegor, C. L. (2015). Varney's midwifery (5th ed.). Jones & Bartlett Learning

RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

Stase 1: ibu Hamil Trimester III dengan Dugaan Anemia

KOMPETENSI 1. Anamnesa

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Menggali keluhan utama		
2. Riwayat keluhan sekarang		
3. Riwayat Obstetri		
4. Riwayat Konsumsi Fe		
5. Riwayat Nutrisi		
6. Faktor Resiko Anemia		

Skoring KOMPETENSI 1

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 6 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 4–5 dari 6 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–4 dari 6 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Pemeriksaan Fisik

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Pemeriksaan Tekanan Darah		
2. Pemeriksaan Nadi		
3. Pemeriksaan Pernafasan		
4. Pemeriksaan Suhu		
5. Pemeriksaan Konjungtiva		
6. Pemeriksaan TFU		
7. Pemeriksaan DJJ		

Skoring KOMPETENSI 2

- 3= Jika peserta ujian melakukan 7 langkah dengan tepat dan sistematis.
- 2= Jika peserta melakukan 5 - 6 langkah dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat.

- 1= Jika peserta melakukan 1–5 langkah dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun, atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat.

KOMPETENSI 3. Analisa Data

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Mengidentifikasi Masalah Utama		
2. Menghubungkan Data Subyektif dan Obyektif		
3. Menyimpulkan Dugaan Anemia		

Skoring KOMPETENSI 3

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 3 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 2 dari 3 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1 dari 3 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 4. Dokumentasi (SOAP)

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Subyektif (S)		
2. Obyektif (O)		
3. Assasement (A)		
4. Planing (P)		

Skoring KOMPETENSI 4

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 4 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 2 dari 3 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan **1**–2 dari 4 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 4

(dicatat di rubrik penilaian)

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah total skore}}{40} \times 100 =$$

(Kota), ...

.....

Penguji :.....

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Pengkajian Kebidanan Terpadu : Anamnesa Terfokus Pemeriksaan Fisik, dan Dokumentasi Awal

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Ibu Hamil Trimester III dengan Dugaan Anemia
Metode penilaian	DOPS merupakan metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan klinik mahasiswa saat melakukan prosedur pada pasien nyata atau simulasi. Penilaian dilakukan secara real-time oleh pembimbing klinik menggunakan instrumen terstruktur.	Mahasiswa kebidanan diamati secara langsung saat melakukan pengkajian pada ibu hamil trimester III di ruang ANC puskesmas.
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah Menilai kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan secara nyata pada praktik klinik, khususnya dalam pengkajian kebidanan terpadu.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang Menggali anamnesa terfokus pada ibu hamil dengan keluhan lemas saja tetapi melakukan pemeriksaan fisik dasar secara sistematis

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Ibu Hamil Trimester III dengan Dugaan Anemia
		dan mendokumentasikan hasil pengkajian dalam format SOAP
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang digunakan harus representatif dan sesuai dengan kompetensi yang akan dinilai.	Seorang perempuan 28 tahun, G2P101, hamil 37 minggu, datang ke Puskesmas PONED dengan keluhan pusing dan lemas.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Pada DOPS, mahasiswa diamati saat melakukan Kegiatan nyata yang dilakukan mahasiswa selama praktik klinik yang menjadi objek observasi.	Mahasiswa melakukan komunikasi terapeutik, melakukan anamnesa terfokus, melakukan pemeriksaan tanda vital dan pemeriksaan kebidanan, menyusun interpretasi data, m enulis dokumentasi awal
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai Komponen keterampilan yang dinilai secara terstruktur sesuai standar kompetensi.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu melakukan anamnesa terfokus, Pemeriksaan fisik, Clinical reasoning (analisis data), Dokumentasi (SOAP)
Fokus observasi pembimbing	Hal-hal spesifik yang menjadi perhatian pembimbing saat melakukan observasi.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa tepat pertanyaan dalam anamnesa, Urutan dan teknik pemeriksaan fisik, Kemampuan mengidentifikasi tanda anemia (konjungtiva pucat, keluhan lemas) Kesesuaian antara data dan diagnosis awal, Kelengkapan dokumentasi
Umpan balik	Umpan balik dalam DOPS diberikan pembimbing setelah observasi, bersifat konstruktif dan spesifik.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah melakukan komunikasi dengan baik dan sistematis, Lebih mendalami riwayat nutrisi dan kepatuhan konsumsi Fe, Latih kembali teknik pemeriksaan konjungtiva dan interpretasinya.
Keputusan penilaian	Hasil akhir penilaian berdasarkan performa mahasiswa selama observasi.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan tindakan awal secara runtut, aman, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan kompeten dengan supervisi apabila langkah utama sudah benar tetapi masih memerlukan arahan. Mahasiswa dinyatakan belum kompeten apabila gagal dalam melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik serta salah menentukan prioritas, atau tidak melakukan dokumentasi dengan benar.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Ibu Hamil Trimester III dengan Dugaan Anemia
Makna dalam OBE	DOPS sebagai alat ukur pencapaian learning outcomes mahasiswa secara langsung dalam praktik klinik.	Mengukur CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) pada aspek keterampilan klinik, Mendukung pembelajaran berbasis kompetensi, Memberikan bukti autentik pencapaian mahasiswa Mendorong refleksi diri dan perbaikan berkelanjutan

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 3.2
Portofolio pada Pengkajian KebidananTerpadu: Anamnesa Terfokus, Pemeriksaan Fisik dan Dokumentasi Awal

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Ibu Hamil Trimester III dengan Dugaan Anemia
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kompetensi secara berkelanjutan melalui pengalaman klinik nyata.	Mahasiswa mengumpulkan hasil anamnesa, pemeriksaan fisik, dokumentasi SOAP, serta refleksi selama melakukan pengkajian pada ibu hamil dengan keluhan lemas dan pusing.
Tujuan portofolio	Untuk menilai pencapaian kompetensi secara holistik (pengetahuan, keterampilan, sikap) serta mendorong refleksi diri mahasiswa.	Mahasiswa mampu menunjukkan kemampuan melakukan pengkajian terpadu dan memahami pentingnya deteksi dini anemia pada kehamilan.
OSCE dan DOPS	OSCE menilai keterampilan dalam situasi terstandar, sedangkan DOPS menilai performa langsung di lahan praktik.	Mahasiswa telah mengikuti OSCE tentang pengkajian anemia dan dinilai melalui DOPS saat praktik di puskesmas saat menangani pasien nyata.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Ibu Hamil Trimester III dengan Dugaan Anemia
Catatan kasus singkat	Ringkasan kasus pasien yang ditangani meliputi data subjektif dan objektif secara singkat.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus Ny. A, 28 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 28 minggu, keluhan pusing dan lemas. Konjungtiva pucat, TD 100/70 mmHg, riwayat tidak rutin minum tablet Fe.
Refleksi patient safety	Refleksi mahasiswa terkait aspek keselamatan pasien selama tindakan.	Mahasiswa menyadari pentingnya memastikan pasien nyaman saat pemeriksaan, menjaga privasi, serta tidak melewatkan tanda anemia yang dapat berdampak pada ibu dan janin.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari pembimbing klinik atau dosen terkait performa mahasiswa.	Mahasiswa sudah baik dalam komunikasi, namun perlu meningkatkan ketelitian dalam menggali riwayat nutrisi dan kepatuhan konsumsi Fe.
Karakteristik penilaian	Penilaian bersifat autentik, berkelanjutan, komprehensif, dan berbasis bukti nyata.	Penilaian dilakukan berdasarkan performa langsung, dokumentasi SOAP, serta refleksi mahasiswa selama praktik.
Bukti konsistensi kompetensi	Bukti bahwa mahasiswa mampu menunjukkan kompetensi secara konsisten dalam beberapa kesempatan.	Mahasiswa menunjukkan kemampuan serupa dalam beberapa kasus ANC, seperti melakukan anamnesa terfokus, pemeriksaan tanda vital, dan dokumentasi dengan benar.
Makna dalam OBE	Portofolio sebagai alat untuk menilai pencapaian learning outcomes secara nyata dan terukur.	Portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa telah mencapai CPL keterampilan klinik dalam pengkajian kebidanan secara terpadu sesuai standar profesi.

Tabel 3.3
Case Report pada Pengkajian Kebidanan Terpadu: Anamnesa Terfokus Pemeriksaan Fisik, dan Dokumentasi Awal

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Ibu Hamil Trimester III dengan Dugaan Anemia
Hakikat case report	Case report merupakan laporan ilmiah yang menggambarkan secara sistematis satu kasus pasien mulai dari pengkajian, diagnosis, intervensi, hingga evaluasi. Dalam kebidanan, case report digunakan untuk mendokumentasikan proses asuhan secara komprehensif dan berbasis bukti.	Mahasiswa menyusun laporan kasus seorang ibu hamil usia 32 minggu yang datang dengan keluhan lemas, pusing, dan mudah lelah. Dilakukan pengkajian terpadu mulai dari anamnesa, pemeriksaan fisik, hingga dokumentasi awal untuk menegakkan dugaan anemia.
Tujuan	Untuk melatih kemampuan klinis mahasiswa dalam mengintegrasikan teori dan praktik, meningkatkan kemampuan analisis kasus, serta sebagai sarana evaluasi pembelajaran berbasis praktik (OBE).	Mahasiswa mampu mengidentifikasi tanda dan gejala anemia pada kehamilan trimester III serta menyusun dokumentasi awal yang tepat sesuai standar asuhan kebidanan.
Isi laporan	Meliputi identitas pasien, anamnesa terfokus, pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan penunjang (jika ada), diagnosis kebidanan, rencana asuhan, dan dokumentasi awal.	Pada kasus ini, mahasiswa menuliskan ▪ Identitas: Ny. A, 28 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 32 minggu ▪ Anamnesa: Keluhan lemas, pusing, riwayat kurang konsumsi tablet Fe ▪ Pemeriksaan fisik: Konjungtiva pucat, Hb 9 gr/dL ▪ Diagnosis: Anemia ringan pada kehamilan ▪ Dokumentasi awal: SOAP
Fokus penilaian	Menilai ketepatan dalam pengumpulan data (anamnesa dan pemeriksaan fisik), kemampuan analisis klinis, ketepatan dokumentasi, serta penerapan prinsip patient safety.	Pembimbing menilai apakah Mahasiswa mampu menggali riwayat nutrisi, kepatuhan konsumsi Fe, serta menemukan tanda objektif seperti pucat pada konjungtiva dan hasil Hb rendah.
Nilai edukatif	Memberikan pengalaman belajar nyata berbasis kasus, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, clinical reasoning, serta kemampuan komunikasi dengan pasien.	Dari kasus Ibu Hamil dugaan Anemia, Mahasiswa belajar pentingnya deteksi dini anemia pada ibu hamil untuk mencegah komplikasi seperti perdarahan postpartum dan BBLR.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Ibu Hamil Trimester III dengan Dugaan Anemia
Makna dalam OBE	Dalam OBE, Case report menjadi alat untuk mengukur capaian pembelajaran (CLO/CPMK), terutama dalam aspek keterampilan klinis, komunikasi, profesionalisme, dan pengambilan keputusan berbasis bukti.	Mahasiswa menunjukkan kompetensi dalam melakukan pengkajian kebidanan terpadu sesuai standar, serta mampu mendokumentasikan hasil secara sistematis dan profesional.

Tabel 3.4
Refleksi Patient Safety pada Kegawatdaruratan Persalinan: Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal

Komponen	Deskripsi	Contoh pada pengkajian kebidanan terpadu pada ibu hamil trimester III dengan dugaan Anemia
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan proses berpikir kritis untuk mengidentifikasi potensi risiko, kesalahan, atau kejadian yang dapat membahayakan pasien selama proses pelayanan, serta upaya perbaikannya.	Pada kasus Ibu Hamil dugaan Anemia, mahasiswa Mahasiswa merefleksikan proses pengkajian pada ibu hamil 32 minggu dengan keluhan lemas untuk memastikan tidak ada data penting yang terlewat yang dapat membahayakan ibu dan janin.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan Meningkatkan kesadaran keselamatan pasien, mencegah kesalahan klinis, serta meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan melalui evaluasi diri.	Mahasiswa menyadari pentingnya skrining anemia secara tepat untuk mencegah komplikasi seperti perdarahan saat persalinan.
Fokus refleksi	Berfokus pada proses anamnesa, pemeriksaan fisik, komunikasi dengan pasien, ketepatan interpretasi data, dan dokumentasi awal.	Refleksi pada ketepatan menggali riwayat konsumsi tablet Fe, pola makan, serta pemeriksaan tanda pucat dan interpretasi hasil Hb.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa menunjukkan kemampuan mengenali Potensi bahaya atau kesalahan yang mungkin terjadi selama pengkajian.	• Tidak teridentifikasi anemia karena anamnesa kurang mendalam • Kesalahan interpretasi hasil Hb • Dokumentasi tidak lengkap • Tidak memberikan edukasi yang adekuat
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan Langkah-langkah untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan keselamatan pasien.	▪ Melakukan anamnesa sistematis berbasis keluhan utama ▪ Melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh ▪ Cross-check hasil pemeriksaan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada pengkajian kebidanan terpadu pada ibu hamil trimester III dengan dugaan Anemia
		▪ Dokumentasi sesuai standar (SOAP) ▪ Edukasi konsumsi tablet Fe dan nutrisi
Pembelajaran mahasiswa	Insight atau pelajaran yang diperoleh mahasiswa dari proses refleksi.	Mahasiswa memahami bahwa pengkajian yang tidak lengkap dapat berdampak pada keterlambatan diagnosis anemia dan meningkatkan risiko komplikasi pada ibu dan janin.
Makna dalam OBE	Refleksi patient safety mendukung pencapaian kompetensi lulusan dalam aspek keselamatan pasien, clinical reasoning, dan profesionalisme.	Mahasiswa menunjukkan kemampuan berpikir kritis, tanggung jawab profesional, dan penerapan prinsip patient safety dalam praktik kebidanan.

K. Ringkasan Materi

Pengkajian kebidanan terpadu merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses asuhan kebidanan, pengambilan keputusan klinis yang tepat dan aman bagi ibu serta janin. Pendekatan dilakukan secara sistematis dan komprehensif melalui integrasi tiga komponen utama, yaitu anamnesa terfokus, pemeriksaan fisik, dan dokumentasi awal. Ketiga komponen tersebut saling melengkapi menghasilkan data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Anamnesa terfokus dilakukan dengan menggali informasi berdasarkan keluhan utama dan faktor risiko yang relevan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar diagnosis klinis dapat ditegakkan melalui anamnesa yang baik dan terarah. Dalam konteks kebidanan, anamnesa tidak hanya mencakup keluhan fisik, tetapi juga riwayat obstetri, pola nutrisi, kepatuhan terhadap konsumsi suplemen seperti tablet zat besi, serta faktor psikososial yang dapat mempengaruhi kondisi kehamilan. Dengan anamnesa yang sistematis, tenaga kesehatan dapat mengidentifikasi secara dini potensi komplikasi, seperti anemia pada kehamilan.

Selanjutnya, pemeriksaan fisik dilakukan untuk mengkonfirmasi dan melengkapi data subjektif yang diperoleh dari anamnesa. Penelitian klinis menunjukkan bahwa kombinasi anamnesa dan pemeriksaan fisik secara signifikan meningkatkan akurasi deteksi dini terhadap masalah kesehatan ibu hamil. Pemeriksaan ini meliputi penilaian tanda-tanda vital, inspeksi, palpasi, auskultasi, serta pemeriksaan obstetri sesuai usia kehamilan. Misalnya, pada kasus dugaan anemia, dapat ditemukan tanda seperti konjungtiva pucat atau kondisi umum ibu

yang tampak lemah. Pemeriksaan fisik yang tepat sangat penting untuk memperkuat dugaan diagnosis dan menentukan kebutuhan pemeriksaan penunjang lebih lanjut.

Komponen terakhir adalah dokumentasi awal, yang merupakan proses pencatatan seluruh hasil pengkajian secara sistematis, biasanya menggunakan format seperti SOAP (Subjective, Objective, Assessment, Planning). Berdasarkan hasil penelitian, dokumentasi yang lengkap dan akurat berperan penting meningkatkan keselamatan pasien, menjamin kontinuitas pelayanan, serta mengurangi risiko kesalahan medis. Selain itu, dokumentasi juga memiliki aspek legal dan menjadi alat komunikasi efektif antar tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan yang berkesinambungan.

Secara keseluruhan, pengkajian kebidanan terpadu terbukti melalui berbagai penelitian sebagai pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Integrasi antara anamnesa terfokus, pemeriksaan fisik, dan dokumentasi awal tidak hanya mendukung ketepatan diagnosis, tetapi juga memperkuat praktik kebidanan berbasis bukti (evidence-based practice) serta menjamin keselamatan pasien.

L. Alur asuhan singkat

Alur asuhan kebidanan terpadu dimulai dari penerimaan pasien dan komunikasi terapeutik → identifikasi identitas serta keluhan utama → anamnesa terfokus (riwayat kehamilan, obstetri, kesehatan, nutrisi, dan faktor risiko) → pemeriksaan fisik umum dan obstetri (tanda vital, head-to-toe, pemeriksaan kehamilan) → analisis data subjektif dan objektif untuk menentukan diagnosis/masalah kebidanan → dokumentasi awal dalam format SOAP (Subjective, Objective, Assessment, Plan) → perencanaan asuhan dan edukasi (intervensi, konseling, rencana pemeriksaan lanjutan) → evaluasi awal kondisi ibu → penentuan tindak lanjut (kontrol ulang atau rujukan bila diperlukan).

M. Tabel Red Flags & Eskalasi

Pengkajian Kebidanan Terpadu : Anamnesa Terfokus Pemeriksaan Fisik, dan Dokumentasi Awal

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Perdarahan pervaginam	Dugaan abortus, plasenta previa, atau solusio plasenta	Stabilkan kondisi, rujuk segera ke fasilitas PONEK
Nyeri kepala hebat, pandangan kabur	Indikasi preeklamsia/eklamsia	Cek tekanan darah, observasi ketat, rujuk segera
Tekanan darah ≥ 140/90 mmHg	Hipertensi dalam kehamilan	Monitoring, kolaborasi, rujukan bila perlu
Gerakan janin berkurang/tidak terasa	Distress janin atau IUFD	Evaluasi DJJ, rujuk segera
DJJ <120 atau >160 x/menit	Gangguan kesejahteraan janin	Rujuk segera untuk evaluasi lanjutan
Konjungtiva pucat, Hb <11 gr/dL	Anemia pada kehamilan	Pemberian Fe, edukasi nutrisi, rujuk jika berat
Lemas berat, pusing, sesak	Anemia sedang–berat	Pemeriksaan Hb segera, pertimbangkan rujukan
Edema wajah dan tangan	Tanda preeklamsia	Evaluasi lanjutan dan rujuk
TFU tidak sesuai usia kehamilan	Gangguan pertumbuhan janin	Pemeriksaan lanjutan (USG), rujuk
Demam tinggi (>38°C)	Infeksi	Terapi awal, rujuk bila tidak membaik
Data pengkajian tidak lengkap	Risiko kesalahan diagnosis	Lengkapi data, validasi ulang
Tidak ada dokumentasi SOAP	Risiko masalah legal & keselamatan pasien	Segera lakukan dokumentasi sesuai standar
Tidak ada rencana tindak lanjut	Risiko keterlambatan penanganan	Susun rencana asuhan dan follow-up jelas

N. Referensi

Agustin, L., & Rahmawati, D. (2024). Buku ajar pemeriksaan fisik ibu dan bayi.

Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Spong, C. Y., & Dashe, J. S. (2014). Williams obstetrics (24th ed.). McGraw-Hill Education.

Handayani, D. F. (2018). Laporan tugas akhir asuhan kebidanan komprehensif pada Ny. D di UPT Puskesmas Banyuanyar Surakarta.

International Confederation of Midwives. (2019). Essential competencies for midwifery practice.

JNPK-KR. (2017). Asuhan persalinan normal.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020a). Buku kesehatan ibu dan anak (KIA).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020b). Pedoman pelayanan antenatal terpadu.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020c). Standar profesi bidan Indonesia.

Liana (2019) Kunjungan Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) dan Faktor yang Mempengaruhinya. 1st edn. Banda Aceh: Bandar Publishing.

Lumban Gaol, Y. V. S., et al. (2025). Pemeriksaan fisik kesehatan.

Safitri, W. (2020). Laporan tugas akhir asuhan kebidanan pada bayi.

Varney, H., Kriebs, J. M., & Gegor, C. L. (2015). Varney's midwifery (5th ed.). Jones & Bartlett Learning.

World Health Organization. (2016a). Antenatal care guidelines.

World Health Organization. (2016b). WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience.

BAB 4

PEMERIKSAAN TANDA VITAL DAN ANTROPOMETRI: TEKNIK, INTERPRETASI, DAN KESALAHAN UMUM

CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepatuhan aspek legal-budaya dalam pelayanan kebidanan.	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik, konseling, dan kolaborasi yang berpusat pada perempuan dan keluarga.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan keselamatan pasien, pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), serta K3 dalam seluruh tindakan klinis.	CPMK-1; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-7
CPL-4	Melaksanakan pengkajian, interpretasi data, dan clinical reasoning untuk menentukan asuhan, monitoring, dan rujukan.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
CPL-5	Mendemonstrasikan keterampilan pemeriksaan dan tindakan dasar kebidanan secara aman, efektif, dan bermutu.	CPMK-4; CPMK-5; CPMK-7
CPL-6	Menyusun dokumentasi klinis dan komunikasi rujukan yang akurat serta memanfaatkan standar/bukti untuk perbaikan mutu.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-6; CPMK-7

CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menerapkan prinsip keselamatan pasien, APD, pencegahan infeksi, dan K3 pada seluruh keterampilan klinis kebidanan.
CPMK-2	Melaksanakan komunikasi terapeutik dan KIE/konseling kebidanan yang empatik, terstruktur, dan sesuai kebutuhan serta literasi kesehatan.
CPMK-3	Melakukan pengkajian kebidanan terpadu melalui anamnesis terfokus, pemeriksaan fisik dasar, dan dokumentasi awal yang akurat.
CPMK-4	Melakukan pemeriksaan tanda vital dan antropometri, menginterpretasi hasil, serta mengidentifikasi kesalahan teknik dan tindak lanjut awal.
CPMK-5	Melakukan pemeriksaan obstetri intrapartum (Leopold, DJJ, dan pemeriksaan dalam aseptik) serta melaporkan kemajuan persalinan secara tepat.
CPMK-6	Menggunakan partograf untuk memantau persalinan dan mengambil keputusan praktik dasar (observasi, intervensi, rujukan) berbasis kriteria.
CPMK-7	Melaksanakan tindakan dasar asuhan kebidanan dan stabilisasi awal pada persalinan, nifas, bayi baru lahir, KB, serta rujukan aman sesuai standar.

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 4. Pemeriksaan Tanda Vital dan Antropometri: Teknik, Interpretasi, dan Kesalahan Umum	4.1 Melakukan pengukuran tanda vital dan antropometri dengan teknik benar serta cek alat sederhana.	4.2 Menginterpretasi hasil, mengenali nilai abnormal dan kesalahan umum, serta menentukan tindak lanjut awal.	CPMK-4	CPMK-1; CPMK-3

Uraian Materi

A. Pemeriksaan Tanda Vital dan Antropometri: Teknik, Interpretasi, dan Kesalahan Umum

Antropometri adalah studi tentang pengukuran tubuh manusia dalam hal dimensi tulang, otot, dan jaringan adiposa (lemak). Pengukuran jaringan adiposa subkutan penting karena individu dengan nilai besar dilaporkan berisiko tinggi terkena hipertensi, diabetes mellitus onset dewasa, penyakit kardiovaskular, batu empedu, radang sendi, dan penyakit lainnya, dan bentuk kanker. Dikombinasikan dengan diet dan data kuesioner terkait, dan penentuan biokimia, antropometri adalah informasi penting dan penting yang diperlukan untuk membantu menggambarkan data yang dikumpulkan dari orang-orang dalam sampel NHANES III.

Tujuan Antropometri yaitu untuk melihat petumbuhan aktual, berat badan, dan ukuran tubuh aktual termasuk lipatan kulit, ketebalan, dan lebar akan dikumpulkan di MEC untuk tujuan menilai pertumbuhan, distribusi lemak tubuh, dan untuk penyediaan data referensi. Pengukuran perawakan dan berat badan akan memungkinkan revisi bagan pertumbuhan anak yang sebagian didasarkan pada data yang dikumpulkan dalam siklus NHES II dan III dan data dari Studi Longitudinal Fels. Pengukuran antropometri seperti lipatan kulit dan lingkar dan impedansi bioelektrik (metode yang digunakan untuk memperkirakan jumlah jaringan tanpa lemak) akan memungkinkan analisis cross-sectional tentang hubungan antara obesitas dan risiko penyakit. Oleh karena itu, banyak pengukuran yang termasuk dalam NHANES III akan mengulangi yang dilakukan pada NHANES dan HHANES sebelumnya sehingga analisis tren dapat dilakukan. Beberapa ukuran telah ditambahkan untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang ukuran tubuh dan distribusi lemak, sementara yang lain telah dihilangkan karena data baru telah menentukan bahwa ukuran lain lebih informatif

Prosedur Pemeriksaan

1. Berat Badan
   a. Orang dewasa harus mengenakan pakaian minimalis dan ringan. Jika tidak memungkinkan baginya untuk melepas pakaian berat, silakan merujuk ke daftar bobot khas pakaian dewasa yang dikembangkan oleh masing-masing pusat (Lampiran 2) dan ingatlah untuk mengurangi nilai penjumlahan ini dari berat total sebelum mencatat nilai pada formulir.
   b. Mintalah ibu untuk melepas benda berat dan melepas sepatunya.
   c. Pastikan timbangan berada pada permukaan yang rata sempurna tanpa penghalang.

d. Nyalakan timbangan dengan menekan perlahan kaki pada permukaan timbangan
e. Mintalah ibu untuk berdiri di atas timbangan, meletakkan kakinya di atas tanda kaki yang ditempelkan pada timbangan, dan tetap diam sampai beban muncul.
f. Baca dan catat berat di bagian formulir yang sesuai
g. Silakan lakukan pengukuran berat dua kali dan catat pada formulir seperti yang muncul di layar, yaitu ke satu tempat desimal (Dr. Mecedes de onis, Dr. leila Cheikh Ismail, 2012)

Kesalahan Umum

Ada banyak timbangan berbeda yang tersedia, tetapi timbangan yang paling cocok untuk tujuan ini adalah:

a. Valid
b. Dapat diperiksa secara rutin melalui kalibrasi
c. Memiliki level semangat bawaan untuk memastikan bahwa timbangan horizontal
d. Memiliki tampilan jarak jauh sehingga individu tidak dapat melihat pembacaan
e. Portabel, ringan, dan mudah diangkut
f. Berat tampilan hingga 100g pada kisaran 0-150 kg dan memiliki fasilitas pegangan dan tara

Peralatan penimbangan harus dikalibrasi dan ini harus dilakukan oleh personel terlatih setiap tahun. Stiker kalibrasi dan level semangat harus diperiksa pada awal setiap sesi pengukuran. Setiap tiga bulan sekali timbangan harus diperiksa berat oleh orang yang bersangkutan di dalamnya. Anda harus mengatur timbangan ke nol dan menempatkan masing-masing timbangan, secara bergantian, ke timbangan untuk memeriksa apakah peralatan penimbangan mencatat berat yang sama dengan bobot portabel. Jika kesalahan melebihi 100g, timbangan harus dikirim untuk kalibrasi.

a. Pastikan timbangan telah diperiksa dan dikalibrasi setiap tahun mengikuti pedoman pabrikan.
b. Sebelum menggunakan peralatan, Anda harus memastikannya rata. Untuk melakukan ini, Anda harus mengubah kaki hingga gelembung berada di lingkaran tengah. Jika Anda memindahkan peralatan, posisi gelembung kemungkinan besar akan berubah sehingga memerlukan penyesuaian ulang.

c. Untuk menyesuaikan, putar kaki sekrup searah jarum jam untuk menaikkan, dan berlawanan arah jarum jam untuk menurunkan timbangan.
d. Saat berada dalam posisi yang benar, sehingga gelembung berada di lingkaran tengah, kunci di tempatnya dengan memasang mur pengunci (cakram atas) ke atas, berlawanan arah jarum jam (NIHR, 2017)

2. Tinggi Badan
   a. Mintalah pasien berdiri tegak di papan lantai stadiometer dengan punggung menghadap papan belakang vertikal stadiometer.
   b. Berat peserta didistribusikan secara merata di kedua kaki.
   c. Tumit kaki ditempatkan bersama dengan kedua tumit menyentuh pangkal papan vertikal.
   d. Tempatkan kaki sedikit mengarah ke luar pada sudut 60 derajat
   e. Jika pasien memiliki lutut yang saling menyentuh atau kaki berbentuk X, kaki dipisahkan sehingga bagian dalam lutut bersentuhan tetapi tidak tumpang tindih.
   f. Bokong, skapula, dan kepala diposisikan bersentuhan dengan papan belakang vertikal.
   g. Kebanyakan orang dewasa untuk menempatkan tumit, bokong, skapula dan aspek posterior kepala mereka ke papan belakang sambil mempertahankan perawakan normal.
   h. Pasien semacam itu diposisikan sedemikian rupa sehingga hanya tumit dan bokong yang bersentuhan dengan papan vertikal, dan tubuh diposisikan secara vertikal di atas pinggang.
   i. Lengan menggantung bebas di sisi batang dengan telapak tangan menghadap paha.
   j. Pasien diminta untuk menarik napas dalam-dalam dan berdiri tegak sepenuhnya tanpa mengubah posisi tumit.
   k. Kepala pasien dipertahankan dalam posisi Frankfort Horizontal Plane, sementara pemeriksa menurunkan bilah horizontal dengan pas ke ubun-ubun kepala dengan tekanan yang cukup untuk mengompres rambut. Ornamen rambut, sanggul, kepang, dll. harus dilepas untuk mendapatkan pengukuran yang akurat.
   l. Bilah dikunci di tempatnya dan salah satu label nomor sampel ditempatkan di sebelah pita pada bilah tegak sehingga label dapat dibaca pada foto pengukuran ketinggian berdiri. Pemeriksa perlu memastikan bahwa rambut paise tidak mengaburkan skala saat diiukur. Setelah pengukuran dibaca oleh pemeriksa hingga 0,1 cm terdekat

Kesalahan Umum

a. Klasifikasi yang belum tepat pada tinggi badan orang dewasa berdasarkan jenis kelamin
b. Klasifikasi yang belum tepat pada orang dewasa dalam beberapa negara
c. Klasifikasi yang belum tepat pada orang dewasa sesuai dengan etnis
d. Teknik pemeriksaan tinggi badan yang tidak sesuai dengan standart prosedur
e. Pembacaan hasil pemeriksaan yang tidak tepat (Sahyoun et al., 2008)

Tanda - Tanda Vital

Pemeriksaan Tanda - Tanda Vital yaitu tekanan darah, frekuensi jantung, frekuensi pernapasan, dan suhu tubuh. Mungkin pemeriksa akan menemukan bahwa tanda – tanda vital pasien sudah diperiksa dan dicatat pada rekam medisnya; jika abnormal, mungkin dianjurkan untuk mengulangi sendiri pemeriksaannya. (Melakukan pemeriksaan yang penting ini pada saat memulai pemeriksaan kardiovaskular, toraks, dan paru, tetapi pemeriksaan ini sering memberi informasi pendahuluan yang penting dan mempengaruhi arah pengevaluasian)

Teknik Pemeriksaan

1. Periksa dahulu tekanan darah atau denyut nadi.
2. Jika tekanan darahnya tinggi, ukur Kembali pada saat melakukan pemeriksaan fisik.
3. Hitung denyut nadi radialis dengan jari jari tangan anda atau denyut apeks (iktus kordis) dengan meletakkan stetoskop di daerah apeks jantung.
4. Lanjutkan salah satu teknik pemeriksaan ini dan hitung frekuensi pernapasan tanpa pasien menyadarinya (pola pernapasan dapat berubah jika pasien menyadari bahwa pernapasannya sedang diamati). Suhu tubuh diukur dengan termometer kaca, termometer timpanik, atau termometer elektronik digital (*digital electronic probes*). Rincian lebih lanjut mengenai teknik – teknik untuk memastikan akurasi hasil pemeriksaan tanda tanda vital terdapat pada halaman berikutnya.

B. Tekanan Darah

Pemilihan Tensimeter (Sfigmomanometer). Sebanyak 50 juta orang Amerika memiliki tekanan darah yang tinggi. Untuk mengukur tekanan darah dengan akurat, anda harus memiliki tensimeter yang pas. Pedoman dibawah ini akan membantu Anda dalam memberikan saran kepada pasien yang ingin membeli alat pengukur tekanan darah. Manset yang terlalu pendek atau terlalu sempit dapat meberikan hasil pengukuran yang tinggi dan salah (*fasely high*). Pemakaian manset dengan ukuran regular pada lengan yang gemuk dapat menghasilkan diagnosis hipertensi yang keliru. Pemilihan tensimeter yang benar

1. Lebar balon yang dapat digembungkan dalam manset harus sekitar 40% dari lingkaran lengan atas (sekitar 12-14 cm pada rata- rata orang dewasa)
2. Panjang balon tersebut harus sekitar 80% dari lingkaran lengan atas (hampir cukup panjang untuk mengelilingi lengan)
3. Jika tensimeter itu jenis aneroid, lakukanlah kalibrasi secara berkala sebelum digunakan .

Teknik Pengukuran. Sebelum mengukur tekanan darah, ada beberapa Langkah yang harus Anda lakukan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran yang Anda lakukan akurat. Setelah langkah - langkah ini dilakukan, Anda siap mengukur tekanan darah. Teknik pengukuran yang benar merupakan hal penting dan mengurangi variabilitas yang dapat ditimbulkan oleh pasien, pemeriksa, alat dan prosedur itu sendiri.

Teknik Pemeriksaan Tekanan Darah

1. Idealnya, minta kepada pasien untuk menghindari rokok atau minuman yang mengandung kafein selama 30 menit sebelum tekanan darah diukur dan beristirahat selama sedikitnya 5 menit.
2. Lakukan pengecekan untuk memastikan bahwa ruang periksa bener – bener terang dan hangat.
3. Pastikan bahwa lengan yang akan diperiksa tidak terbungkus pakaian. Tidak boleh ada *fistula arteriovenosa* untuk dialysis, sikatriks bekas insisi arteri brakialis, atau tanda - tanda limfedema (terlihat sesudah diseksi kelenjar limfe aksilaris atau terapi radiasi).
4. Lakukan palpasi arteri brakialis untuk memastikan bahwa arteri tersebut benar – benar memiliki denyut yang aktif.
5. Atur posisi lengan sedemikian rupa agar arteri brakialis pada fosa antekubiti terletak setinggi jantung yang secara kasar berada pada ruang sela iga ke – 4 pada titik pertemuannya dengan *os sternum*.

6. Jika pasien duduk, letakkan lengannya pada meja yang sedikit lebih tinggi daripada pinggang pasien; jika pasien berdiri, cobalah meyangga lengan pasien setinggi bagian Tengah dadannya.
7. Sekarang pemeriksa siap mengukur tekanan darah. Pasanglah balon manset yang bisa digembungkan tepat di Tengah arteri brakialis. Batas bawah manset harus sekitar 2,5 cm diatas fosa antekubiti. Pasang manset tensimeter dengan pas, atur posisi lengan pasien dalam kedudukan agak fleksi pada sendi sikunya.
8. Untuk menentukan seberapa tinggi tekanan dalam manset harus dinaikkan, pertama perkirakan tekanan sistolik melalui palpasi, Ketika denyut arteri radialis pasien sudah teraba dengan jari – jari dari salah satu tangan pemeriksa, pompa dengan cepat manset tensimeter sampai denyut arteri radialis tersebut tidak teraba lagi.
9. Baca tekanan ini pada manometer dan tambahkan 30 mmHg pada angka yang terlihat. Gunakan penjumlahan angka ini sebagai target agar pemompaan manset berikutnya tidak menimbulkan gangguan kenyamanan karena tekanan manset yang terlalu tinggi.
10. Penggunaan angka tersebut juga akan menghindari kesalahan yang kadang – kadang terjadi karena jeda (gap) auskultatori – masa jeda (interval) tanpa suara yang dapat terjadi di antara tekanan sistolik dan diastolik.
11. Kempiskan manset dengan segera sampai benar – benar kempis dan tunggu selama 15 hingga 30 detik.
12. Kini letakkan stetoskop pada bagian bell dengan tekanan yang ringan di daerah arteri brakialis; perhatikan agar tidak ada udara yang masuk ke dalam sungkup stetoskop (kedap udara) dengan menahan sungkup sedemikian rupa sehingga seluruh bingkainnya tertekan pada kulit. Karena bunyi yang terdengar (*bunyi Korotkoff*) merupakan nada yang relative rendah, bunyi *Korotkoff* tersebut lebih jelas didengar dengan stetoskop (*bell*).
13. Sekali lagi, pompa manset dengan cepat untuk melawan tinggi tekanan (*level*) yang baru saja di tentukan dan kemudian kempiskan secara perlahan – lahan dengan kecepatan sekitar 2 hingga 3 mmHg per detik. Perhatikan tinggi tekanan saat Anda mendengar sedikitnya dua bunyi denyutan yang berturutan. Tinggi tekanan ini merupakan tekanan sistolik.
14. Lanjutkan penurunan tekanan tersebut dengan perlahan sampai bunyi yang terdengar menjadi redup dan kemudian menghilang. Untuk memastikan saat hilangnya bunyi tersebut, dengarkan ketika tekanan diturunkan sebesar 10 hingga 20 mmHg lagi. Kemudian, kempiskan manset dengan cepat hingga angka 0. Titik hilangnya bunyi yang terdengar itu, yang biasanya hanya beberapa mmHg

di bawah titik terdengarnya bunyi yang redup, merupakan estimasi yang paling tepat untuk tekanan diastolic pada orang dewasa.

15. Baca tinggi tekanan sistolik ataupun diastolik dengan kisaran nilai paling dekat nilai paling dekat 2 mmHg. Tunggu 2 menit atau lebih, dan ulangi pembacaan atau pengukuran ini. Kemudian tentukan rata – rata hasil pengukuran Anda. Jika di antara dua pengukuran terdapat selisih yang melebihi 5 mmHg, lakukan pengukuran tambahan.
16. Ketika menggunakan tensimeter air raksa, jaga agar manometernya berada dalam posisi vertikal (kecuali jika Anda menggunakan model lantai yang miring) dan upayakan agar pembacaan angkanya dilakukan dengan mata setinggi meniskus air raksa. Jika Anda menggunakan tensimeter aneroid,nletakkan lempengannya (yang memperlihatkan angka pengukuran) sedemikian rupa sehingga menghadap ke arah Anda. Hindari pemompaan manset yang lambat atau berkali – kali karena kongesti darah vena yang ditimbulkannya dapat memberikan hasil pengukuran yang salah.
17. Tekanan darah harus diukur pada kedua lengan paling tidak sebanyak satu kali. Normalnya, terdapat perbedaan tekanan sebesar 5 mmHg dan kadang dapat sampai 10 mmHg. Pengukuran berikutnya harus dilakukan pada lengan dengan tekanan darah yang lebih tinggi.
18. Pada pasien yang menggunakan oabt – obat antihipertensi atau yang memiliki Riwayat sinkop, pening ketika berdiri (*postural dizziness*) atau mungkin deplesi volume darah, lakukanlah pengukuran tekanan darah dalam tiga posisi – berbaring, telentang, duduk dan berdiri (kecuali jika terdapat kontra indikasi). Normalnya, Ketika pasien berubah posisi dari posisi horizontal ke posisi berdiri, tekanan sistolik akan turun sedikit naik. Pengukuran lain yang dilakukan setelah berdiri selama 1-5 menit dapat menunjukkan hipotensi ortostatik yang terlewatkan oleh pengukuran sebelumnya. Pengulangan pengukuran tekanan darah ini terutama berguna pada orang – orang yang berusia lanjut.
19. Letakkan lempengannya (yang memperlihatkan angka pengukuran) sedemikian rupa sehingga menghadap ke arah Anda. Hindari pemompaan manset yang lambat atau berkali – kali karena kongesti darah vena yang ditimbulkannya dapat memberikan hasil pengukuran yang salah.
20. Tekanan darah harus diukur pada kedua lengan paling tidak sebanyak satu kali. Normalnya, terdapat perbedaan tekanan sebesar 5 mmHg dan kadang dapat sampai 10 mmHg. Pengukuran berikutnya harus dilakukan pada lengan dengan tekanan darah yang lebih tinggi.
21. Pada pasien yang menggunakan oabt – obat antihipertensi atau yang memiliki Riwayat sinkop, pening ketika berdiri (*postural dizziness*) atau mungkin deplesi

volume darah, lakukanlah pengukuran tekanan darah dalam tiga posisi – berbaring, telentang, duduk dan berdiri (kecuali jika terdapat kontra indikasi). Normalnya, Ketika pasien berubah posisi dari posisi horizontal ke posisi berdiri, tekanan sistolik akan turun sedikit naik. Pengukuran lain yang dilakukan setelah berdiri selama 1-5 menit dapat menunjukkan hipotensi ortostatik yang terlewatkan oleh pengukuran sebelumnya. Pengulangan pengukuran tekanan darah ini terutama berguna pada orang – orang yang berusia lanjut.

Jika arteri brakialis berada jauh di bawah tinggi jantung, pengukuran tekanan darah akan memberikan hasil tinggi yang salah. Upaya pasien sendiri untuk menyangga lengannya dapat menaikkan tekanan darah. Manset yanng longgar atau kantong manset dengan balon yang keluar akan memberikan hasil tinggi yang salah. Jeda auskultatori (*auscultatory gap*) yang tidak dikenali dapat menyebabkan estimasi tekanan sistolik yang rendah (misalnya 150/98 pada contoh dibawah) atau estimasi tekanan diastolik yang tinggi. Jika Anda menemukan jeda auskultatori, catatlah hasil pengukuran Anda dengan lengkap (misalnya, 200/98) dengan jeda auskultatori 170 – 150).Pada sebagian orang, titik redup dan hilangnya bunyi terpisah dengan jarak yang lebih jauh. Kadang – kadang bunyi tersebut tidak pernah menghilang, seperti pada regurgitasi aorta. Jika terdapat perbedaan yang melebihi 10 mmHg, catat kedua angkanya (missal 154/80/68). Dengan menyebabkab bunyinya tidak begitu terdengar, kongesti darah vena dapat menimbulkan tekanan sistolik palsu yang rendah dan tekanan diastolic yang tinggi. Perbedaan tekanan yang melebihi 10 – 15 mmHg menunjukkan kemungkinan kompresi atau obstruksi arteri pada sisi tubuh yang tekanannya lebih rendah. Penurunan tekanan sistolik sebesar 20 mmHg atau lebih, khususnya jika disertai dengan gejala, menunjukkan hipotensi ortostatik (postural) penyebabnya meliputi obat – obatan, kehilangan darah, Tirah baring yang lama, dan penyakit pada sistem saraf otonom.

Definisi Tekanan Darah yang Normal dan Abnormal. Pada tahun 1997, *the Joint Committee on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure* merekomendasikan bahwa diagnosis hipertensi hanya boleh ditetapkan jika tekanan darah seseorang lebih tinggi daripada nilai normal pada sedikitnya dua kali kunjungan klinik atau lebih sesudah skrinning awal. Salah satu saja di antara tekanan darah diastolic atau tekanan darah sistolik dapat dinyatakan tinggi, untuk orang dewas (berusia 18 tahun atau lebih), komite tersebut menyusun enam tingkat kategori untuk tekanan diastolic dan sistolik.

Klasifikasi Tekanan Darag (pada Orang Dewasa)

Kategori	Sistolik (mmHg)	Diastolik (mmHg)
Hipertensi		
Stadium 3 (berat)	≥180	≥110
Stadium 2 (sedang)	160-179	100-109
Stadium 1 (ringan)	140-159	90-99
Normal Tinggi	130-139	85-89
Normal	≤130	<85
Optimal	<120	<80

Ketika tinggi tekanan sistolik dan diastolik menunjukkan kategori yang berbeda, gunakan kategori yang lebih tinggi. Sebagai contoh, 170/92 mmHg merupakan hipertensi sedang dan 170/120 mmHg merupakan hipertensi berat. Pada *isolated systolic hypertension*, tekanan sistolik Adalah 140 mmHg atau lebih sedangkan tekanan diastolic nya kurang dari 90 mmHg. Pemeriksaan hipertensi juga meliputi akibatnya pada organ – mata, jantung, otak dan ginjal. Carilah tanda yang membuktikan adanya retinopati hipertensi, hipertrofi ventrikel, dan gangguan neurologi yang menunjukkan kemungkinan stroke. (Pemeriksaan ginjal memerlukan urinalisis dan tes darah. Interpretasi tekanan darah yang relative rendah harus selalu dilakukan dengan memperhatikan hasil pengukuran yang dahulu dan keadaan klinik pasien yang sekarang. Tekanan darah 110/70 biasanya dianggap normal, tetapi juga dapat menunjukkan keadaan hipotensi yang signifikan jika pasien memiliki Riwayat tekanan darah yang tinggi.

Permasalahan Khusus

Pasien yang Cemas. Kecemasan (ansietas) merupakan penyebab tekanan darah tinggi yang sering dijumpai, khususnya pada kunjungan pasien yang pertama. Cobalah untuk membuat pasien rileks, ulangi Kembali pengukuran tekanan darahnya pada pemeriksaan pertama tersebut. Sebagian pasien akan mengatakan bahwa tekanan darah mereka hanya meningkat Ketika beberapa kali pengukuran Ketika mereka berada di rumah atau lingkungan Masyarakat.

Lengan yang Gemuk atau Kurus. Untuk lengan yang gemuk, harus menggunakan manset yang lebar (15 cm). jika lingkaran lengan melebihi 41 cm , harus menggunakan manset paha (lebar 18 cm). untuk lengan yang sangat kurus, dapat menggunakan manset pediatrik.

Denyut Nadi dan Tekanan Darah Tungkai. Untuk menyingkirkan kemungkinan koarktasio aorta, harus dilakukan dua observasi yang setidaknya dilakukan satu kali pada setiap hipertensi:

1. Bandingkan Volume dan saat terabanya denyut nadi radialis dengan denyut nadi femoralis
2. Bandingkan tekanan darah pada lengan dengan pada tungkai

Untuk menentukan tekanan darah pada tungkai, gunakan manset paha yang lebar dan panjang dengan ukuran balon 18 × 42 cm, dan pasang manset tersebut pada bagian pertengahan pada pasien. Tempatkan balonnya tepat di tengah pada permukaan posterior paha, lingkarkan manset dengan erat dan dengarkan bunyi denyut arteru poplitea. Jika mungkin, pasien harus berbaring telungkup. Sebagai alternatif lain, minta kepada pasien yang berbaring telentang untuk sedikit memfleksikan salah satu tungkainya, sementara bagian tumit diletakkan pada tempat tidur. Jika manset yang dipakai pada tungkai lenga n itu memiliki ukuran yang sesuai, tekanan darah ahrus sama pada kedua daerah tersebut. (Jika manset yang biasa dipakai pada lengan digunakan pada tungkai, akan diperoleh hasil pengukuran tinggi yang salah (*falsely high*)). Tekanan sistolik yang lebih rendah pada tungkai dibandingkan pada lengan merupakan keadaan yang abnormal.

Denyut nadi femoralis yang lebih kecil dan lebih lambat daripada denyut nadi radialis menunjukkan kemungkinan koartasio aorta atau penyakit oklusif aorta. Dalam kondisi ini tekanan darah pada tungkai lebih rendah dibandingkan tekanan darah pada lengan.

Bunyi *Korotkoff* yang Lemah atau Tidak Terdengar. Pikirkan persoalan teknis seperti penempatan stetoskop yang salah, kegagalan membuat bell stetoskop kontak sepenuhnya dengan kulit, kongesti darah vena dalam lengan akibat pemompaan manset yang berkali kali. Pertimbangkan pula kemungkinan terjadinya syok. Jika Anda tidak dapat mendengar bunyi Korotkoff sama sekali, Anda mungkin dapat memperkirakan tekanan sistolik melauli palpasi. Metode alternatif lain seperti teknik Doppler atau *tracing* langsung tekanan arteri mungkin diperlukan. Untuk memperkeras bunyi Korotkoff, satu diantara teknik berikut ini mungkin dapat membantu:

1. Tinggikan lengan pasien sebelum dan selama memompa manset. Kemudian, turunkan lengannya dan tekanan ukuran tekanan darahnya.
2. Pompa manset. Minta pasien untuk mengepalkan tangannya beberapa kali dan kemudian tentukan ukuran tekanan darahnya.

Aritmia. Irama yang tidak teratur menimbulkan variasi tekanan dan dengan demikian pengukurannya tidak dapat diandalkan. Abaikan efek kontraksi jantung prematur (*premature heart beat)* yang terkadang timbul. Pada kontraksi prematur

yang seringa tau pada fibrilasi atrium, tentukan rata – rata hasil observasi dan buat catatan bahwa hasil pengukuran Anda Adalah nilai perkiraan.

1. Frekuensi dan Irama Jantung

Dengan meraba denyut nadi arteri, Anda dapat menghitung frekuensi detak jantung dan menentukan iramanya, menilai amplituo, dan kontur gelombang denyut nadi tersebut, dan terkadang mendeteksi obstruksi aliran darah.

Frekuensi Jantung *(Heart Rate).* Umum nya digunakan denyut nadi (pulsus) radialis untuk menentukan frekuensi jantung. Dengan permukaan ventral jari telunjuk dan jari tengah tangan Anda, tekan arteri radialis sampai terasa palpasi yang maksimal. Jika iramanya teratur dan frekuensinya terasa normal, hitung frekuensi denyut arteri radialis selama 15 detik dan kemudian kalikan perhitungan ini dengan 4. Namun, jika kecepatannya sangat tinggi atau rendah yang abnormal, hitung frekuensi denyut nadi arteri tersebut selama 60 detik.

Jika iramanya tidak teratur (ireguler), hasil penguatan denyut nadi radialis ini harus dievaluasi dengan auskultasi jantung, karena denyut yang timbul lebih awal daripada denyut berikutnya mungkin tidak terdeteksi secara perifer dan dengan demikian akan terjadi frekuensi detak jantung serius yang disepelekan.

Irama. Untuk memulai pemeriksaan irama jantung, raba denyut nadi radialis. Jika terdapat ketidakteraturan atau iregularitas, periksalah irama tersebut sekali lagi dengan menggunakan stetoskop Anda pada daerah apeks kordis. Apakah iramana teratur atau tidak? Jika tidak teratur, cobalah untuk mengenali polanya : (1) Apakah detak awal terdengar pada irama dasar yang teratur? (2) Apakah ketidaksetaraan itu bervariasi secara konsisten dengan respirasi? (3) Apakah iramanya sama sekali tidak teratur. Irama yang ireguler meliputi fibrilasi atrium dan kontraksi premature atrium atau vetrikel. Palpasi dengan irama ireguler yang tidak teratur merupakan indikasi fibrilasi atrium yang dapat diandalkan. Untuk semua pola ireguler lainnya diperlukan pemeriksaan EKG untuk mengenali jenis aritmia.

Abnormalitas pada Denyut Nadi Arteri dan Gelombang Tekanan

Normal:

Besar tekanan nadi sekitar 30 – 40 mmHg. Kontur denyut nadi Adalah bulat dan rata (*smooth*), (Takik (*notch*) pada garis gelombang yang menurun tidak teraba.)

Denyut Nadi yang Kecil, Lemah:

Tekanan nadi menghilang dan denyut nadi teraba lemah serta kecil. Mungkin *upstroke* terasa lambat, puncaknya memanjang. Penyebab denyut nadi yang kecil dan lemah adalah (1) penurunan volume sekuncup (*stroke volume*), seperti yang terjadi pada gagal jantung, hipovolemiaserta stenosis aorta yang berat, dan (2) peningkatan tahanan perifer seperti terjadi pada pajanan dengan hawa dingin dan gagal jantung kongesif yang berat.

Denyut Nadi yang Besar, Meloncat:

Tekanan nadi meningkat dan denyut nadi terasa kuat serta meloncat. Naik turunnya mungkin terasa cepat, puncaknya singkat. Penyebab denyut nadi yang besar dan meloncat Adalah: (1) peningkatan volume sekuncup, penurunan tahanan perifer atau keduanya seperti terjadi pada demam, anemia, hipertiroidisme, reguritasi aorta, fistula arteriovenosa, dan ductus persisten (*Patent Ductus Arteriosus*). (2) penin- gkatan volume sekuncup akibat frekuensi jantung yang lambat seperti terjadi pada bradikardia serta blok jantung total (*complete heart block*), dan (3) penurunan kelenturan (peningkatan rigiditas) pada dinding aorta seperti terjadi pada penuaan atau aterosklerosis.

Pulsus Bisferiens:

Pulsus bisferiens merupakan peningkatan denyut nadi arteri dengan puncak sistolik yang ganda. Penyebabnya meliputi regurgitasi aorta yang murni, kombinasi stenosis dengan regurgitasi aorta, dan kardiomiopati hipertrofik walaupun yang terakhir ini tidak begitu sering teraba.

Pulsus Alternans:

Pada keadaan ini, amplitude denyut nadi berubah – ubah antara denyut yang satu dan denyut berikutnya kendati irama jantung pada dasarnya masih reguler (yang merupakan syarat yang wajib dipenuhi jika Anda akan membuat diagnosis pulsus alternans). Jika perbedaan antara denyut yang terkuat dan yang terlemah sangat kecil, keadaan ini hanya dapat terdeteksi lewat sfigmomanometri (pemeriksaan dengan tensimeter). Pulsus alternans menunjukkan gagal jantung kiri dan biasanya disertai dengan bunyi S_3 sisi kiri.

Pulsus Bigeminus:

Keadaan ini merupakan kelainan irama yang memberikan Kesan seolah – olah pulsus alternans, pulsus bigeminus terjadi karena denyut nadi yang normal diselingi oleh kontraksi prematur. Volume sekuncup pada denyut prematur tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan volume sekuncup pada denyut normal, dan dengan demikian amplitudo denyut nadinya akan bervariasi.

Pulsus Paradoksus:

Pulsus paradoktus dapat dideteksi melalui penurunan amplitude denyut nadi yang dapat diraba pada inspirasi yang tenang. Jika tanda ini tidak begitu nyata, maka diperlukan pemeriksaan dengan menggunakan manset tensimeter untuk mendiagnosisnya. Tekanan sistolik menurun sebanyak lebih dari 10 mmHg pada saat inspirasi. Pulsus paradoksus ditemukan pada tamponade pericardium. Pericarditis konstriktif (kendati tidak begitu sering dijumpai) dan penyakit paru obstruktif. (Lynn, 2012)

C. Frekuensi dan Irama Pernapasan

Perhatikan frekuensi pernapasan (*respiratory rate*), irama, dalamnya pernapasan, dan upaya bernapas. Hitung jumlah respirasi selama satu menit dengan inspeksi visual atau dengan mendengarkan bunyi pernapasan pada trakea.

Teknik Pemeriksaan

1. Pasien dengan stetoskop ketika pemeriksa memeriksa bagian kepala dan leher atau bagian dada. Normalnya, orang dewasa akan menarik napas sebanyak 14 – 20 kali per menit dengan pola regular tanpa mengeluarkan suara.
2. Tarikan napas dalam (menghela napas) yang terkadang terjadi merupakan keadaan normal. Lakukan pengecekan untuk melihat apakah ekspirasi memanjang. Ekspresi yang memanjang menunjukkan penyempitan bronkiolus.

Frekuensi dan Irama Jantung Tertentu

Irama jantung dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu reguler (teratur) atau ireguler (tidak teratur). Jika iramanya ireguler atau frekuensi jantung cepat atau lambat, diperlukan EKG untuk mengenali asal denyut jantung tersebut (*sinus node*, nodus AV, atrium, atau ventrikel) dan pola hantarannya. Perhatikan bahwa pada keadaan blok atrioventrikuler (*AV block*), dapat terjadi aritmia dengan frekuensi ventrikel yang cepat, normal, atau lambat.

Apakah Iramanya Reguler atau Ireguler?

1. Reguler, Frekuensinya:
   a. Cepat (>100)
      Pola EKG dan Frekuensi Istirahat Normal:
      1) Sinus takikardi (100 – 180)
      2) Takikardi supraventikuler (atrial atau nodal) (150 – 250)
      3) *Flutter* atrial dengan respons ventrikel yang reguler (100 – 175)
      4) Takiakrdia ventrikuler (110 – 250)
   b. Normal (60 – 100)
      Pola EKG dan Frekuensi Istirahat Normal:
      1) Irama sinus yang normal (60 – 100)
      2) AV blok derajat dua (60 – 100)
      3) *Flutter* atrial dengan respons ventrikel yang reguler (75 – 100)
   c. Lambat (<60)
      Pola EKG dan Frekuensi Istirahat Normal:
      1) Sinus bradikardia (<60)
      2) AV blok derajat dua (30 – 60)
      3) Blok jantung total (*complete heart block*) (< 40)
2. Ireguler, Iregularitasnya:
   a. Ireguler Berirama / Sporadis:
      Pola EKG:
      1) Denyut nadi, Kontraksi prematur atrial atau nodal (supraventikuler)
      2) Sinus aritmia, Kontraksi prematur ventrikel (VPB, VES)
   b. Ireguler Total:
      Pola EKG:
      1) Fibrilasi atrium (*atrial fibrillation*)
      2) *Flutter* atrial dengan berbagai blok
3. Irama Jantung Ireguler
   Tipe irama,
   a. Kontraksi Prematur Atrial atau Nodal (*Supraventikular*)
      Irama: Denyut yang berasal dari atrium atau *sinus node* timbul lebih awal daripada denyut normal berikutnya. Diikuti satu masa istirahat (*pause*), dan kemudian irama jantung muncul kembali.
      Bunyi Jantung: Intensitas S_1 pada denyut prematur ini mungkin berbeda dengan intensitas S_1 pada denyut normal, dan intensitas S_2 mungkin menurun. Jika tidak, kedua bunyi tersebut akan terdengar serupa dengan bunyi pada denyut normal.

b. Kontraksi Ventrikel Prematur

Irama: Denyut yang berasal dari ventrikel timbul lebih awal daripada denyut normal berikutnya. Diikuti satu masa istirahat (*pause*), dan kemudian irama jantung muncul Kembali.

Bunyi Jantung: Intensitas S_1 pada denyut prematur ini mungkin berbeda dengan intensitas S_1 pada denyut normal, dan intensitas S_2 mungkin menurun. Kedua bunyi tersebut kemungkinan besar akan terpecah (*split*) .

c. Sinus Aritmia dan Fibrilasi Atrial

Irama: Denyut jantung bervariasi secara siklus dan biasanya bertambah cepat pada saat inspirasi serta melambat pada saat ekspirasi.

Bunyi Jantung: Bunyi jantung normal walaupun bunyi S_1 mungkin bervariasi mengikuti frekuensi jantung.

d. *Flutter* Atrial dengan AV Blok yang Bervariasi

Irama: Irama ventrikel sama sekali tidak teratur (ireguler total) walaupun Gerakan pendek irama ventrikel yang ireguler dapat terlihs reguler.

Bunyi Jantung: Intensitas S_1 bervariasi.

Abnormalitas pada Frekuensi dan Irama Pernapasan

Ketika mengamati pola respirasi, pikirkanlah pernapasan pasien dalam hal frekuensi (*rate*), dalam (*depth*) dan keteraturannya (*regularity*). Uraikan apa yang anda lihat mengenai hal ini. Istilah yang tradisional, seperti takipnea, diberikan dibawah ini agar anda memahaminya, tetapi kami menganjurkan untuk menggunakan deskripsi yang sederhana.

1. Normal: Frekuensi resepirasi sekitar 14 – 20 kali per menit pada orang dewasa yang normal hingga 44 kali per menit pada bayi.
2. Pernapasan Cepat dan Dangkal (*Takipnea*): Pernapasan yang cepat dan dangkal disebabkan oleh sejumlah keadaan yang meliputi penyakit paru restriktif, nyeri pleuritic dada dan elevasi diafragma.
3. Pernapasan Cepat dan Dalam (*Hiperpnea, Hiperventilasi*): Pernapasan cepat dan dalam disebabkan oleh beberapa keadaan yang meliputi olahraga, kecemasan (ansietas), dan asidosis metabolic. Pada pasien yang koma, pertimbangan kemungkinan infark, hipoksia, atau hipoglikemi yang berakibat terhadap *midbrain* atau pons. *Pernapasan Kussmaul* Adalah pernapasan yang dalam akibat asidosis metabolik. Frekuensi pernapasan ini bisa cepat, normal, atau lambat.
4. Pernapasan Lambat (*Bradipnea*) :Pernapasan yang lambat dapat terjadi sekunder karena penyebab seperti koma diabetic, depresi pernapasan yang ditimbulkan oleh obat, dan peningkatan tekanan intracranial.

5. Pernapasan Cheyne – Stokes: Periode pernapasan dalam yang diselingi dengan periode apnea (periode tidak bernapas). Anak anak dan manula secara normal memperlihatkan pola ini pada waktu tidur. Penyebab lainnya meliputi gagal jantung, uremia, depresi pernapasan yang ditimbulkan oleh obat dan kerusakan otak (secara tipikal pada kedua sisi hemisfer serebri atau diensefalon).
6. Pernapasan Ataksia (*Biot's Breathing*): Pernapasan ataksia ditandai oleh iregularitas yang tidak dapat diramalkan. Pernapasannya dapat dalam atau dangkal dan berhenti sesaat. Penyebab nya meliputi depresi pernapasan dan kerusakan otak yang secara tipikal terjadi pada level mendula (oblongata).
7. Respirasi Menghela Napas (*Sighing Respiration*): Pernapasan yang diselingi dengan helaan napas yang sering harus membuat Anda mewaspadai kemungkinan sindrom hiperventilasi – penyebab keluhan sesak nafas dan pusing yang sering dijumpai. Helaan napas yang terjadi kadang – kadang merupakan keadaan normal.
8. Pernapasan Obstruktif: Pada penyakit paru obstruktif terjadi ekspirasi yang memanjang karena penyempitan saluran napas meningkatkan tahanan terhadap aliran udara. Penyebabnya meilputi penyakit asma, bronchitis kronis dan PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronik). (Lynn, 2012)

D. Suhu Tubuh

Meskipun mungkin akan memilih untuk mengabadikan pemeriksaan suhu tubuh pada pasien rawat jalan, suhu tubuh harus dicek jika dicurigai adanya kelainan. *Suhu oral* rata rata biasanya ditetapkan pada 37 °C (98,6 °F) dan suhu ini cukup berfluktuasi. Pada pagi hari, suhu tubuh dapat turun sampai 35,8 °C (96,4 °F), dan pada senja hari (menjelang malam) atau malam harinya suhu tubuh dapat naik sampai 37,3 °C (99,1 °F). *Suhu rektal* lebih tinggi daripada suhu oral dan selisihnya rata – rata sebesar 0,4 – 0,5 ° C (0,7 – 0,9 °F), tetapi perbedaan ini juga cukup bervariasi (Sebaliknya,*suhu aksila* lebih rendah daripada suhu oral yang selisihnya lebih kurang 1 °, tetapi memerlukan pengukuran selama 5 – 10 menit dan umumnya dianggap kurang akurat dibandingkan cara – cara pengukuran lainnya.

Sebagian besar pasien menyukai pengukuran suhu oral daripada rektal. Namun, pengukuran suhu oral tidakdianjurkan pada pasien yang tidak sadarkan diri, gelisah, atau tidak dapat menutup mulutnya. Hasil pengukuran suhu oral mungkin tidak akurat dan termometernya dapat pecah karena gerakan rahang pasien yang tidak terduga.

Untuk mengukur suhu oral, dapat memilih termometer kaca atau elektronik. Jika menggunakan termometer kaca, guncangkan dahulu termometer tersebut agar garis air raksanya turun hingga 35 °C (96 °F) atau kurang. Kemudian letakkan ujung

termometer dibawah lidah, minta kepada pasien untuk merapatkan kedua bibirnya dan tunggu selama 3 - 5 menit. Kemudian baca hasil yang didapat pada termometer, masukkan kembali selama 1 menit, dan baca kembali hasilnya. Jika suhunya tetap meninggi, ulangi prosedur ini sampai hasil pembacaannya tidak berubah lagi. Perhatikan bahwa cairan yang panas atau dingin dan bahkan merokok dapat mengubah hasil pengukuran. Pada hari ini, sebaiknya pengukuran suhu tubuh ditunda dahulu selama 10 – 15 menit.

Jika menggunakan termometer elektronik, dengan hati – hati pasangkan dahulu plastic penutup yang disposable pada ujung tersebut di bawah lidah. Minta kepada pasien untuk merapatkan kedua bibirnya dan kemudian amati dengan cermat hasil pengukuran dalam bentuk angka – angka digital yang tertera pada layer. Biasanya pemeriksaan suhu yang akurat memerlukan waktu selama 10 detik.

Untuk mengukur *suhu rektal*, minta kepada pasien untuk berbaring miring dengan sendi paha difleksikan. Pilih thermometer rektal dengan bagian ujung yang pendek, lumasi ujung ini dan masukkan selama 3 – 4 cm (1 ½ inci) ke dalam saluran anus dengan arah yang menuju umbilicus. Cabut ujung termometer setelah didiamkan 3 menit, kemudian baca hasil pengukurannya. Sebagai alternatif lain, gunakan termometer elektronik dengan penutup ujung probe yang telah dilunasi. Tunggu selama sekitar 10 detik sampai muncul angka digital yang menunjukkan hasil pengukuran suhu.

Demam atau preksia diartikan sebagai kenaikan suhu tubuh *hiperpireksia* mengacu pada kenaikan suhu yang ekstrim, yaitu diatas 41,1 °C (106 °F), sedangkan *hiportemia* mengacu pada suhu abnormal yang rendah, yaitu dibawah 35 °C (95 °F); pada pengukuran suhu per rektal. Penyebab *demam* meliputi infeksi, trauma (seperti pembedahan atau *crush injuries*), malignasi, kelainan darah (seperti anemia hemolitik akut), reaksi obat dan kelainan imun (seperti penyakit vascular kolagen).

Penyebab utama *hipotemia* adalah pajanan terhadap hawa dingin. Faktor presdiposisi lainnya meliputi gerakan yang berkurang seperti pada paralisis, gangguan karena vasokonstriksi seperti akibat sepsis atau pemakain alkohol yang berlebihan, kelaparan, hipoturoidisme dan hipoglikemia. Manula merupakan kelompok pasien yang rentan terhadap hipotermia dan juga memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk mengalami demam.(Lynn, 2012)

Teknik Pemeriksaan

1. Pengukuran *suhu membran timpani* kini semakin banyak dikerjakan dan merupakan cara pengukuran yang cepat, aman, serta dapat diandalkan jika dilaksanakan dengan benar.
2. Pastikan bahwa di dalam kanalis auditorius eksterna tidak terdapat serumen.
3. Atur posisi ujung (*probe*) di dalam kanalis auditorius agar pancaran sianr inframerah tertuju ke membrane timpani (jika tidak, hasil pengukurannya tidak sahih).
4. Tunggu selama 2 – 3 detik sebelum sampai angka digital yang menunjukkan hasil pengukuran suhu. Metode ini mengukur suhu inti tubuh (*body core temperature*) yang lebih tinggi sekitar 0,8 °C (14 °F) bila dibandingkan dengan suhu oral yang normal.
5. Frekuensi pernapasan yang cepat cenderung memperbesar perbedaan antara suhu oral dan rektal. Pada situasi ini, suhu rektal lebih dapat diandalkan. (Lynn, 2012)

E. Denyut Nadi

Menghitung denyut nadi dengan cara meraba:

1. Arteri radialis pada pergelangan tangan
2. Arteri brachialis pada siku bagian dalam
3. Arteri carotis pada leher
4. Arteri temporalis pada pelipis
5. Arteri femoralis pada lipatan pada (selangkangan)
6. Arteri dorsalis padis pada kaki
7. Arteri frontalis pada ubunn-ubunn (bayi)

Tujuan

Untuk mengetahui jumlah denyut nadi atau kardiovaskuler selama satu menit.

PERLENGKAPAN DAN PERALATAN

1. Arloji tangan dengan penunjuk detik atau dengan polsteller
2. Buku catatan suhu dan nadi

PELAKSANAAN

1. Menghitung denyut nadi dilakukan bersamaan dengan pengukuran suhu
2. Pada waktu menghitung denyut nadi, pasien harus benar – benar istirahat dalam posisi berbaring atau duduk
3. Penghitungan dilakukan dengan menempelkan jari telunjuk dan jari tengah di atas arteri selama setengah menit, dan hasilnya dikalikan dua
4. Khusus pada anak-anak penghitungan dilakukan selama satu menit
5. Hasil penghitungan dicatat pada buku catatan suhu dan nadi(Istichomah, 2021)

F. Referensi

Dr. Mecedes de onis, Dr. leila Cheikh Ismail, P. C. C. (2012). *International Fetal and Newborn Growth Standards for the 21 st Century*. *April*, 1–59.

Istichomah. (2021). *Modul Praktikum Keperawatan Dasar II*. Media sains Indonesia.

Lynn, B. (2012). *Buku Ajar Pemeriksaan Fisik dan Riwayat Kesehatan*. EGC.

NIHR. (2017). *NIHR Southampton Biomedical Research Centre Procedure for Measuring*. *April 2015*, 1–4.

Sahyoun, N. R., Maynard, L. M., Zhang, X. L., & Serdula, M. K. (2008). FACTORS ASSOCIATED WITH ERRORS IN SELF-REPORTED HEIGHT AND WEIGHT IN OLDER ADULTS. *The Journal of Nutrition, Health and Aging*, *12*(2), 108–115. https://doi.org/10.1007/BF02982562

PROFIL PENULIS



Kristy Mellya Putri, SST., Bdn., M.Kes, lahir di Nipah Panjang pada tanggal 1 Juli 1990. Riwayat Pendidikan : SMA N 5 Kota Jambi lulus tahun 2008, memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan dari Poltekkes Kemenkes Jambi tahun 2011, memperoleh gelar Sarjana Sains Terapan Program Studi Diploma IV Bidan Pendidik dari Universitas Respati Yogyakarta tahun 2013, memperoleh gelar Magister Kesehatan Masyarakat perminatan Kesehatan Reproduksi dari Universitas Respati Indonesia tahun 2015, memperoleh gelar Profesi Bidan di Poltekkes Kemenkes Jambi tahun 2022. Riwayat Pekerjaan: Dosen tetap di Akbid Jakarta Mitra Sejahtera dari 2013-2021, Dosen tetap Program Studi Pendidikan Diploma III Kebidanan Tahun 2021 dan Pendidikan Profesi Bidan dari 2022 sampai sekarang di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Adiwangsa Jambi, telah lulus Sertifikasi Dosen. Penulis juga aktif dalam Tridarma Perguruan Tinggi serta keikutsertaan dalam Organisasi Ikatan Bidan Indonesia di Kota Jambi. Adapun buku yang sudah di tulis diantaranya Asuhan Kebidanan, Pendidikan Ilmu Kebidanan, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Digitalisasi Dalam Perawatan Kesehatan, Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi, Ibu dan Anak, Pengantar Ilmu Kebidanan dan Etikolegal dalam Praktik Kebidanan, Keperawatan Maternitas dan Keluarga Berencana, Kesehatan Wanita dan Kesehatan Reproduksi, Kebidanan Dasar, psikologi Dalam Praktik Kebidanan, Perilaku Kesehatan dan Promosi Kesehatan, Asuhan Persalinan, Patologi Kebidanan, Metodologi Riset Kesehatan (Teori dan Aplikasi), Kumpulan Soal UKOM Kebidanan Berstandar Nasional Berbasis Kasus dan Pembahasan Mendalam. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: kristymellyaputri@rocketmail.com

Motto: "Keselamatan adalah prioritas, pencegahan infeksi adalah tanggung jawab, dan pelayanan berkualitas adalah tujuan setiap bidan profesional. Kompetensi klinis dibangun melalui pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, dan budaya keselamatan pasien. "

PROFIL PENULIS



Sri Musfiroh, S.Si.T., M.Kes., Lahir di Grobogan, 05 Maret 1970. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 pada Program Studi Kebidanan Poltekkes Tasikmalaya dan lulus tahun 2005, kemudian melanjutkan ke jenjang D4 Program Studi Sarjana Sains Terapan Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju Jakarta dan lulus tahun 2007. Selanjutnya, penulis menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Respati Indonesia pada tahun 2013. Riwayat pekerjaan penulis dimulai setelah lulus D3 sebagai bidan praktik di berbagai fasilitas kesehatan dasar, kemudian bergabung sebagai tenaga pengajar di institusi pendidikan kesehatan. Saat ini penulis menjabat sebagai Rektor sekaligus dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon, mengampu mata kuliah Kesehatan Reproduksi & Keluarga Berencana (Kespro & KB), Kesehatan Dasar Pada Kehamilan (KDPK), serta Asuhan Kebidanan Persalinan & Bayi Baru Lahir. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengamalan Al-Islam Kemuhammadiyahan. Penulis telah menghasilkan berbagai penelitian di bidang kesehatan reproduksi remaja dan anemia gizi besi, serta aktif melakukan pengabdian masyarakat melalui edukasi kesehatan di sekolah-sekolah dan komunitas. Selain itu, penulis rutin mempublikasikan karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi, serta menulis buku dan modul pembelajaran untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: srimusfiroh052@gmail.com. Motto: "Menjadi manusia yang berguna untuk orang lain"



Khusnul Nikmah, SST., M. Kes. Penulis lahir di Lamongan 08 Desember 1980 tinggal di Surabaya. Lulus D III Kebidanan YARSIS tahun 2006 yang sekarang menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA) kemudian melanjutkan kulia D IV Kebidanan di Universitas Kadiri lulus pada tahun 2008. Pada tahun 2015 melanjutkan kulia S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat di STIKes STRADA Kediri yang sekarang menjadi Universitas STRADA Indonesia (USI) lulus pada tahun 2017. Sejak lulus D III Kebidanan pada tahun 2006 penulis mengabdikan diri di Universitas Islam Lamongan. Pada tahun 2008 - 2014 menjabat sebagai Koordinator I di Program Studi Diploma III Kebidanan UNISLA. Pada tahun 2019 mencapai jabatan fungsional Asisten Ahli dan pada tahun 2023 jabatan fungsional Lektor. Bidang Keahlian mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia (KDM) dan Promosi Kesehatan. Penulis juga aktif dalam berbagai seminar maupun publikasi jurnal ilmiah Nasional.

PROFIL PENULIS



Nina Hidayatunnikmah, S.Keb., Bd., M.Kes., dilahirkan di Gresik pada bulan Januari Tahun 1992. Penulis menyelesaikan S1 Kebidanan pada tahun 2013, pada tahun 2015 penulis menyelesaikan Pendidikan Profesi Bidan di Universitas Brawijaya. Kemudian lanjut S2 di Universitas Airlangga mengambil Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Ibu dan Anak tahun 2015. Saat ini penulis menjadi seorang pengajar di Prodi Kebidanan Fakultas Sains Dan Kesehatan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Jawa timur Indonesia. Penulis pernah publikasi jurnal ilmiah nasional. Sekarang ini penulis aktif menulis buku bidang Kesehatan

Sinopsis

Buku ajar *Keterampilan Klinis Kebidanan: Pemeriksaan, Tindakan Dasar, dan KIE* disusun sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa kebidanan dalam memahami dan menguasai keterampilan klinis dasar yang diperlukan dalam pelayanan kebidanan. Buku ini menekankan pentingnya kemampuan melakukan pemeriksaan, tindakan dasar, komunikasi terapeutik, serta pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) secara aman, tepat, etis, dan berpusat pada kebutuhan pasien.

Pembahasan dalam buku ini diawali dengan konsep dasar keterampilan klinis kebidanan, meliputi prinsip keselamatan pasien, penggunaan alat pelindung diri (APD), serta pencegahan dan pengendalian infeksi dalam praktik pelayanan. Materi ini menjadi landasan penting agar setiap tindakan kebidanan dilakukan dengan memperhatikan keamanan pasien, tenaga kesehatan, serta lingkungan pelayanan.

Selanjutnya, buku ini membahas komunikasi terapeutik dan KIE dalam kebidanan, termasuk teknik wawancara, membangun empati, mendengarkan aktif, serta menyampaikan edukasi kesehatan secara efektif. Kemampuan komunikasi yang baik sangat diperlukan agar bidan mampu membina hubungan saling percaya dengan pasien, menggali informasi secara tepat, serta membantu pasien dan keluarga memahami kondisi maupun keputusan kesehatan yang perlu diambil.

Buku ini juga menguraikan pengkajian kebidanan terpadu yang mencakup anamnesis terfokus, pemeriksaan fisik, dan dokumentasi awal. Pembaca diarahkan untuk memahami proses pengumpulan data secara sistematis sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan, masalah, serta rencana asuhan kebidanan. Selain itu, buku ini membahas pemeriksaan tanda vital dan antropometri, mulai dari teknik pelaksanaan, interpretasi hasil, hingga kesalahan umum yang perlu dihindari dalam praktik klinis.

Melalui penyajian materi yang sistematis, buku ajar ini diharapkan dapat membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan klinis, ketelitian, kemampuan berpikir kritis, serta sikap profesional dalam memberikan pelayanan kebidanan. Buku ini juga dapat menjadi referensi bagi dosen dan praktisi dalam mendukung pembelajaran praktik yang aman, komunikatif, dan sesuai dengan standar pelayanan kebidanan.

Buku ajar Keterampilan Klinis Kebidanan: Pemeriksaan, Tindakan Dasar, dan KIE disusun sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa kebidanan dalam memahami dan menguasai keterampilan klinis dasar yang diperlukan dalam pelayanan kebidanan. Buku ini menekankan pentingnya kemampuan melakukan pemeriksaan, tindakan dasar, komunikasi terapeutik, serta pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) secara aman, tepat, etis, dan berpusat pada kebutuhan pasien.

Pembahasan dalam buku ini diawali dengan konsep dasar keterampilan klinis kebidanan, meliputi prinsip keselamatan pasien, penggunaan alat pelindung diri (APD), serta pencegahan dan pengendalian infeksi dalam praktik pelayanan. Materi ini menjadi landasan penting agar setiap tindakan kebidanan dilakukan dengan memperhatikan keamanan pasien, tenaga kesehatan, serta lingkungan pelayanan.

Selanjutnya, buku ini membahas komunikasi terapeutik dan KIE dalam kebidanan, termasuk teknik wawancara, membangun empati, mendengarkan aktif, serta menyampaikan edukasi kesehatan secara efektif. Kemampuan komunikasi yang baik sangat diperlukan agar bidan mampu membina hubungan saling percaya dengan pasien, menggali informasi secara tepat, serta membantu pasien dan keluarga memahami kondisi maupun keputusan kesehatan yang perlu diambil.

Buku ini juga menguraikan pengkajian kebidanan terpadu yang mencakup anamnesis terfokus, pemeriksaan fisik, dan dokumentasi awal. Pembaca diarahkan untuk memahami proses pengumpulan data secara sistematis sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan, masalah, serta rencana asuhan kebidanan. Selain itu, buku ini membahas pemeriksaan tanda vital dan antropometri, mulai dari teknik pelaksanaan, interpretasi hasil, hingga kesalahan umum yang perlu dihindari dalam praktik klinis.

Melalui penyajian materi yang sistematis, buku ajar ini diharapkan dapat membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan klinis, ketelitian, kemampuan berpikir kritis, serta sikap profesional dalam memberikan pelayanan kebidanan. Buku ini juga dapat menjadi referensi bagi dosen dan praktisi dalam mendukung pembelajaran praktik yang aman, komunikatif, dan sesuai dengan standar pelayanan kebidanan.

Penerbit:
PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005
Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7927-20-0 (PDF)
9 786347 927200